



SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR

Edición: Primera

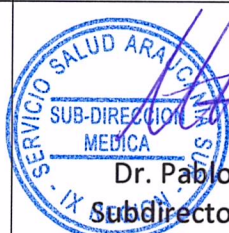
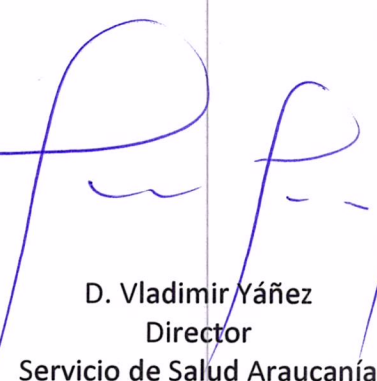
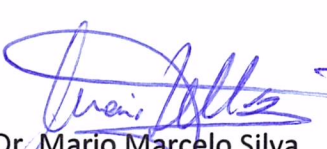
Fecha : mayo de 2024

Página 0 de 107

Vigencia: mayo de 2026

Orientaciones de Referencia Clínico Ambulatorio

Servicio de Salud Araucanía Sur

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Dra. Karina Gallegos L. Encargada Referencia – Contrarreferencia Servicio de Salud Araucanía Sur en conjunto con Médicos Especialistas y Referentes Médicos de la Red Servicio de Salud Araucanía Sur	 Dr. Pablo Valdés Subdirector Médico Servicio de Salud Araucanía Sur	 D. Vladimir Yáñez Director Servicio de Salud Araucanía Sur 
	 Dr. Mario Marcelo Silva Jefe Subdepartamento Apoyo clínico Servicio de Salud Araucanía Sur	
	 Dr. Iván Niesel Jefe Gestión Territorial Dpto. De Atención Primaria Servicio de Salud Araucanía Sur	

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 0 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

ORIENTACIONES DE REFERENCIA

CLÍNICO AMBULATORIO

SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR

2024

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 1 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

Agradecimientos

A Dra. Tamara Aliaga, quien participó en la coordinación y edición del documento.

A los Médicos Especialistas de la Red que apoyaron en conjunto con Gestores de Listas de Espera, Priorizadores de la Red, Referentes del Servicio de Salud Araucanía Sur, para la elaboración de las especificaciones de derivación según especialidades respectivas.

Entre ellos:

- Dr. Fernando Vega, broncopulmonar
- Dr. Gabriel Jano, Cardiología
- Dra. Natalia Retamales, Cardiología Infantil
- Dr. Herman Schneider, Nefrología adulto
- Dr. Luis Castillo, Nefrología adulto
- Dr. Cristian Gottschalk, Cirugía Cabeza y Cuello
- Dr. Mariano Flores, Cirugía Coloproctológica
- Dra. Verónica Fonseca, Cirugía de Tórax
- Dr. Luis Burgos, Cirugía Vascular
- Dr. Luis Arratia, Cirugía Vascular
- Dra. Claudia Nicklas, Dermatología
- Dr. Gastón Briceño, Dermatología
- Dra. Eugenia Ortiz, Endocrinología
- Dra. Roxana Gayoso, Endocrinología
- Dra. Tatiana Vásquez, Diabetología y Nutrición
- Dr. Fernando Gallardo, Ginecología
- Dr. Oscar Morales, Medicina Interna
- Dra. Angélica Becerra, Oftalmopediatría
- Dra. Celeste Fulgeri, Nefrología
- Dr. Eduardo Lobos, Oftalmología
- Dra. Loreto Nicklas, Otorrinolaringología
- Dr. Carlos Baumert, Reumatología
- Dra. Jahzeel Gacitúa, Nutriología pediátrica
- Dra. Sandra Venegas, Psiquiatría infantojuvenil
- Dr. Martin Zecher, Traumatología adulto
- Dr. Ramón Hernández, Traumatología adulto

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 2 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

- Dr. Pablo Muller, Traumatología Infantil
- Dr. Sebastián Urrutia, Urología
- Dra. Lorena Prado, Medicina Física y Rehabilitación
- Dr. Danilo Pérez, Medicina Interna
- Dra. Marina Leiva, Nefrología adulto
- Dra. Rossana Villalobos, Pediatría
- Dra. Marcela Molina, Endocrinología Infantil
- Dra. Carolina del Castillo, Neurología adulto
- Dr. Michael Soto, Pediatría
- Dra. Maite López, Psiquiatría Infantojuvenil
- Dr. Daniel Fodor, Traumatología adulto
- Dr. José Inzunza, Urología
- Dra. Alejandra Gómez
- Dra. Mariela Urrutia, Cirugía Digestiva Alta
- Dr. Carlos Baumert, Reumatología
- Dra. Carolina Paz, Geriatria.
- Dra. Paulina Troncoso, Ginecología
- Dr. Gustavo Kiekebusch, Ginecología
- Dr. Sebastián Martínez, Ginecología
- Dr. Fernando Abarzúa, Ginecología
- Dra. Pamela Caro, Pediatría
- Dr. Juan Andrés Navarro, Broncopulmonar infantil
- Dr. Andrés Troncoso, Cirugía Digestiva
- Dr. Héctor Losada, Cirugía Digestiva
- Dr. Claudio Nome, Urología Infantil
- Dra. Andrea González, Gastroenterología infantil
- María Rosa Fernández, Matrona Encargada ITS
- Dra. Marisa Capurro, Hematología Adulto
- Dra. Ana María Vinet, Inmunoreumatología infantil
- Dr. Alfonso Hernández, Inmunoreumatología infantil
- Dra. Patricia Mella, Nefrología Infantil
- Dr. Héctor Escalante, Neurocirugía
- Dr. Claudio parada, Neurocirugía
- Dr. Echeverría, Oftalmología Adulto

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 3 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

- Dr. Gianni Rivera, Neurología Infantil
- Marjorie Fuentes, Psicóloga, referente salud mental
- Dr. Arturo Beyer, Traumatología rodilla
- Dr. Claudio Parada, Neurocirugía
- Dra. Jacqueline Fierro, Gastroenterología infantil
- Dra. Roxana Sepúlveda, Medicina Familiar
- Dra. Camila Meier, Médico Cirujano, encargada Referencia HHA
- Dr. Joaquín Bernal, Cirugía Plástica.
- María Rosa Fernández, Matrona encargada del policlínico ITS, HHA
- Edelweis Valdebenito, Referente de Enfermedades Emergentes y Reemergentes, SSAS
- Víctor Carrasco, Referente técnico programa de Resolutividad en APS, SSAS.

Considerar además a muchos otros profesionales médicos y no médicos que apoyaron con la revisión y sugerencias para las orientaciones.

A todos Uds., muchas gracias por la dedicación y esfuerzo.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 4 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

Contenido

I. INTRODUCCIÓN	7
II. OBJETIVOS	8
III. ALCANCE	8
IV. RESPONSABLES	8
V. DEFINICIONES O GLOSARIO	9
VI. DESARROLLO	10
ORIENTACIONES DE REFERENCIA POLICLÍNICOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	10
POLICLÍNICO ADOLESCENCIA	10
ALTO RIESGO OBSTETRICO	11
ANESTESIA - DOLOR CRONICO	15
BRONCOPULMONAR ADULTO	15
BRONCOPULMONAR INFANTIL	18
CARDIOLOGÍA ADULTO	20
CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA	22
CIRUGÍA ADULTO	26
a. DIGESTIVO ALTO	26
b. HEPATOBILIO-PÁNCREAS.....	28
c. TÓRAX.....	30
d. Cirugía Plástica	31
CIRUGÍA – UROLOGÍA INFANTIL.....	32
DERMATOLOGÍA	34
ENDOCRINOLOGÍA ADULTO – DIABETES	40
ENDOCRINOLOGÍA INFANTIL (menores de 15 años)	42
GASTROENTEROLOGÍA ADULTO	46
GASTROENTEROLOGÍA INFANTIL – ALERGIA A LA PROTEÍN DE LECHE DE VACA	48
GERIATRÍA	50

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 5 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

GINECOLOGÍA	52
HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA ADULTO	53
HEMATO-ONCOLOGÍA INFANTIL.....	55
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, POLICLÍNICO (ITS)	58
INMUNO-REUMATOLOGÍA INFANTIL	59
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN – POLICLÍNICO DE AMPUTADOS.....	61
NEFROLOGÍA ADULTO	66
a)Derivar desde NODO por nefrólogo a Nefrología HHA	68
b)DERIVAR A URGENCIAS INMEDIATA, para hospitalización (con resolutiveidad nefrológica). 68	
NEFROLOGÍA INFANTIL.....	68
NEUROCIRUGÍA ADULTO	70
NEUROLOGÍA INFANTIL	73
NEUROCIRUGÍA PEDIÁTRICA	78
NEUROLOGÍA ADULTO	79
NUTRICIÓN INFANTIL	82
OFTALMOLOGÍA INFANTIL.....	85
POLICLINICO DE GÉNERO	87
OTORRINOLARINGOLOGÍA	88
PSIQUIATRÍA PEDIATRICA Y DE LA ADOLESCENCIA	89
REUMATOLOGÍA ADULTO	96
TRAUMATOLOGÍA ADULTO	96
a) HOMBRO	96
b) RODILLA.....	98
c) TUMORES.....	99
d) CADERA.....	100
e) PIE	100
f) MANO.....	101
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA INFANTIL	101

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 6 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

UROLOGÍA ADULTO.....	102
VII. CONSIDERARACIONES	106
VIII. DISTRIBUCIÓN	106
IX. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	106
X. CONTROL DE CAMBIOS.....	106
XI. DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS	106
XII. ANEXOS	107
ANEXO N° 1. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO EN APS DE PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA, QUE NO CUMPLEN CRITERIOS DE DERIVACIÓN A HHA.....	108
○ FIGURA 1. ALGORITMO TRATAMIENTO TAQUIARRITMIAS	109
○ FIGURA 2 . ALGORITMO SOPLOS EN PEDIATRÍA.....	110
MINISTERIO DE SALUD. Guía Clínica CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS OPERABLES EN MENORES DE 15 AÑOS. SANTIAGO: MINSAL, 2010)	110
ANEXO N°2. SOPLO FUNCIONAL O INOCENTE, información para padres y pacientes.....	111
ANEXO N° 3. Documento para registro de frecuencia cardiaca	112
ANEXO 4. Síncope Neuromediado. Información para padres y pacientes.....	113
ANEXO N° 5. Ficha de ITS y Consentimiento informado para registro de imágenes.	114
ANEXO N° 6: Manejo de Nódulo Tiroideo.....	118
ANEXO N°7: Criterios Diagnósticos de Fibromialgia.	121
ANEXO N° 8: Flujograma de derivación del niño con epilepsia.....	124
ANEXO N° 9: Flujograma CEFALÉAS.....	127
ANEXO N° 10: ESCALAS DE RIESGO TROMBOEMBÓLICO Y DE RIESGO DE SANGRADO	130
Anexo N ° 11 Índice de Barthel.	133
Anexo N° 12: Formulario derivación Geriátrica, Hospital Digital.....	134

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 7 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

I. INTRODUCCIÓN

Las orientaciones de referencia Clínico Ambulatorio del Servicio de Salud Araucanía Sur surgen tras la necesidad de estandarizar criterios al momento de derivar un usuario a especialista, logrando una adecuada comunicación entre profesionales médicos y, junto con ello, una adecuada pertinencia de la derivación.

Este documento aporta mayores herramientas a todos los profesionales médicos para decidir cuándo y dónde derivar, qué estudios corresponde desarrollar según cartera de prestaciones existentes y entregar, en algunos casos, recomendaciones de manejo y guías clínicas/documentos de apoyo. Las patologías incorporadas corresponden en su mayoría a los diagnósticos más frecuentemente derivados a cada especialidad presentada. Se incorporaron aquellas especialidades que se pudieron sumar a esta estrategia, no siendo una limitación a futuro el incorporar más especialidades y diagnósticos.

Siendo el Servicio de Salud Araucanía Sur el que la fecha posee la lista de espera consulta nueva de especialidad más importante a nivel Nacional, debemos seguir avanzando en estrategias que nos permitan mejorar la comunicación y optimizar nuestros recursos, en particular, las horas de profesionales médicos en todos los niveles de atención.

Este documento es resultado de un trabajo desarrollado por años, iniciado por profesionales médicos desde el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, complementado posteriormente por profesionales médicos y referentes de la Red del Servicio de Salud Araucanía Sur, participando también profesionales de atención primaria, hospitales nodo y alta complejidad, siendo una clara muestra de los resultados que se pueden obtener al coordinarse y trabajar en red.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 8 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

II. OBJETIVOS

- Estandarizar en la práctica clínica los criterios de derivación a especialista y pertinencia dentro de la Red dependiente del Servicio de Salud Araucanía Sur
- Optimizar los recursos existentes en relación a horas de especialista, confirmando la adecuada pertinencia de las consultas nuevas derivadas.
- Intencionar una adecuada preparación de los pacientes que son derivados para atención por especialista, logrando una mayor resolutiveidad tras la primera atención.

III. ALCANCE

Estas orientaciones deberán ser consideradas como guía para la correcta derivación de pacientes, que se origina tanto desde centros de Atención Primaria, como derivaciones intra y/o interhospitalarias para atención ambulatoria electiva de especialidad.

Por lo anterior estas orientaciones se encuentran dirigidas principalmente a:

- Médicas (os) de la red del Servicio de Salud Araucanía Sur que realizan interconsultas a especialidad desde los distintos Centros de Salud respetando la Red de Derivación.
- Médicos Contralores y Priorizadores, para apoyar el proceso de validación y priorización de interconsultas.
- Especialistas médicos, cuyo registro de pertinencia de las derivaciones de consulta nueva recepcionadas debiera coincidir con las definiciones expuestas en este documento.

IV. RESPONSABLES

- Responsable de la difusión y evaluación de correcto uso: Directores y Subdirectores Médicos de los establecimientos de Salud que se asocian al Servicio de Salud Araucanía Sur.
- Responsable operativo de la correcta aplicación de las orientaciones de referencia: Médicos que desarrollan funciones en Centros de Salud asociados al Servicio de Salud.
- Responsable de su actualización: Médica (o) encargada del proceso de Referencia - Contrarreferencia, dependiente del Servicio de Salud Araucanía Sur.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 9 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

V. DEFINICIONES O GLOSARIO

- APS: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
- FUR: FECHA DE ÚLTIMA REGLA
- EG: EDAD GESTACIONAL
- ARO: ALTO RIESGO OBSTÉTRICO
- PTGO: PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA ORAL
- HBA1C: HEMOGLOBINA GLICOSILADA
- AAS: ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
- GEG: GRANDE PARA EDAD GESTACIONAL
- RCIU: RESTRICCIÓN CRECIMIENTO INTRAUTERINO
- OA: ORDEN DE ATENCIÓN (SOLICITUD DE ECOGRAFÍA ARO)
- RNPT: RECIÉN NACIDO PREMATURO
- DDS: DESORDEN DEL DESARROLLO SEXUAL
- ITS: INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 10 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

VI. DESARROLLO

ORIENTACIONES DE REFERENCIA POLICLÍNICOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

POLICLÍNICO ADOLESCENCIA

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN CDT HHA	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES
TRASTORNO DE CONDUCTA ALIMENTARIA	10-19 años Adolescente cursando o con sospecha de presentar algún Trastorno Alimentario y de Ingesta (TAI) de acuerdo con DSM-V (Anorexia, Bulimia, Trastorno por Atracón, etc.)	No requiere	Derivación por médico psiquiatra, nutrióloga, pediatra, ginecóloga infanto juvenil
ADOLESCENTE CON PATOLOGÍA CRÓNICA	12-19 años Adolescente en control en policlínico de subespecialidad de pediatría por patología crónica, para apoyar adherencia a tratamiento y proceso de Transición	No requiere	Derivación desde policlínicos de subespecialidad de pediatría (CDT)

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 11 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

ALTO RIESGO OBSTETRICO

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
DIABETES GESTACIONAL	<u>PRIMER TRIMESTRE:</u> 2 GLICEMIAS AYUNAS $\geq$ 100 mg/dL <u>ó</u> <u>SEGUNDO TRIMESTRE:</u> PTGO $\geq$ 140 mg/dl	GLICEMIAS ó PTGO INTERCONSULTA A POLICLÍNICO DE ARO DEBE CONTENER 1. FUR PACIENTE (OPERACIONAL SI TIENE) 2. FÓRMULA OBSTÉTRICA (INCLUIR VÍA DE PARTO Y EG AL PARTO) 3. EDAD GESTACIONAL ACTUAL 4. PATOLOGÍA POR LA CUAL SE DERIVA 5. RESULTADO DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS A LA PATOLOGÍA 6. OTRAS COMORBILIDADES	EDUCACIÓN EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN APS
DIABETES PREGESTACIONAL	AL PRIMER CONTROL PRENATAL	HBA1C PROTEINURIA 24 HRS INTERCONSULTA A POLICLÍNICO DE ARO DEBE CONTENER 1. FUR PACIENTE (OPERACIONAL SI TIENE) 2. FÓRMULA OBSTÉTRICA (INCLUIR VÍA DE PARTO Y EG AL PARTO) 3. EDAD GESTACIONAL ACTUAL 4. PATOLOGÍA POR LA CUAL SE DERIVA 5. RESULTADO DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS A LA PATOLOGÍA	DERIVAR ADEMÁS A DIABETOLOGÍA HHA DESDE APS INICIAR AAS 150 MG POR NOCHE <16 SEMANAS

		6. OTRAS COMORBILIDADES INTERCONSULTA A POLICLÍNICO DE ARO DEBE CONTENER 1. FUR PACIENTE (OPERACIONAL SI TIENE) 2. FÓRMULA OBSTÉTRICA (INCLUIR VÍA DE PARTO Y EG AL PARTO) 3. EDAD GESTACIONAL ACTUAL 4. PATOLOGÍA POR LA CUAL SE DERIVA 5. RESULTADO DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS A LA PATOLOGÍA 6. OTRAS COMORBILIDADES	SOLICITAR PRIORIDAD EN ECOGRAFÍA 11-14 /22-24 INTERCONSULTA A POLICLÍNICO DE ARO DEBE CONTENER 1. FUR PACIENTE (OPERACIONAL SI TIENE) 2. FÓRMULA OBSTÉTRICA (INCLUIR VÍA DE PARTO Y EG AL PARTO) 3. EDAD GESTACIONAL ACTUAL 4. PATOLOGÍA POR LA CUAL SE DERIVA 5. RESULTADO DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS A LA PATOLOGÍA 6. OTRAS COMORBILIDADES
HIPERTENSIÓN ARTERIAL	ANTECEDENTE PREVIO A EMBARAZO 2 PRESIONES ARTERIALES $\geq 140/90$ mmHg ≤ 20 SEMANAS	HEMOGRAMA PROTEINURIA 24 HRS CREATININA PRUEBAS HEPÁTICAS ECG INTERCONSULTA A POLICLÍNICO DE ARO DEBE CONTENER 1. FUR PACIENTE (OPERACIONAL SI TIENE) 2. FÓRMULA OBSTÉTRICA (INCLUIR VÍA DE PARTO Y EG AL PARTO) 3. EDAD GESTACIONAL ACTUAL 4. PATOLOGÍA POR LA CUAL SE DERIVA	SUSPENDER ANTIHIPERTENSIVOS PREVIOS. USAR DE PREFERENCIA ANTAGONISTAS CANALES DE CALCIO COMO NIFEDIPINO O AMLODIPINO, COMO SEGUNDA OPCIÓN METILDOPA PARA LOGRAR PRESIONES NORMALES.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 13 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

		5. RESULTADO DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS A LA PATOLOGÍA 6. OTRAS COMORBILIDADES	HTA crónica si previo a embarazo no usaba fármacos y en control prenatal tiene PA mayores de 130/80, debería iniciar farmacoterapia AAS 150 MG POR NOCHE SI <16 SEMANAS
ANTECEDENTE PREECLAMPSIA - HELLP - ECLAMPSIA	DERIVAR AL INICIO DE CONTROL PRENATAL	DETALLE DE EMBARAZOS PREVIOS INTERCONSULTA A POLICLÍNICO DE ARO DEBE CONTENER 1. FUR PACIENTE (OPERACIONAL SI TIENE) 2. FÓRMULA OBSTÉTRICA (INCLUIR VÍA DE PARTO Y EG AL PARTO) 3. EDAD GESTACIONAL ACTUAL 4. PATOLOGÍA POR LA CUAL SE DERIVA 5. RESULTADO DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS A LA PATOLOGÍA 6. OTRAS COMORBILIDADES	INICIAR AAS 150 MG POR NOCHE <16 SEMANAS
SÍNDROME HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO	2 PRESIONES ARTERIALES $\geq 140/90$ mmHg ≥ 20 SEMANAS	NINGUNO INTERCONSULTA A POLICLÍNICO DE ARO DEBE CONTENER 1. FUR PACIENTE (OPERACIONAL SI TIENE) 2. FÓRMULA OBSTÉTRICA (INCLUIR VÍA DE PARTO Y EG AL PARTO)	DERIVACIÓN A SERVICIO DE URGENCIA OBSTÉTRICA

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 14 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

		3. EDAD GESTACIONAL ACTUAL 4. PATOLOGÍA POR LA CUAL SE DERIVA 5. RESULTADO DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS A LA PATOLOGÍA 6. OTRAS COMORBILIDADES	
CICATRIZ DE CESÁREA	DERIVAR A LAS 36 SEMANAS	ECOGRAFÍA (UBICACIÓN PLACENTARIA) INTERCONSULTA A POLICLÍNICO DE ARO DEBE CONTENER 1. FUR PACIENTE (OPERACIONAL SI TIENE) 2. FÓRMULA OBSTÉTRICA (INCLUIR VÍA DE PARTO Y EG AL PARTO) 3. EDAD GESTACIONAL ACTUAL 4. PATOLOGÍA POR LA CUAL SE DERIVA 5. RESULTADO DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS A LA PATOLOGÍA 6. OTRAS COMORBILIDADES	CONTROL HABITUAL
PARTO PREMATURO	ANTECEDENTE DE PREMATUREZ O RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA <36 SEMANAS. HISTORIA DE INCOMPETENCIA CERVICAL O USO DE CERCLAJE EN EMBARAZO ANTERIOR	DETALLE DE PARTOS PREVIOS (EG - CERCLAJE) INTERCONSULTA A POLICLÍNICO DE ARO DEBE CONTENER 1. FUR PACIENTE (OPERACIONAL SI TIENE) 2. FÓRMULA OBSTÉTRICA (INCLUIR VÍA DE PARTO Y EG AL PARTO) 3. EDAD GESTACIONAL ACTUAL 4. PATOLOGÍA POR LA CUAL SE DERIVA 5. RESULTADO DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS A LA PATOLOGÍA 6. OTRAS COMORBILIDADES	INICIAR PROGESTERONA MICRONIZADA 200 MG VÍA VAGINAL EN SEGUNDO TRIMESTRE.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 15 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

EMBARAZO GEMELAR	AL DIAGNÓSTICO	ECOGRAFÍA REALIZADA	DERIVAR A POLICLÍNICO DE ECOGRAFÍA (OA) POLICLÍNICO DE ARO SERÁ ASIGNADO POR ESPECIALISTA SEGÚN HALLAZGOS
------------------	----------------	---------------------	--

ANESTESIA - DOLOR CRONICO

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
Dolor crónico no oncológico	- EVA ≥ 5 a pesar de tratamiento en 3er escalón según OMS *Flujo de derivación: APS $\rightarrow$ Fisiatría $\rightarrow$ Dolor crónico (anestesia)	Exámenes realizados en los últimos 15 días: - Hemograma - Pruebas de coagulación	
Dolor crónico oncológico	- EVA ≥ 5 a pesar de tratamiento en 3er escalón según OMS *Flujo de derivación: APS $\rightarrow$ Unidad de Cuidados Paliativos de hospitales nodo $\rightarrow$ Dolor crónico (Anestesia)		

BRONCOPULMONAR ADULTO

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
SAHOS	Derivar con sospecha clínica	- Hemograma, exámenes generales, pruebas tiroideas. - Radiografía de tórax PA-L - Cuestionarios Epworth - Stop Bang	- Interconsulta con datos completos - Sin disponibilidad de estudio de la patología en la red - Gestionar Poligrafía o Polisomnografía en lugar de origen por Med. Interna (Hospital nodo)

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 16 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

		- Circunferencia cervical	
ASMA	Asma refractaria a tratamiento con buena adherencia y dosis altas de corticoides inhalados *Flujo de derivación: APS → Med. Interna → Broncopulmonar	- Espirometría Basal y post broncodilatador - Hemograma, IgE total - Radiografía de tórax PA- L o TAC de Tórax sin contraste fase en inspiración y espiración SEGÚN CARTERA DE PRESTACIONES	- Interconsulta con datos completos - Evaluar técnica inhalatoria, adherencia y diagnósticos alternativos - Al momento de la consulta deben traer inhaladores y aerocámara
HEMOPTISIS	Paciente con clínica de hemoptisis. *Flujo de derivación: APS → Med. Interna → Broncopulmonar. Según gravedad considerar derivación a Urgencia.	- Exámenes generales (+ orina) - Estudio TBC - Radiografía tórax o AngioTAC de tórax con protocolo de Aorta según disponibilidad.	- Interconsulta con datos completos - Según gravedad, debiese ser derivado a Servicio de Urgencia
DERRAME PLEURAL	Derivación desde APS a Med. Interna: Primer episodio de Derrame pleural. Evaluar derivación a urgencia según gravedad ó sospecha de empiema.	- Ex. Generales: Hemograma, VHS, PCR, Perfil bioquímico, Perfil lipídico, Ex. De orina, Albuminemia - Rx Tórax AP y Lat.	
	Derivación desde Med. Interna a Broncopulmonar: EXUDADO PLEURAL: sin diagnóstico luego de estudios básicos (estudio de líquido: citoquímico, citológico, cultivo, ADA, GeneXpert TB)	-Examen líquido pleural: Citoquímico, citológico, LDH, ph, cultivo. -Exámenes generales. -TAC Tórax post toracocentesis.	Interconsulta con datos completos
TOS CRÓNICA	Tos de más de 2 meses de evolución, habiendo descartado causas infecciosas que	-Espirometría Basal y Post BD -Rx de Tórax ó Scanner de Tórax y Cavidades paranasales sin	- Interconsulta con datos completos

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 17 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	incluyen TBC y crónicas como Asma, EPOC, secuelas de TBC, RGE y Bronquiectasias *Flujo de derivación: APS → Med. Interna → Broncopulmonar	contraste, según cartera de prestaciones	
EPOC	EPOC GOLD C o D Con buena adherencia a tratamiento y con exacerbaciones *Flujo de derivación: APS → Med. Interna → Broncopulmonar	- Hemograma - Perfil Bioquímico - Espirometría Basal y post BD Test de Marcha de 6 Minutos	- Revisión de Técnica Inhalatoria - Incentivar cese de tabaquismo si corresponde - Traer Inhaladores y aerocámara
Enfermedad Pulmonar difusa	Sospecha de enfermedad pulmonar difusa *Flujo de derivación: APS → Med. Interna → Broncopulmonar	- Hgma, VHS, PCR, glicemia, función renal y hepática. - Exámenes Inmunológicos (ANA, ENA, FR, AntiCCP) según cartera de prestaciones - TAC de Tórax sin contraste de alta resolución (Gestión por Med. Interna) - Espirometría basal y post broncodilatador	Ante la sospecha Derivar Si además hay sospecha de Enfermedad de tejido conectivo derivar a Reumatología
Nódulos Pulmonares	Hallazgo de nódulo (s) pulmonar (es) en TAC de Tórax, que no corresponda a sospecha de Cáncer pulmonar según norma técnica Médico Administrativa (GES)	- Hgma, VHS, PCR, glicemia, función renal y hepática. - TAC de Tórax sin contraste (Gestión por Med. Interna)	- Interconsulta con datos clínicos completos Guía de práctica clínica Cáncer de pulmón 2018: https://diprece.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/05/RE_GPC-C%C3%A1ncer-de-Pulm%C3%B3n_2018.pdf
Bronquiectasias	Paciente con diagnóstico de Bronquiectasias que a pesar de	- Hgma, VHS, PCR, glicemia, función renal y hepática. - Estudio TBC	- Interconsulta con datos completos

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 18 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	tratamiento persistan sintomáticos y/o complicaciones *Flujo de derivación: APS → Med. Interna → Broncopulmonar	- Espirometría Basal y post BD - Cultivo corriente expectoración - TAC Tórax sin contraste según cartera de prestaciones	
SOSPECHA DE TBC PULMONAR (QUE NO SE LOGRA CONFIRMAR EN APS)	Antecedentes clínicos más imágenes que permiten sospechar patología pero no su confirmación *Flujo de derivación: APS → Broncopulmonar adulto (policlínico tuberculosis) sumado a correo electrónico a equipo gestor tbc.hhha@asur.cl	- Hgma, VHS, PCR, glicemia, función renal y hepática. - Muestra bacteriológica (PCR) / BK (aunque sea negativa) - Rx. de Tórax	Casos confirmados de TBC, deben ser manejados en APS. *Norma Técnica para el control y la eliminación de la tuberculosis, año 2022

BRONCOPULMONAR INFANTIL

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
SBOR/ ASMA MENOR 15 AÑOS	1. SBO-R que NO responde a tratamiento habitual 2. ASMA: - Sospecha de Asma del lactante - Asma bronquial moderada a severa en menores de 15 años. *Flujo de derivación: APS → Pediatría → Broncopulmonar infantil	1. Radiografía de tórax 2. Espirometría si paciente colabora.	<u>VALORAR:</u> - Técnica uso de aerocámara - Indicaciones - Control ambiental

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 19 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

NEUMONIAS BACTERIANAS RECURRENTES	Pacientes con historia clínica de neumonía bacteriana 2 o más episodios en 1 año o más de 3 en cualquier tiempo, documentada con Rx. de tórax. *Flujo de derivación: APS → Pediatría →Broncopulmonar infantil	1. Rx de Tórax 1. Hemograma. 2. Deseable IGs GAME (para gestión en Hosp. Nodo)	
FIBROSIS QUÍSTICA	Todo paciente en el que se sospeche Fibrosis Quística *Flujo de derivación: APS → Pediatría →Broncopulmonar infantil	1. Radiografía de tórax	
DAÑO PULMONAR CRÓNICO	Pacientes con historia clínica compatible e imágenes persistentes en RX de Tórax. *Flujo de derivación: APS → Pediatría →Broncopulmonar infantil	1. Radiografía de Tórax	
DISPLASIA BRONCOULMONAR	Todo recién nacido prematuro (RNPT), con antecedente de Displasia Broncopulmonar *Flujo de derivación: APS → Pediatría →Broncopulmonar infantil		Verificar que RNPT se encuentre en control policlínico de seguimiento. Si esta en control y tiene antecedente de DBP, es posible que esté programado control con Broncopulmonar y no haya asistido a control.
TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO	Historia sugerente (roncador nocturno, apnea del sueño)		
SOSPECHA DE TBC PULMONAR (QUE NO SE LOGRA CONFIRMAR EN APS)	Antecedentes clínicos más imágenes que permiten sospechar patología pero no su confirmación *Flujo de derivación: APS →Broncopulmonar infantil sumado a respaldo vía correo electrónico a equipo gestor tbc.hhha@asur.cl .	- Hgma, fx hepática, fx renal - Muestra bacteriológica (PCR) / BK (aunque sea negativa) -Rx. de Tórax	Casos confirmados de TBC, deben ser manejados en APS. *Norma Técnica para el control y la eliminación de la tuberculosis, año 2022

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 20 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

CARDIOLOGÍA ADULTO

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
ARRITMIAS CARDÍACAS	- Arritmias ventriculares o supraventriculares sintomáticas. Incluye TPSV, WPW, ACxFA - Bradiarritmias sintomáticas. Bloqueo A-V o intraventriculares de alto grado. *Flujo de derivación: APS → Med. Interna → Cardiología	- ECG diagnostico <u>Exámenes laboratorio:</u> glicemia, función renal, ELP, TSH y T4L, perfil lipídico	Considerar derivaciones activando GES según corresponda. https://auge.minsal.cl/problemasdesalud/index/25 Inicio de tratamiento anticoagulante, ver en Patología, “Tratamiento anticoagulante”, guía N°7 SSAS: Tratamiento con anticoagulantes orales.
INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA	• ICC aguda descompensada (según gravedad considerar derivación vía urgencia). • ICC CF 3 o 4 con disfunción sistólica o diastólica. *Flujo de derivación: APS → Med. Interna → Cardiología	• ECG • <u>Exámenes laboratorio:</u> Hgma, glicemia, función renal, ELP, TSH y T4L, perfil lipídico *Pro BNP de ser factible	-
CARDIOPATÍA CORONARIA - ANGINA	• Antecedente de IAM, pasado período agudo • Ángor crónico estable de baja capacidad funcional. *Flujo de derivación: APS → Med. Interna → Cardiología	• ECG <u>Exámenes laboratorio:</u> Hgma, glicemia, función renal, ELP, perfil lipídico • Antecedentes clínicos u hospitalización	-

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 21 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

SÍNCOPE CARDIOGÉNICO	Asociado a síntomas de alarma: - Sin pródromos - Asociado a ejercicio - Antecedente personal de cardiopatía, arritmias. - Antecedente familiar 1° de Muerte súbita, PCR recuperado, DAI o MCP. -ECG alterado *Flujo de derivación: APS → Med. Interna → Cardiología	-Ex laboratorio: Hgma, glicemia, función renal, ELP, TSH y T4L, perfil lipídico -Radiografía de tórax -EKG	
SOPLO CARDÍACO	Derivar ambulatorio -Asociado a antecedente de familiar de 1° con Miocardiopatía, MS. -Genopatía asociada -Asociado a alteraciones del EKG o de RX de Tórax *Flujo de derivación: APS → Med. Interna → Cardiología	- Radiografía de tórax -EKG -Ex laboratorio: Hgma, glicemia, función renal, ELP, TSH y T4L, perfil lipídico	Soplo patológico: Holosistólico, diastólico, continuo, con frémito.
TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE	Criterios para pacientes con indicación de TACO: A1.- Trombosis Venosa Profunda, Tromboembolismo Pulmonar. A2.- Fibrilación Auricular, Arritmia Completa por Fibrilación Auricular (según escala CHA2DS2- VASc) (anexo 10) y Flutter sin embolia sistémica, (prevención isquemia). A3.- Accidente vascular embólico con fibrilación auricular. A4.- Fibrilación Auricular Paroxística y Flutter auricular con indicación de Cardioversión (Control Ritmo). A5.- Fibrilación Auricular con Valvulopatías.	1. Formulario de ingreso a tratamiento anticoagulante y Consentimiento informado (ANEXO 10) 2. Epicrisis, DAU o resumen de historia clínica 3. Exámenes: - Hemograma - INR capilar - Función renal	Guía N°7 SSAS: Tratamiento con anticoagulantes orales. Derivaciones desde Hospitales familiares y comunitarios debe realizarse IC asincrónica a Telemedicina Cardiología Hospital Lautaro (informar tras generación de interconsulta a referente TACO de SSAS para asegurar agendamiento). *Contraindicaciones para inicio de terapia: -Has-Bled >= 3 puntos (ANEXO 10). - Antecedentes de sangramiento digestivo menor a 3 meses. -Aneurisma cerebral.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 22 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	A6.- Prótesis valvular mecánica Mitral, Prótesis valvular mecánica Aórtica y Prótesis valvular mecánica Tricuspídea. A7.- Prótesis valvulares Biológicas. A8.- Trombo Intracavitario, Infarto cardiaco extenso de pared anterior con diskinesia o akinesia del ápex. A9.- Hipertensión Pulmonar (tipo IV), Miocardiopatía Dilatada con fracción de eyección < a 35% (alto riesgo de trombosis) y Trombofilias. Derivar al Hospital más cercano a policlínico de Anticoagulante con formularios e indicaciones correspondientes para inicio de terapia.		-Antecedentes de hemorragia intracraneal. -Hepatopatías y nefropatías graves, (considerar esta última para tratamiento con nuevos anticoagulantes orales). -Primer trimestre de embarazo. -Anemia importante: Hb < 8 gr/dl. -Falta de cooperación del paciente e imposibilidad para cumplir el tratamiento.
--	--	--	---

CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN. <u>SOLO SI</u>	REQUISITOS QUE <u>DEBEN</u> INCLUIRSE EN LA INTERCONSULTS	OBSERVACIONES/SUGERENCIAS MANEJO APS
ARRITMIAS	Luego de anamnesis, ex físico, ECG y Rx de tórax tienen diagnóstico: 1. GES: TSV, BAVC y presencia de ritmos ventriculares.	- Antecedentes personales y familiares (+). -Detalle de síntomas y signos relevantes. -Registro de FC,	1.GES: Notificar y generar interconsulta Cardiología HHHA (adjuntar ECG) 2.NO GES: Debe ser evaluado por Pediatra de su nodo para completar estudio. Ver Figura 1: Taquiarritmias en

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 23 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	NO GES: Sospecha TSV, palpitaciones asociadas a síncope, soplo patológico, alteración de ECG, o antecedentes familiares 1° de muerte súbita, PCR recuperado, miocardiopatía, canalopatía o QT largo.	Sat O2, PA. - ECG basal (todos los pacientes). -Rx de tórax.	pediatría Ver Anexo 1 DIAGNÓSTICOS DIFERENTES A LOS DESCRITOS SERÁN DEVUELTOS AL ORIGEN.
CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS	GES: Sospecha de cardiopatías Congénitas Operables en < de 15 años: 1. Cianosis central 2. Insuficiencia cardíaca congestiva 3. Alteración de pulsos periféricos 4. Soplo patológico en < 3 meses	-Antecedentes personales y familiares (+). -Detalle de síntomas y signos relevantes. -Registro de FC, Sat O2, PA 4 extremidades. -ECG basal (todos los pacientes). -Rx de tórax.	GES: Notificar y generar interconsulta Cardiología HHA (adjuntar ECG Y Rx de tórax)
CIANOSIS CENTRAL	GES: Si Sospecha fundada de cardiopatía congénita cianótica. DESCARTAR: -Infecciones -Hipoglicemia -Acidosis metabólica -Patología pulmonar -Factores predisponentes para hipertensión pulmonar.	- Antecedentes personales y familiares (+). -Detalle de síntomas y signos relevantes. -Registro de FC, Sat O2 y PA 4 exttemidades. -ECG basal (todos los pacientes). -Rx de tórax.	GES: Hospitalizar, administrar O2, descartar otras causas. Notificar y Derivar HHA. NO DERIVAR PACIENTES CON CIANOSIS PERIFÉRICA, O SOSPECHA DE CIANOSIS SIN SATURACIÓN DE OXÍGENO REGISTRADA.
INSUFICIENCIA CARDÍACA	GES: Todo paciente con diagnóstico o	- Antecedentes personales y familiares (+).	GES: Hospitalizar, estabilización HD, Notificar y derivar HHA

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 24 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	sospecha de IC.	-Detalle de síntomas y signos relevantes. -Registro de FC, Sat O2, PA 4 extremidades. -ECG basal (todos los pacientes). -Rx de tórax.	
SOPLO CARDÍACO	1. GES si soplo asociado a: - Cianosis central - Insuficiencia cardíaca - Disminución de pulsos periféricos. - Soplo patológico en menores de 3 meses. (Holosistólico, diastólico, continuo, con frémito) 2. NO GES si: - Antec. Prenatal cardiopatía no ductus dependiente. - Soplo patológico en > 3 meses sin otros hallazgos patológicos. - Asociado a antecedente familiar de primer grado con Miocardiopatía, MS, PCR recuperado. - Genopatía con riesgo de CC. - ECG o Rx de tórax alterada.	- Antecedentes personales y familiares (+). -Detalle de síntomas y signos relevantes. -Registro de FC, Sat O2, PA 4 extremidades -ECG basal (todos los pacientes). -Rx de tórax.	1. GES: Notificar y Derivar CDT HHA (adjuntar ECG) 2. NO GES: Debe ser evaluado por Pediatra de su nodo para completar estudio y eventual derivación a Cardiología HHA. NO DERIVAR: SOPLO NO PATOLÓGICO CON PACIENTE ASINTOMÁTICO, RESTO DEL EXAMEN NORMAL, HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL BENIGNA. ECG Y RX DE TORAX NORMAL Ver Anexo 1 y fig 2.
	NO GES: Derivar si sospecha causa cardíaca: - Sin pródromos.	Antecedentes personales y	NO GES: Debe ser evaluado por Pediatra de su nodo para completar estudio y eventual

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 25 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

SÍNCOPE	- Asociado a ejercicio. - En posición supina. - Precedido de dolor precordial o palpitaciones. - Antecedente personal de cardiopatía, arritmias. - Antecedentes familiares de primer grado de Muerte súbita, PCR recuperado, DAI, miocardiopatía. - ECG alterado	familiares (+) Detalle de síntomas y signos relevantes. Registro de FC, Sat O2 4 extremidades, PA. ECG basal (todos los pacientes) Rx de tórax	derivación a Cardiología HHA NO DERIVAR SÍNCOPE NEUROMEDIADO Ver Anexo 1 Ver Anexo 3: Síncope, información para padres y pacientes
DOLOR PRECORDIAL	NO GES: Derivar si sospecha causa cardíaca: - Asociado a ejercicio, opresivo. - Antecedente personal de cardiopatía, arritmias. - Asociado a síncope, palpitaciones o soplo patológico. - Antecedente familiar primer grado de MS, miocardiopatía, IAM < de 50 años - ECG o enzimas cardíacas alteradas.	Antecedentes personales y familiares (+) Detalle de síntomas y signos relevantes. Registro de FC, Sat O2 4 extremidades, PA. ECG basal (todos los pacientes) Rx de tórax	NO GES: Debe ser evaluado por Pediatra de su nodo para completar estudio y eventual derivación a Cardiología HHA Ver Anexo 1

TSV: Taquicardia Supraventricular. BAVC: Bloqueo AV completo. PA: Presión arterial. MS: muerte súbita. CC: Cardiopatía Congénita. PCR: Paro cardiorespiratorio. DAI: Desfibrilador automático implantable

De ser necesario, se puede contactar al equipo de Cardiología Infantil HHA a través de correo electrónico cardiopedtemuco@gmail.com

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 26 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

CIRUGÍA ADULTO

a. DIGESTIVO ALTO

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
CÁNCER GÁSTRICO	SINTOMAS: Síndrome Consuntivo, epigastralgia, hemorragia digestiva alta, tumor palpable y metástasis evidentes, como la adenopatía supraclavicular izquierda (Nódulo de Virchow), adenopatía umbilical (nódulo de la Hermana María José), PREVENCIÓN SECUNDARIA: Detección precoz y tratamiento de la enfermedad. PREVENCIÓN Terciaria: Tratamiento, rehabilitación y paliación para mejorar el pronóstico de los pacientes con cáncer gástrico.	Endoscopia digestiva alta (EDA): todo paciente con epigastralgia > 2 semanas tiene indicación de EDA. TC tórax abdomen y pelvis con contraste. Según disponibilidad.	PREVENCIÓN PRIMARIA: 1) erradicación de la infección por H. pylori (Gestión a través de programa de resolutiveidad para la atención primaria) 2) eliminar el cigarrillo 3) cambiar el hábito en la comida. *GES. Las garantías de oportunidad determinan que la evaluación por especialista será en un plazo no mayor a 30 días desde la sospecha, la confirmación diagnóstica (incluye etapificación) dentro de 30 días desde solicitud por especialista y que el tratamiento tendrá lugar dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.
CIRUGÍA BARIÁTRICA	-IMC > a 40 kg/m² -IMC > a 35 kg/m², pero con comorbilidades asociadas a la obesidad	- Ex generales que incluyan glicemia, función renal, función hepática, pruebas	NO DERIVAR EN CASO DE: abuso de drogas y alcohol, patología psiquiátrica no controlada o descompensada.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 27 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	- Baja del 10% de su peso previo derivación Seguimiento de al menos <u>1 año antes de derivar:</u> - Control por psicología o psiquiatría según corresponda, con informe de adherencia y potencial capacidad de adecuarse al cambio de estilo de vida que requiere esta cirugía, de por vida. - Control con Nutrición, con informe de adherencia a terapia nutricional de al menos 1 año. Se indica baja de peso de 10% de peso previo derivación e ingreso al programa. - Control con Kinesiología para acondicionamiento físico. - Controles por Médico, quien indica ingreso a protocolo y confirme adecuada adherencia a evaluaciones e indicaciones indicadas previamente. - Controles por especialista o subespecialista para manejo y compensación comorbilidades asociadas a cada paciente. Derivar con informes.	tiroideas, perfil lipídico - * Evaluación preoperatoria	La derivación deberá realizarse sólo una vez que se hayan realizado las evaluaciones y controles multidisciplinarias, confirmando buena adherencia a indicaciones y baja de peso. Al generar la IC deben entregárselos informes al paciente. Pacientes con abdomen en delantal deben ser derivados a cirugía plástica según indicaciones.
CÁNCER DE ESÓFAGO	Policlínico de cirugía de tórax y NO a cirugía digestiva.		

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 28 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

b. HEPATOBILIO-PÁNCREAS

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
COLEDOCOLITIASIS	- Historia de dolor abdominal +/- transfixiante - Historia de Ictericia/ acolia / coluria. - Hallazgo de coledocolitiasis en ECO abdominal. - Consignar en historia de IC: Dolor / Ictericia / Coluria, Vómitos, Baja de peso, anorexia. - Antecedentes de cirugías previas. Flujo de derivación: APS→ Cirugía General → Cirugía hepatobiliopáncreas.	LABORATORIO: -Hemograma. -Protrombina y tromboplastina. -Glucosa. -Creatinina y nitrógeno ureico. -Amilasa, lipasa. -Bilirrubina total y directa. ECOGRAFÍA ABDOMINAL según cartera de prestaciones, informada con coledocolitiasis.	-Derivar a urgencia colangitis: dolor, ictericia fiebre (al momento de la consulta). -Si Eco no describen vía biliar; no describen paredes; no informan tamaño, disposición de litos. Repetir ecografía.
LESIÓN FOCAL HEPÁTICA	Derivar SI: <u>QUÍSTICAS:</u> - Quistes complejos. - Quiste hidatídico >5 cm - Abscesos hepáticos - Poliquistosis Hepática - Cistoadenocarcinoma /adenocarcinoma. <u>SÓLIDAS:</u> - BENIGNAS: hemangioma e Hiperplasia nodular focal→ control ecográfico; Adenoma derivar→ >5 cm.	<u>LABORATORIO:</u> -Hemograma. -Protrombina y tromboplastina. -Glucosa. -Creatinina y nitrógeno ureico. -Amilasa, lipasa. -Bilirrubina total y directa.	- En IC constatar historia epidemiológica; motivo de consulta v/s incidentaloma; dolor; ictericia; baja de peso; anorexia

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 29 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	- <u>MALIGNAS:</u> Hepatocarcinoma, Colangiocarcinoma. Flujo de derivación: APS→ Cirugía General → Cirugía hepatobiliopáncreas.	*Lesión Sólida: CA 19-9 , CA 125, AFP, ACE (Según cartera de prestaciones) ECOGRAFÍA ABDOMINAL/ TC (trifásico) / RM según disponibilidad. ENDOSCOPIA ALTA / COLONOSCOPIA (según disponibilidad) si sospecha de malignidad.	
HIDATIDOSIS HEPÁTICA	- Historia de tos vómica, hemoptisis, bilipneumonia, tumor palpable, dolor abdominal, ictericia. - + ECO quiste Hidatídico mayor a 5 cm. - Fracaso tratamiento pulsos de albendazol Flujo de derivación: APS→ Cirugía General → Cirugía hepatobiliopáncreas.	-ECOGRAFIA ABDOMINAL según disponibilidad - Rx DE TORAX AP-LL/ TAC según disponibilidad. -ELISA para <i>Equinococcus granulosus</i> según disponibilidad -ENO diaria!	- <u>Quiste <5cm→Albendazol:</u> - Albendazol 10mg /kg /día (max 800mg/día) dividido en 2 tomas diarias. 3 ciclos de 30 días con control ecográfico a los 3-6-12 meses. - Albendazol: control mensual, pruebas hepáticas, función renal, hemograma. *Evaluar según sintomatología eventual derivación vía urgencia, sobre todo si hay hemoptisis
CÁNCER DE VESÍCULA BILIAR	ECOGRAFÍA: -Vesícula de paredes engrosadas. - Masa que ocupe la vesícula o su lecho - Lesión hipo o isoecogénica con respecto al hígado o irregularidad en el contorno.	IMÁGENES: -Ecografía abdominal -TC (tórax y abdomen cte) según cartera de prestaciones.	

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 30 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	Flujo de derivación: APS → Cirugía General → Cirugía hepatobiliopáncreas.	EXÁMENES DE LABORATORIO: Hemograma, bioquímico, p. de coagulación CA19-9, según disponibilidad.	
--	---	---	--

c. TÓRAX

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
NÓDULO PULMONAR SOLITARIO	-Todo nódulo mayor de un centímetro. Revisar imágenes previas a tres años para ver si existía anteriormente (Si no hay cambios, se puede desestimar estudio) -Considerar lesión de vidrio esmerilado en paciente con alto riesgo epidemiológico de cáncer pulmonar.	- IC completa, con antecedentes - Imágenes previas - TC de tórax según disponibilidad. ENVIAR IMÁGENES EN CD O CON LINK. NO SIRVE SOLO EL INFORME RADIOLÓGICO.	EVALUACION DE RIESGO DE MALIGNIDAD se realizará al momento de la consulta del especialista. En caso de sospecha de cáncer activar GES.
QUISTE HIDATÍDICO	Clínica (inespecífica): tos, fiebre, dolor torácico, hemoptisis o expectoración hemoptoica recurrente, infección bronquial recurrente, broncorrea + CON IMAGEN SUGERENTE Flujo de derivación: APS → Cirugía General → Cirugía de Tórax	1. Interconsulta con datos anamnesis completos. 2. Ex de laboratorio para parámetros inflamatorios (hemograma, PCR) 3. Radiografía de tórax (mínimo) o TC de tórax con contraste EV, según disponibilidad	IMAGEN SUGERENTE = -Rx tórax opacidad homogénea circunscrita ovoídea, con o sin derrame pleural o signos neumónicos. -Rx Complicado: Signo del camalote Neumo periquiste -Derrame pleural -Nivel hidroaéreo -Cavitación -No dar albendazol Enviar de urgencia si está complicado, sobre todo si hay hemoptisis
DERRAME PLEURAL	PACIENTE HOSPITALIZADO CON DIAGNÓSTICO DE:	-Ex líquido pleural: Citoquímico,	- TRANSUDADO: estudiar en APS

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 31 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	1.EMPIEMA: que no mejore con drenaje pleural a la semana de evolución más tratamiento 2.EXUDADO PLEURAL: sin diagnóstico luego de estudios básicos (estudio de líquido: citoquímico, citológico, cultivo, ADA) DERIVACIÓN A TRAVÉS DE GESTIÓN DE PACIENTES, POR ATENCIÓN CERRADA (NO CORRESPONDE GENERAR IC) DESDE MEDICINA INTERNA O CIRUGÍA GENERAL.	citológico, LDH, ph, cultivo. -Exámenes generales. -TC tórax con contraste, según disponibilidad (luego de evacuado el derrame por toracocentesis)	- No derivar derrames sin definir si son exudados.
CÁNCER DE ESOFAGO	SINTOMAS INCIPIENTES: disfagia lógica, sensación de atoro + EDA SUGERENTE HISTORIA ERGE + síntomas consuntivos + EDA SUGERENTE	EDA + TAC tórax abdomen y pelvis con contraste si es factible. Si no, derivar a la brevedad solo con EDA	Todo paciente con disfagia debe realizarse una EDA. No retrasar la derivación por esperar el TAC.
DISFAGIA / ACALASIA	1. Acalasia se debe derivar a CIRUGIA DIGESTIVA 2. Todos los síntomas dispépticos y reflujo gastresofágico derivar a gastroenterología		

d. Cirugía Plástica

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
Guatita de delantal (Abdominoplastia)	- Paciente de cualquier sexo post cirugía bariátrica IMC <30 - Paciente de cualquier sexo IMC<28 ASA I o II (criterios de anestesia)	Pacientes ASA 2 derivar con exámenes según patología	No corresponde la derivación de pacientes con IMC >30

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 32 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

CIRUGÍA – UROLOGÍA INFANTIL

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
FIMOSIS	<u>Cirugía pediátrica:</u> - Menor a 4 años si: 1. ITU 2. Balanopostitis a repetición (más de 2 episodios) 3. Prepucitis 2 episodios o más 4. Parafimosis 5. Balanitis xerótica obliterante 6. En caso de requerir estudio con cateterización uretral (ej: cistouretrografía) 7. En caso de requerir cateterismo intermitente (ej: mielomeningocele) - Mayores de 4 años.	No requiere exámenes	Se realizará contra derivación en caso de no presentar fimosis o fimosis sin indicación quirúrgica.
CRIPTORQUÍDEA	<u>Cirugía Pediátrica:</u> - Mayor de 6 meses	Ecografía Testicular si es viable según cartera de prestaciones, objetivar ubicación y tamaño testicular	Se realizará contra derivación en caso de no presentar criptorquídea y ser testículo retráctil, que se debe derivar según corresponda (protocolo)
HERNIA UMBILICAL	<u>Cirugía Pediátrica:</u> - Mayor de 4 años - Menor de 4 años sólo si: 1. Hernia Atascada (derivar vía urgencia) 2. Sintomático	Ecografía partes blandas pared abdominal según cartera de prestaciones	Se realizará contra derivación en caso de no presentar hernia umbilical
TESTÍCULO RETRÁCTIL	<u>Cirugía Pediátrica:</u> - Mayor de 4 años 1. Persistir patología 2. Asimetría testicular	Ecografía testicular, según cartera de prestaciones, para objetivar tamaño testicular	Se realizará contra derivación de no presentar testículo retráctil
HERNIA INGUINAL	<u>Cirugía Pediátrica:</u> - Al momento del diagnóstico o sospecha clínica	Idealmente ecotomografía inguino-testicular	Se realizará contra derivación de no

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 33 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	1. Aumento de volumen inguinal 2. Atascamiento (derivar vía urgencia)	(según cartera de prestaciones) para objetivar patología	presentar hernia inguinal
ONICOCRIPTOSIS	<u>Cirugía Pediátrica:</u> - Menores de 10 años - Sin infección activa (debe tratarse en red episodio agudo) - Granuloma 2°	Exámenes generales para descartar causa metabólica	Se realizará contra derivación de ser mayores de 10 años, ya que pueden ser resueltos en centros que cuenten con Cirugía menor ambulatoria. HHA sólo cuenta con Cirugía mayor ambulatoria.
PILOMATRIXOMA O LESIONES SUBDERMICAS	<u>Cirugía Pediátrica:</u> - Menores de 10 años - Al momento del diagnóstico	Ideal complementar estudio con ecotomografía de partes blandas según cartera de prestaciones	Se realizará contra derivación si: - Paciente no desea cirugía - Lesión pequeña que pudiese realizarse con anestesia local previo acuerdo paciente-padres con cirujano
TÓRAX EXCAVUM O CARINATUM	<u>Cirugía Pediátrica:</u> - Mayores de 10 años - Repercusión hemodinámica de malformación	Radiografía de tórax AP y Lat	Se realizará contra derivación si: - Sin indicación quirúrgica según criterio especialista en cirugía tórax pediátrico.
HIPOSPADIAS	<u>Urología pediátrica:</u> - Menor a 10 meses si: • Testículo no palpable bilateral • Malformación reno vesical • Sospecha de DDS (desorden del desarrollo sexual) -Desde 10 meses de edad.	- Ecografía reno vesical según disponibilidad	Se realizará contra derivación si: - El paciente no presenta hipospadias - El paciente es derivado previo a la edad de derivación.
MALFORMACIONES DE LAS VIAS URINARIAS	Anomalías del parénquima renal: - Hipoplasia/displasia renal - Displasia renal multiquística - Agenesia renal Alteraciones de la posición:	- Ecografía reno vesical según disponibilidad	Se realizará contra derivación si: - El paciente no presenta malformación de las vías urinarias

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 34 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	- Ectopia renal - Anomalías de la fusión (riñón en herradura) Malformaciones de la vía urinaria: - Reflujo ureterovesical - Hidroureteronefrosis - Estenosis de la unión pieloureteral - Estenosis de la unión ureterovesical - Válvulas de uretra posterior		
ENURESIS	Sobre 5 años	- Ecografía reno vesical según disponibilidad	Se realizará contra derivación si: - El paciente no presenta enuresis
VEJIGA NEUROGÉNICA	Al momento del diagnóstico	- Ecografía reno vesical según disponibilidad	Evaluación por Neurocirujano, nefrología.
Disfunción detrusor y esfinteriana (vejiga hiperactiva)	Sobre 6 años	- Ecografía reno vesical según disponibilidad	

DERMATOLOGÍA

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
ACNÉ	Derivar solo los casos de acné inflamatorio severo. *casos de acné inflamatorio y no inflamatorio pueden ser derivados a Hospital Digital en caso de duda diagnóstica o requerimiento de canasta farmacológica. https://interconsulta.minsal.cl/	EXÁMENES REQUERIDOS PARA LA DERIVACIÓN: -Hemograma -Pruebas hepáticas -Perfil lipídico -Función renal	<u>MANEJO ACNE EN ATENCIÓN PRIMARIA:</u> Derivar a Hospital Digital. -Acné comedoniano: adapaleno 0.1 gel o crema uso nocturno iniciar noche por medio capa fina por 2 semanas luego todas las noches por 1 año.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 35 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

		-En mujeres test de embarazo	- Acné inflamatorio leve a moderado: adapaleno 0.1 más doxiciclina 100 mg o tetraciclina 250 mg cada 12 hrs por 6 semanas, según arsenal farmacológico → CONTROL A LOS 3 MESES: A) Evolución favorable: mantener adapaleno por 1 año. B) Sin respuesta a 3 meses de tratamiento: derivar todos los casos de acné inflamatorio severo.
DERMATITIS ATÓPICA Y DE CONTACTO	Derivar en caso de fracaso al tratamiento *Considerar derivación a Hospital Digital en caso de duda diagnóstica o requerimiento de canasta farmacológica no disponible en APS https://interconsulta.minsal.cl/		<u>MANEJO EN APS:</u> Derivar a H. Digital. Medidas generales: Evitar contactantes, Uso de jabón, shampoo y productos HIPOALERGENICOS, Uso de ropa de algodón en contacto con la piel, Detergente hipoalergénico bebé. Lubricar con Vaselina sólida o crema hipoalergénica diariamente. Niños y en región facial y genital: -HIDROCORTISONA 1% 2 veces al día por 5 a 10 días según arsenal farmacológico Adultos y cuerpo: - BETAMETASONA 0.05% 2 veces al día MAXIMO por 10 a 14 días -Clorfenamina 4 mg en caso de prurito → CONTROL A LOS 15 DIAS Derivar a dermatología si mala respuesta.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 36 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

			-Reforzar medidas generales de suspensión de contactantes.
NEVUS	<u>PRESENCIA SIGNOS DE ALARMA:</u> Alteración según regla ABCDE /Sospecha de Melanoma Nevos Congénitos: -Nevo congénito de bordes irregulares / de dos o más colores -Nevo congénito periorificial o localizado en línea media -Nevo congénito que mida más de 1,5 cms o múltiples en menor 6 meses Nevos Adquiridos: - Nevo asimétrico, borde irregular, dos o más colores o ulcerado - Nevo con halo blanco periférico - Nevo de reciente aparición en paciente mayor de 30 años - Cambio en Nevo: simetría, coloración, borde o superficie - Nevo localizado en mucosa oral, genital o subungueal - Nevo en paciente con antecedentes personales o familiares de melanoma Maligno o múltiples nevos, más de 100.		NO ES CRITERIO DE DERIVACION A DERMATOLOGIA: - Nevo con pelos, a menos que presente alguna característica de malignidad - Nevo cuyo único síntoma sea el prurito: Mayoría son por roce o trauma, control a los 15 días evitando irritantes y grataje con resolución de cuadro - Nevo con aumento de volumen regular progresivo con los años (frecuente en rostro y cuello) - Nevos que el paciente desea extirpar por motivos estéticos - Los nevos en las plantas y en las palmas se rigen por los mismos criterios de sospecha de malignidad del resto del cuerpo CIRUGIA MENOR AMBULATORIA EN CESFAM AMANECER (DSM TEMUCO) O PROPIA DEL ESTABLECIMIENTO Puede resolver Atención Primaria los Nevos sospechosos o nevos señalados previamente si lo amerita siempre con Biopsia
ROSÁCEA	Derivar en caso de <u>refractoriedad</u> de tratamiento. *Considerar derivación a Hospital Digital en caso de duda diagnóstica o requerimiento de canasta farmacológica.	EXÁMENES GENERALES: -Hemograma, Pruebas hepáticas y función renal.	<u>MANEJO EN APS:</u> FOTOPROTECTOR HIPOALERGENICO 50 + uso al levantarse y medio día permanente.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 37 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	https://interconsulta.minsal.cl/		2. METRONIDAZOL 0.75 GEL uso 2 veces al día mínimo 6 meses o permanente, según arsenal farmacológico 3. MEDIDAS GENERALES: Evitar sol, calor, duchas calientes, etc Evitar alimentos muy calientes o condimentados, ají alcohol, café, etc. →CONTROL A LAS 6 SEMANAS: -Si mala respuesta a tratamiento: Agregar doxiciclina 100 mg o tetraciclina 250 mg c 12 hrs por 6 semanas. →CONTROL EN 6 SEMANAS: - Derivar a dermatología si no hay mejoría en 3 meses.
ONICOMICOSIS	DERIVAR EN CASO DE: - Fracaso en el tratamiento - Duda diagnóstica *Considerar derivación a Hospital Digital en caso de duda diagnóstica o requerimiento de canasta farmacológica. https://interconsulta.minsal.cl/	EXÁMENES GENERALES: -Hemograma, Pruebas hepáticas y Creatinina y revisar historia de disfunción hepática crónica o activa e interacciones farmacológicas.	MANEJO EN APS: SOLICITAR EXÁMENES: Hemograma, Pruebas hepáticas y Creatinina y revisar historia de disfunción hepática crónica o activa e interacciones farmacológicas. →SI EXÁMENES NORMALES: Iniciar terbinafina a dosis de 250 mg/día por 1 mes según arsenal farmacológico Salvo casos de alta sospecha de onicomicosis por cándida (30% de los casos en manos e historia de paroniquia): Iniciar FLUCONAZOL 300 mg/semanales por AL MENOS 6-9 meses.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 38 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

			→CONTROL AL MES CON P. HEPÁTICAS. -Si exámenes Normales: Continuar tratamiento por 3 a 4 meses (4-5 meses en total) →EVALUAR A LOS 6 MESES: A) Si crecimiento proximal ungueal sano: Control en APS. B) Si caso refractario a tratamiento: -descartar recontagio interfamiliar. - Sospecha patología diferencial: DERIVAR A DERMATOLOGÍA
VERRUGAS	DERIVAR EN CASO DE: - Fracaso en el tratamiento - Persistencia de verruga después de 6 meses de seguimiento (involución espontánea)	EXÁMENES GENERALES: -Hemograma, -Pruebas hepáticas y -función renal.	MANEJO EN APS: A) VERRUGAS VULGARES Y PLANTARES: Uso de Ac. Salicílico+ Ac. Láctico (Duofilm® o Verrufilm®) nocturno por 3 meses, según arsenal farmacológico B) VERRUGAS PLANAS: Conducta expectante por 6 meses: casos autoresolutivos. →CONTROL MENSUAL Derivación a dermatología a los 6 meses de manejo en el nivel primario.
	- No corresponde derivación. Manejo en APS en cirugía menor		MANEJO EN APS: CIRUGIA MENOR AMBULATORIA EN CESFAM AMANECER (DSM Temuco)

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 39 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

ACROCORDONES			O PROPIA DEL ESTABLECIMIENTO
PSORIASIS	DERIVAR EN CASO DE: - Psoriasis severa afecta > 10% superficie corporal - Psoriasis con compromiso áreas significativas: cara, palmoplantar, genital - Psoriasis 5-10% superficie corporal que no responde a tratamiento tópico en APS <u>EN CASO DE COMPROMISO ARTICULAR DERIVAR A REUMATOLOGIA</u> *Considerar derivación a Hospital Digital en caso de duda diagnóstica o requerimiento de canasta farmacológica. https://interconsulta.minsal.cl/	EXÁMENES GENERALES: -Hemograma, Pruebas hepáticas y función renal.	MANEJO EN APS: EDUCACION: naturaleza crónica en brotes, exacerba estrés rascado fármacos (B- bloqueador, iECA, litio, Corticoides sistémicos) OH y Tabaco HUMECTACION: uso 2 veces al día idealmente en base a UREA 10% EXÁMENES: estudio sd metabólico asociado Manejo DEPRESION asociada frecuentemente <u>CLOBETASOL 0.05% (ideal) o BETAMETASONA 0.05%</u> uso 2 veces al día por 6 a 8 semanas luego uso fines de semana en caso necesario Psoriasis que persistan con lesiones activas pero < <u>5 % Superficie corporal mantener el manejo en APS</u>

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 40 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

ENDOCRINOLOGÍA ADULTO – DIABETES

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
DIABETES	Derivar: - Embarazadas + DM pregestacional o DM gestacional con requerimiento de insulina - Diabetes Tipo 1 - Diabetes Tipo LADA - Diabetes 2 que requieran esquema intensificado de insulina (basal + prandial según glicemias) - Diabetes 2 que estén con insulina y requieran controles frecuentes en atención 3ª por otras patologías, ejemplo: neurológicas, reumatológicas, gastroenterológicas, enfermedades neoplásicas - Diabetes 2 Post trasplante de órgano - DM2 con daño pancreático o fibrosis quística *Flujo de derivación: - Pacientes embarazadas: Telemedicina patología tiroidea y embarazo - Otros casos no GES: APS → Medicina Interna → Diabetología	EXÁMENES GENERALES: - Hemograma, - Pruebas hepáticas y función renal, - glicemia ayuna, - hemoglobina glicosilada, - pruebas tiroideas, - perfil lipídico, - perfil glicémico	Link guías clínicas GES: DM1 https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2014/12/Diabetes-Mellitus-tipo-1.pdf DM2 https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2018/01/DIABETES-MELLITUS-TIPO-2-1.pdf Diabetes y embarazo https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2016/03/GUIA-DIABETES-Y-EMBARAZO.pdf *Derivar a Hospital Digital en los casos que se requiera apoyo por especialista para compensación metabólica y GES N°7, DM2. https://interconsulta.minsal.cl/
DIABETES JUVENIL / TIPO I	Todas *Flujo de derivación:	EXÁMENES GENERALES: - Hemograma, - Pruebas hepáticas y función renal,	

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 41 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	- Pacientes embarazadas: Telemedicina patología tiroidea y embarazo - Otros casos no GES: APS→Medicina Interna →Diabetología	glicemia ayuna, hemoglobina glicosilada, pruebas tiroideas, perfil lipídico	
BOCIO DIFUSO	Derivar sólo ante síntomas compresivos	--	—
NODULO TIROIDEO	Derivar: - Nódulos solidos hipoecogénicos (Tirads 4 – T5): > 1 cm - Nódulos sólidos iso – hiperecogénico y sólido quísticos (Tirads 3): > 1.5 cm *Flujo de derivación: APS→Med. Interna→Endocrinología	- TSH -T4L - Ecotomografia tiroidea. Si es detectado por otro método, complementar con eco	Se adjunta referencia en anexo n°6
HIPOTIROIDISMO	Embarazadas. Resto de los casos deben ser manejados en APS *Derivar a policlínico de Telemedicina patología tiroidea y embarazo	TSH, T4L	
HIPERTIROIDISMO	Todos, priorizar según caso, embarazadas precozmente *Derivar a policlínico de Telemedicina patología tiroidea y embarazo.	TSH, T4L, T3, hemograma, pruebas hepáticas. IDEAL: eco tiroidea según cartera de prestaciones	1.- Consulta S. Urgencia (SUO) si paciente muy sintomática, tiene síntomas de insuficiencia cardiaca descompensada, presenta taquiarritmia o si las condiciones obstétricas lo indican. 2.- Resto son prioridad 1
HIPO/ HIPERCALCEMIA	Todas *Flujo de derivación: APS→Med. Interna→Endocrinología	Derivar con Ca-Fosfato-PTH-Vitamina D – Creatinina según cartera de prestaciones.	Evaluar derivación vía urgencia de acuerdo a sintomatología y gravedad. Hipercalcemia sobre 14, derivar en todos los casos a Urgencia. Hipercalcemia entre 12 a 14 según criterio clínico.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 42 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

TRASTORNO IDENTIDAD DE GENERO	Todas * Derivar a policlínico “Endocrinología de género”		Tiene su propia pestaña en red de derivación (Endocrinología de género)
HIPOGONADISMO MASC / FEM	Todas *Flujo de derivación: APS→Med. Interna→ Endocrinología	Masc: Testo / LH Fem: E2/ FSH	

ENDOCRINOLOGÍA INFANTIL (menores de 15 años)

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN CDT HHHA	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
HIPOTIROIDISMO	-Hipotiroidismo patrón central -Hipotiroidismo primario (TSH alta>10mUI/ml con T4L bajo) desde el nacimiento hasta la edad de Menarquia en niñas y hasta el estirón puberal en niños -Hipotiroidismo Subclínico sólo con TSH >10 *Flujo de derivación: APS→Pediatría →Endocrinología infantil	-Curva de crecimiento -Radiografía carpo -Exámenes recientes de TSH, T4libre, deseable anticuerpos anti tiroideos ATPO-ATG (según cartera de prestaciones)	Hipotiroidismo patrón central: TSH normal o baja con T4L baja Hipotiroidismo subclínico: TSH alta con T4libre normal, en 2 mediciones separadas
HIPERTIROIDISMO	Derivar a todos con prioridad 1 controlar periódicamente mientras llega Interconsulta. si síntomas y signos aumentan derivar a urgencia infantil APS→Pediatría →Endocrinología infantil	Exámenes de laboratorio: Hormonas tiroideas (TSH, T4 libre,T3), hemograma ,GOT, GPT, Bili total /fraccionada, GGT, creatinina	Si no hay contraindicación (obstrucción bronquial, Asma) iniciar beta-bloqueadores, ej: propanolol 0.5-2mg/k/día, cada 8 ó 12 hrs)
PUBERTAD PRECOZ en niñas	1.-Paciente de 2 a 8 años derivar a todas 2.-Paciente menor de 2 años, si: a) Se asocia a aceleración de velocidad de crecimiento. b) Con aumento progresivo de tamaño (Tanner 3 o más) c) Se asocia a otros signos puberales.	Curva de crecimiento radiografía carpo Deseable ecografía pélvica (solicitar medición de longitud uterina, volumen de ovarios , relación cuerpo/cuello)	-Niñas con más de 9 años con Menarquia o ya en Tanner IV no se ven favorecidas con frenación de pubertad para aumento de talla final, al contrario, podría ser perjudicial y además afectar adquisición de masa ósea, por lo que en general no se frenan.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 43 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	d) Avance de edad ósea mayor a 2 DE de la edad Cronológica 3.-Paciente entre 8 a 9 años, derivar solamente en caso de que Tanner I avance a Tanner III en un periodo menor de 6 mes o ya se encuentre en Tanner IV de mamas APS→Pediatria →Endocrinología infantil		Explicar y NO derivar -Niñas en que inicio de desarrollo puberal(telarquia) fue antes de los 6 años derivar vía GES (sospecha Tumor SNC en menor de 15 años) Si paciente muy rural, padres dudosa adherencia a indicaciones considerar derivar a urgencia para hospitalizar y agilizar estudio
PUBERTAD PRECOZ en niños	Derivar(prioridad 1) a todo niño menor de 9 años que inicie pubertad , con testes de 2.5cms de longitud mayor ó más (4cc o más de volumen) aislado o con otros signos de pubertad APS→Pediatria →Endocrinología infantil	Curva de crecimiento radiografía carpo Deseable testosterona total, LH,FSH	Derivar vía GES , sospecha Tumor SNC en menor de 15 años Si paciente muy rural , padres dudosa adherencia a indicaciones considerar derivar a urgencia para hospitalizar y agilizar estudio
TRASTONO DE LA PUBERTAD – PUBARQUIA PRECOZ	<u>Pubarquia precoz Definición:</u> Aparición de vello púbico(VP) antes de los 8 años en niñas; antes de los 9 años en niños <u>Derivar en los siguientes casos:</u> a) Niña menor de 8 años/Niño menor de 9 años: Siempre derivar, variante normal o idiopático es de descarte, se debe descartar patología. Si presenta VP más de Tanner III y/o otro signo de pubertad (desarrollo mamario, virilización en la niña, aumento desarrollo peneano en el niño, ginecomastia) b) Niña mayor de 8 años si presenta virilización, por	Curva de crecimiento. radiografía de carpo(edad ósea)	Si presenta VP más de Tanner III y/o otro signo de pubertad (desarrollo mamario en la niña de inicio menor de 6 años, virilización en la niña, aumento desarrollo peneano en el niño, ginecomastia, derivar prioridad 1, vía GES, sospecha de tumor sólido (Cáncer) en menor de 15 años Si paciente muy rural, padres dudosa adherencia a indicaciones considerar derivar a urgencia para hospitalizar y agilizar estudio Niños y Niñas con sólo olor axilar apocrino aislado

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 44 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	ejemplo: clitoromegalia(>1cm) Flujo de derivación: APS→Pediatria →Endocrinología infantil		sobre los 6 años de edad no necesita derivación Niños y Niñas con sólo olor axilar apocrino aislado menor de 6 años derivar a Endocrinología pediátrica con mismos exámenes que en pubarquia precoz
TRASTONO DE LA PUBERTAD – GINECOMASTIA aislada	Ginecomastia aislada prepuberal (es decir con testes menor a 2.5cms de longitud mayor o menor a 4cc de volumen) derivar siempre prioridad 1 Ginecomastia aislada en niño > 9 años /adolescente con pubertad derivar si es mayor de Tanner III símil, o en progresión en 6 meses de observación, o antecedente mórbido de riesgo para que sea patológica Flujo de derivación: APS→Pediatria →Endocrinología infantil	Curva de crecimiento Radiografía de carpo Deseables exámenes sanguíneos: LH, FSH, testosterona total, HCG, alfa feto proteínas , prolactina, TSH,T4L,T3,LDH,DHEAS, 17OHprogesterona→NO DEMORE IC para realizar exámenes sanguíneos	Hallazgo, antecedente mórbido de riesgo de Ginecomastia patológica: Edad : Prepuberal Fármacos: investigar causa farmacológica, incluida sospecha consumo de cannabis Evolución: rápida y progresiva Ginecomastia de gran tamaño (> 4cm de diámetro). Testes pequeños y escasa virilización o pubertad detenida. Masas en testes o abdomen. Bocio (sospecha hipertiroidismo) Talla muy alta, crecimiento acelerado y/o hipogenitalismo Enfermedad: buscar falla renal/falla hepática crónica Galactorrea /Telorragia

TALLA BAJA	- <u>Talla baja severa</u> < -3DE - Diferencia entre carga genética y talla actual >2DE (bajo 6cms del promedio de talla diana en niñas / bajo 7cms del promedio de talla diana en niños) - Velocidad de crecimiento <4cm/año a cualquier edad. - Caída sostenida de percentiles (o DE) de talla luego de los 18-24 meses de edad, con estancamiento de curva de crecimiento - Talla baja asociada a desproporción o dismorfias. - Pequeño para la edad gestacional (PEG) sin crecimiento compensatorio (talla dentro de talla genética) pasados los 2 años de edad. Flujo de derivación: APS→Pediatria →Endocrinología infantil	- Exámenes de laboratorio: Hemograma, orina completa, perfil bioquímico con creatinina, Gases venosos, electrolitos plasmáticos, hormonas tiroideas (TSH, T4libre), deseable estudio enfermedad celiaca, IGF1 - Radiografía de carpo en mayores de 1 año, informada (traer placa o CD compatible con PC de policlinicos HHA) en centros que cuenten con el recurso.	-Si al evaluar exámenes generales solicitados se encuentra alteración de otra subespecialidad pediátrica, derivar a esa subespecialidad -Niñas postmenarquia no derivar a menos que tenga dismorfias y se sospeche Síndrome genético donde igual es necesario estudio, pero no para mejorar talla ya que postmenarquia no es posible intervención -Niños con Tanner IV genital no derivar a menos que tenga dismorfias y se sospeche Síndrome genético donde igual es necesario estudio , pero no para mejorar talla ya que no es posible intervención
Diabetes en Pediatría	- Sospecha Diabetes tipo 1: derivar a URGENCIA de centro terciario(HHA), aunque paciente se encuentre aparentemente estable - Diabetes tipo 2 : estable (es decir sin clínica de síndrome Diabético agudo, esto es polidipsia, polifagia, poliuria, baja de peso , HGT bajo 200 , realizar IC GES a policlinico endocrinología , prioridad 1 Flujo de derivación: APS→Pediatria →Endocrinología infantil	- HGT (Glicemia capilar) TODOS - En Diabetes tipo 1 (todos) y Diabetes tipo 2 con síndrome diabético agudo es deseable Glicemia central, gases venosos, ELP, ex orina, cetonemia IMPORTANTE: no demorar traslado esperando exámenes -En Diabetes tipo 2 estable: Glicemia central, perfil	-Diabetes tipo 1 y Diabetes tipo 2 con síndrome diabético agudo: estabilizar previo traslado a urgencia, volumelizar si corresponde, Hidratar, NO USAR INSULINA sin realizar ELP, salvo casos excepcionales después de lo anterior (demora excesiva de traslado por ej) siempre asesorándose por pediatras SUI y/o

		lipídico, hb glicosilada, creatinina, índice micro albuminuria/creatinuria (RAC), deseable evaluación FO por oftalmólogo, según disponibilidad	residentes centro terciario Diabetes tipo 2 estable: iniciar educación estilos de vida saludable, no azúcar, metformina 250 mg a 2grs máximo día en mayores de 10 años de edad, empezar progresivamente y con alimentación (almuerzo y/o cena) para mejorar tolerancia y adherencia Intervención con equipo local (EU , nutricionista , unidad salud mental)mientras llegue IC y después alternadamente con centro terciario
--	--	--	--

GASTROENTEROLOGÍA ADULTO

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO	-Solo en casos de muy difícil manejo. -Presencia de síntomas de alarma. *Si cumple criterios de síndrome intestino irritable, identificar el predominio de síntomas, como diarrea o constipación, manejar con:	Colonoscopia en mayores de 50, si rectorragia colonoscopia.	—

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 47 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	- antiespasmódicos, énfasis medidas generales y alimentación. *Flujo de derivación: APS → Medicina Interna → Gastroenterología adulto		
CONSTIPACIÓN	Solo en caso de fracaso a tratamiento médico en APS. *Flujo de derivación: APS → Medicina Interna → Gastroenterología adulto		Medidas generales: -Aumento de fibra, uso de laxantes como lactulosa o polietilenglicol de preferencia, se sugiere derivar después de 6 meses de tratamiento
ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO	Solo en casos refractarios a tratamiento: - IBP - Baja de peso y la elevación de la cabecera de la cama. *Flujo de derivación: APS → Medicina Interna → Gastroenterología adulto	EDA en mayores de 40 años.	Pacientes < a 40 años no necesitan endoscopia para diagnóstico (si no hay síntomas de alarma) Se sugiere omeprazol 20 mg al día AM también cada 12 horas, por 8 semanas.
SINDROME ULCEROSO	Solo en caso de fracaso a tratamiento inicial: -Omeprazol 20 mg -Medidas generales: evitar AINES, tabaco y exceso de alcohol *Flujo de derivación: APS → Medicina Interna → Gastroenterología adulto	Endoscopia digestiva alta, sobre todo mayor de 40 años. (gestipon por programa de resolutiveidad en APS).	
HEPATITIS AGUDA	Alteración pruebas hepáticas: - BT>15 mg/dl - Tiempo de protrombina. *Flujo de derivación: APS → Medicina Interna → Gastroenterología adulto	Hemograma, tiempo de protrombina, glicemia, Función renal, Función hepática, PCR. Según cartera de prestaciones: - IgM anti VHA - HBsAg - IgM anticore VHB	Control con ex lab, semanalmente las primeras dos semanas. Derivar vía urgencia en caso de signos de alarma: - Coagulopatía - Compromiso de consciencia - Vómitos a repetición

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 48 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

		- Anticuerpos anti-VHC - IgM anti VEB - IgM anti CMV	
ÚLCERA PEPTICA	-CLÍNICA: Dolor epigástrico urente mayor en ayuna, o dolor que aumenta posterior a la ingesta de alimentos, Dispepsia. -Úlcera Gástrica, sin respuesta a tratamiento erradicación H. Pylori o úlcera no cicatrizada en EDA de control. -úlcera duodenal, H. pylori (-) *Flujo de derivación: APS → Medicina Interna → Gastroenterología adulto	EDA con test de ureasa (gestión por programa de resolutiveidad en APS)	Si H. pylori (+) erradicar HP

GASTROENTEROLOGÍA INFANTIL – ALERGIA A LA PROTEÍN DE LECHE DE VACA

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
ALERGIA ALIMENTARIA - ALERGIA A LA PROTEÍNA DE LECHE DE VACA	- Clínica sugerente con prueba y contraprueba positiva que NO corresponda a nodo CAPLC, Villarrica, Imperial, Pitrufquén, Lautaro - Paciente de difícil manejo con clínica de FPIES, FPE *Flujo de derivación: APS→Pediatría →Gastroenterología infantil	- hemograma - bioquímico - Coprocultivo	- curva nutricional según edad - Revisar técnica de lactancia *Descartar otras patologías *Pacientes con clínica IgE mediada, derivar a Inmunología Pediátrica.
CONSTIPACION	- Pacientes con criterio ROMA IV, con banderas rojas	- Según sospecha clínica	- Ev nutricional - Tratamiento realizado y evoluciones

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 49 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	- Constipación de difícil manejo Flujo de derivación: APS→Pediatría →Gastroenterología infantil		
DOLOR ABDOMINAL CRONICO	- Sospecha de etiología orgánica - Sin respuesta a tto (contexto biopsicosocial) Flujo de derivación: APS→Pediatría →Gastroenterología infantil	- Según sospecha diagnóstica	- Establecer signos/síntomas de alarma que presenta y estudio asociado según ello (historia familiar: ulcera péptica, enf celiaca, enf inflamatoria intestinal) y manejo realizado.
Hepatitis Aguda	- Sin signos de insuficiencia hepática Flujo de derivación: APS→Pediatría →Gastroenterología infantil	- Según sospecha: Hemograma, Perfil hepático - Eco abdominal	- Ev clínica si amerita hospitalización
Falla hepática aguda	- Servicio urgencia, no corresponde derivación a CDT Flujo de derivación: APS→Pediatría →Gastroenterología infantil	-	- Hospitalización UPC, derivación precoz a centro de trasplante en caso de cumplir criterios.
Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico	- Derivación para evaluación en caso de signos/síntomas de alarma, sin sospecha de causa quirúrgica o metabólica		- Curva crecimiento, incremento ponderal, signo/síntoma alarma, manejo realizado.
Hipertransaminasemia	- Derivación con 2do estudio elevado y CK normal Flujo de derivación: APS→Pediatría →Gastroenterología infantil	- Perfil hepático - Eco abdominal - Serología Virus A, B, C, E, CMV, VEB - EO/URC(lactantes) - Hmas tiroideas - Marcadores de enf celiaca	- Curva crecimiento, evaluación nutricional, manejo realizado.
Diarrea crónica	- En caso de banderas rojas: deterioro	- Según sospecha diagnóstica	- Curva crecimiento/ev nutricional

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 50 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	pondoestatural e inicio precoz del cuadro - Pacientes refractarios a manejo inicial Flujo de derivación: APS→Pediatría →Gastroenterología infantil		- Signos/síntomas de alarma, ant familiares.
Ictericia en el menor de 3 meses	- En paciente con ictericia, acolia y/o coluria Flujo de derivación: APS→Pediatría →Gastroenterología infantil	- BT-BD	- Si predominio directo, derivación para descarte AVB.
Sospecha de cuerpo extraño	- No corresponde derivación por interconsulta. Derivar vía Urgencia según sintomatología y sospecha		
Hemorragia Digestiva Alta/baja	- No corresponde generar interconsulta si hemodinamia inestable o sangrado activo, en cuyo caso se debe derivar vía urgencia.		Derivación ambulatoria con Hgma, cinética de Fe, P. coagulación
Gastroenteritis Aguda	- No corresponde IC. Atención de urgencia		
Sospecha Enfermedad celiaca	- Ante sospecha por clínica GE o extra intestinal (anemia, talla baja, enf autoinmunes, sint neuropsiq) o búsqueda activa Flujo de derivación: APS→Pediatría →Gastroenterología infantil	Según disponibilidad: - IgA total - Ac antitransglutaminasa	- NO INDICAR DIETA LIBRE DE GLUTEN HASTA COMPLETAR ESTUDIO
Enfermedad Inflamatoria Intestinal	- Diarrea con sangre con estudio negativo o que dura más de 10 días - Dolor abdominal y desnutrición sin otra explicación	- Exámenes generales básicos: hemograma con VHS - PCR - Estudio infeccioso en deposición	Evaluación nutricional

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 51 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
POLIFARMACIA	Paciente > 60 años que sea usuario de 11 o más fármacos *Derivación solo a través de Hospital Digital, Anexo N°12	Hemograma, VHS Perfil renal, ELP, Fósforo, Calcio, Perfil hepático, Albúmina, LDH, Proteínas totales, Glicemia, Uricemia, perfil lipídico, pruebas de coagulación, TSH, T4L, otros pertinentes a patologías de base. Se sugiere Niveles de V. B12; 25 - Hidroxi Vit. D; VDRL o RPR; VIH	
MULTIMORBILIDADES	Paciente >60 años que presente 5 o más morbilidades crónicas, alguna de ellas de difícil compensación (hipertensión, hipotensión, dislipidemia, etc) *Derivación solo a través de Hospital Digital, Anexo N°12	Hemograma, VHS Perfil renal, ELP, Fósforo, Calcio, Perfil hepático, Albúmina, LDH, Proteínas totales, Glicemia, Uricemia, perfil lipídico, pruebas de coagulación, TSH, T4L, ex de orina, otros pertinentes a patologías de base. Se sugiere Niveles de V. B12; 25 - Hidroxi Vit. D; VDRL o RPR; VIH	
CAÍDA DE LA FUNCIONALIDAD	Disminución de 15 puntos en el índice de Barthel en menos de 1 año. *Derivación solo a través de Hospital Digital, Anexo N°12	Hemograma, VHS Perfil renal, ELP, Fósforo, Calcio, Perfil hepático, Albúmina, LDH, Proteínas totales,	Índice de Barthel, Anexo N° X

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 52 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

		Glicemia, Uricemia, perfil lipídico, pruebas de coagulación, TSH, T4L, ex de orina, otros pertinentes a patologías de base. Se sugiere Niveles de V. B12; 25 - Hidroxi Vit. D; VDRL o RPR; VIH	
Delirium hipo o hiperactivo	Derivar vía Urgencia		

GINECOLOGÍA

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
DIU SIN GUIAS	1° Se intenta extracción en APS 2° IC por Ginecólogo (no por Matró). Hacer IC desde APS para ECO, no para Ginecología General	1. Ecografía TV 2. Exámenes pre operatorios.	Derivar siempre
ENDOMETRIOSIS	Sospecha ecográfica (Ecografía TV).		*NO derivar por dismenorrea (debe ser visto por ginecólogo infanto juvenil o Ginecólogo general)
PARIDAD CUMPLIDA (ASISTENCIA PARA ANTICONCEPCION)	1° Resolución primero en Nodos (poli Ginecología General)	1. Ecografía TV	Pacientes con comorbilidades: Pase

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 53 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	2° IC a Ginecología General /Matrona: Con Consejería Esterilización quirúrgica.	2. Exámenes pre operatorios	especifico de subespecialidad • Obesidad: Evaluación por especialista en Nutrición • Pase anestesia • HTA-DM (estabilizar en APS)
INFERTILIDAD: - FEMENINA - FEMENINA ASOCIADA A FALTA DE OVULACIÓN - DE ORIGEN TUBARIO - SECUNDARIA	Derivada por Ginecología general *Flujo de derivación: APS → Ginecología General → Policlínico de Infertilidad	HSG, Eco Tv con recuento de Folículos, en menores de 40 años, hormona antimülleriana, progesterona día 21 del ciclo.	
INFERTILIDAD: - CONYUGAL	Derivada por Ginecología general *Flujo de derivación: APS → Ginecología General → Policlínico de Infertilidad	Derivar con Espermiograma, HSG, Eco Tv con recuento de Folículos, en menores de 40 años, hormona antimülleriana, progesterona día 21 del ciclo.	Desde APS derivar a Ginecología casos con imposibilidad de embarazo después de 12 meses o más manteniendo relaciones sexuales habituales sin protección.

HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA ADULTO

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
CÁNCER	Derivar con Diagnóstico realizado (biopsia) *Biopsias ganglionares gestionadas derivando a	Exámenes de laboratorio: Hemograma con frotis, perfil bioquímico, función hepática y renal.	—

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 54 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	Cirugía General. Activar GES según corresponda		
--	--	--	--

ANEMIA	Evaluación previa por Medicina interna en centro nodo.	Hemograma con frotis, perfil bioquímico, función hepática y renal. Ferritina y cinética de fierro, reticulocitos.	Derivación de anemia ferropriva refractaria , anemia hemolítica inmune / no inmune , anemia normocítica sin causa conocida
POLICITEMIA	Evaluación previa por Medicina interna en centro nodo , descartando causas secundarias (Ecocardiograma , RxTx , NP de eritropoyetina)	Hemograma con frotis, perfil bioquímico, función hepática y renal , LDH , uricemia , NP vit B12 y NP de eritropoyetina (SI están disponibles)	Derivar a SUA en caso de poliglobulia con antecedente de ACV , eventos trombóticos , HCTO $\geq$ 55% en poliglobulia secundaria. Si no es posible realizar sangría.
TRASTORNO DE LOS LEUCOCITOS	Evaluación previa por Medicina interna en centro nodo. 1.- Si GB $<$ 4000 mm ³ ó $>$ 10000 mme sin causa evidente secundaria ó asociada a otra citopenia 2.- RAN $<$ 1000 mm ³ sin causa evidente 3.- Eosinofilia $\geq$ 1500 mm ³ sin causa evidente 5.- Linfocitosis $\geq$ 5000 mm ³	Hemograma con frotis, perfil bioquímico, función hepática y renal , estudio viral (VHB y C , VIH , HTLV1) e inmunológico.	RAN $<$ 1000 mm ³ asociado a fiebre debe ser derivado al SUA
TROMBOCITOSIS	Evaluación previa por Medicina interna en centro nodo. Plaquetas $\geq$ 450.000 mm ³ sin causa aparente	Hemograma con frotis, perfil bioquímico, función hepática y renal , PCR , RXTX y ecografía abdominal (paraneoplásico/infeccioso)	Anamnesis imprescindible para trombocitosis reactiva, análisis de recuentos previos_
SOSPECHA DE ADENOPATÍA MALIGNA	-> 2 cm- -Consistencia dura/gomosa -Ausencia de signos inflamatorios ó foco infeccioso -Adherida a planos profundos	-Hemograma con frotis, perfil bioquímico, función hepática y renal , estudio viral e inmunológico, PCR , - Solicitar biopsia ganglionar, sin que ello implique retraso en la derivación a la especialidad	No usar corticoides GES se activa en caso de SOSPECHA de linfoma En caso e contar con Biopsia que confirma Cáncer Hematológico se debe derivar al paciente ambulatorio con Enfermera Coordinadora de

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 55 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	-Aumento de tamaño en el tiempo -Supraclavicular -Síntomas B -No regresa con antiinflamatorios y/o antibióticos. -Asociada a esplenomegalia		Hematología Policlínico y ser presentado por Médico r en Comité de Hematología Mail : Guía Clínica Linfoma en personas de 15 años y más: https://www.minsal.cl/port al/url/item/7220fdc4340544a9e04001011f0113b9.pdf
TROMBOCITOPENIA AISLADA	Evaluación previa por Medicina interna en centro nodo. Recuentos <100.000 mm3 con estudio secundario sin hallazgos	Hemograma con frotis, perfil bioquímico, función hepática y renal , estudio viral e inmunológico , ecografía abdominal , test Hoy en deposiciones, TSH y T4I	_Recuentos plaquetas < 20.000 mm3 ó sangrado deben ser derivados a SUA

HEMATO-ONCOLOGÍA INFANTIL

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN CDT HHA	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
ANEMIA	Anemia normocítica o macrocítica. VCM de acuerdo a edad: > 70 + Edad(años)	Hemograma con frotis, Reticulocitos.	Recomendable evaluación por pediatra previo a derivación (Descartar causas secundarias)
	Anemia microcítica en Escolar o que no responda a ferroterapia adecuada. VCM de acuerdo a edad: < 70 + Edad(años) Flujo de derivación: APS → Pediatría → Hemato – oncología infantil	Hemograma con frotis, Reticulocitos, Cinética de fierro (según cartera de prestaciones)	Anemia ferropriva carencial del lactante derivar solo si no hay respuesta a terapia con Fe en dosis adecuadas (revisar adherencia al tratamiento). Investigar causa de ferropenia en todo mayor de 4 años.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 56 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

TRASTORNO DE LOS LEUCOCITOS	Eosinofilia > 1500/mm ³ Persistente por 6 meses o con evidencia de daño orgánico (piel, corazón, SNC, hígado) Flujo de derivación: APS → Pediatría → Hemato – oncología infantil	Hemograma con frotis, función hepática y renal, LDH, Inmunoglobulinas	Descartar causas alérgicas y parasitarias. Estudio inicial por pediatra.
	Neutropenia < 1000/mm ³ en al menos 2 controles separados por una semana Flujo de derivación: APS → Pediatría → Hemato – oncología infantil	Hemograma con frotis, Inmunoglobulinas	Derivar a servicio de urgencias si se encuentra en contexto de infección bacteriana.
	Leucocitosis > 30.000/mm ³ aislada Flujo de derivación: APS → Pediatría → Hemato – oncología infantil	Hemograma con frotis	Derivar si no está en contexto de proceso infeccioso/inflamatorio. Previa evaluación por pediatra.
TROMBOCITOPENIA	Plaquetas <20.000/mm ³ Aislada Flujo de derivación: APS → Pediatría → Hemato – oncología infantil	-	Derivar a servicio de urgencias.
	Plaquetas > 20.000/mm ³ aislada sin sangrado. Flujo de derivación: APS → Pediatría → Hemato – oncología infantil	Hemograma con frotis, Reticulocitos.	Mantener seguimiento semanal por pediatra hasta control por sub-especialidad.
TROMBOCITOSIS	Plaquetas >600.000/mm ³ Aislada en al menos 2 controles separados por cuatro semanas Flujo de derivación: APS → Pediatría → Hemato – oncología infantil	Hemograma con frotis	Derivar solo si persiste en el tiempo, no asociado a patología infecciosa/inflamatoria. Descartar ferropenia latente.
ADENOPATÍAS	Adenopatías que reúnan los siguientes criterios: -Tamaño > 2 cm -Forma redondeada -Consistencia dura/gomosa -Ausencia de signos inflamatorios o foco infeccioso en territorio de drenaje -Adherencia a planos profundos -Aumento de tamaño en el tiempo -Localización supraclavicular (TODAS) -Síndrome adénico generalizado (fuera de contexto infeccioso)	Hemograma con frotis, VHS, Perfil bioquímico, Ecografía ganglionar / abdominal según cartera de prestaciones. Rx tórax.	Derivar a urgencias si se asocia a síntomas compresivos (síndrome vena cava superior). Intentar curso corto con antibiótico/antiinflamatorio y evaluar respuesta previo a derivación, si hay

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 57 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	-Asociación a síntomas B (fiebre vespertina, pérdida de peso, sudoración nocturna) Flujo de derivación: -APS →Pediatría → Hemato – oncología infantil		sospecha de cuadro infeccioso local. ** NO USAR CORTICOIDES PREVIO A LA DERIVACIÓN**
ESPLENOMEGALIA A	Derivar si se asocia a alteraciones del hemograma Flujo de derivación: APS →Pediatría → Hemato – oncología infantil	Hemograma con frotis y reticulocitos, función hepática, Ecodoppler abdominal.	Evaluación previa por pediatra para descartar causas infecciosas, Hipertensión portal, Enfermedad de depósito.
COAGULOPATÍAS S	Prolongación aislada de tiempos de coagulación (TP y TTPa) en 2 controles separados por al menos 4 semanas en paciente asintomático. Flujo de derivación: APS →Pediatría → Hemato – oncología infantil	Hemograma, Perfil de coagulación realizado en HHA con hora citada.	En pacientes con TP prolongado de forma aislada evaluar respuesta a administración de Vitamina K.
	Paciente con sangrado muco-cutáneo recurrente o severo. Flujo de derivación: APS →Pediatría → Hemato – oncología infantil	Hemograma, Perfil de coagulación realizado en HHA con hora citada.	Anamnesis historia familiar sugerente de coagulopatía congénita. Sin causa local gatillante (ej: gingivitis, rinitis alérgica)
	Hematomas o Hemartrosis desproporcionadas al trauma. Flujo de derivación: APS →Pediatría → Hemato – oncología infantil	Hemograma, Perfil de coagulación realizado en HHA con hora citada.	
	Paciente con familiar de primer grado con diagnóstico de coagulopatía congénita. Flujo de derivación: APS →Pediatría → Hemato – oncología infantil	Hemograma, Perfil de coagulación realizado en HHA con hora citada.	
PACIENTE EN TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE	Paciente en tratamiento anticoagulante con HBPM o anticoagulantes orales. Flujo de derivación: APS →Pediatría → Hemato – oncología infantil	Perfil de coagulación	En caso de cardiopatas, evaluación por cardiología infantil HHA previo.
TROMBOFILIA	Sospecha de trombofilia: Episodio de enfermedad tromboembólica.	Perfil de coagulación	

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 58 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	Localización poco habitual de evento trombótico. Familiares de pacientes con trombofilia primaria y/o antecedentes trombóticos relevantes. Trombosis o purpura fulminante neonatal.	realizado en HHA con hora citada.	
CANCER	Derivación según manual “Detección cáncer Infantil y cómo derivar” (MINSAL) https://redcronicas.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2014/08/Manual-cuando-sospechar-un-c%C3%A1ncer-en-el-ni%C3%B1o-y-c%C3%B3mo-derivar-2012.pdf 	No demorar derivación en espera de exs con sospecha fundada. Adjuntar exs pertinentes a la sospecha Dg	Evaluación por pediatra previo a traslado si hay disponibilidad inmediata.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, POLICLÍNICO (ITS)

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
CONDILOMA ACUMINADO Y MOLUSCO CONTAGIOSO GENITAL, GONORREA, CHLAMYDIA O URETRITIS NO GONOCÓCICA, SÍFILIS, HERPES, TRICHOMONA, LINFOGRANULOMA, CHANCROIDE	Derivar sólo lesiones circunscritas a área genital. NO derivar lesiones que correspondan a otras localizaciones. Mucosa oral → Derivar a patología oral (Odontología) Lesiones dermatológicas extragenitales sugerentes de condiloma/Molusco → ver diagnóstico “Verrugas” Dermatología, considerar derivación a Dermatología Hospital Digital.	- VIH (puede ser test rápido) - RPR/VDRL Ambos exámenes con antigüedad <6 meses. Según cartera de prestaciones, sumar: - Hepatitis B y C - Cultivo de secreción endocervical, secreción orofaríngea y/o secreción uretral en casos que exista sospecha	En el caso de que el paciente cuente con exámenes del extrasistema, adjuntarlos en el correo. Considerar de acuerdo a sospecha o confirmación diagnóstica la necesidad de realizar denuncia en pacientes pediátricos. *Si el paciente no acepta atención telemática, derivar igualmente correo pero

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 59 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	Flujo de derivación: APS (matrona, enfermera o médico) → derivar caso con ficha ITS (Anexo N°6) a policlínico correspondiente a través de correo telemedicinait.sdsas@asur.cl En el caso de existencia de lesiones dérmicas anexar fotografía de lesiones. Se dará acuso de recibo dentro de 24 h (días hábiles).	de gonorrea o UNG, clamidia.	adjuntando solo datos del paciente y número de contacto (Nombre, RUT, teléfono, correo electrónico)
SÍFILIS EN EMBARAZADA	Sospecha tras VDRL reactivo. Indicar PNC BENZATINA 2.4 mill IM sólo con VDRL y no con RPR o USR (confirmando ausencia de alergia). Posterior a ello, derivar mediante el siguiente flujo: APS (matrona, enfermera o médico) → derivar caso con ficha ITS (Anexo N°6) a policlínico correspondiente a través de correo telemedicinait.sdsas@asur.cl En el caso de existencia de lesiones dérmicas anexar fotografía de lesiones. Se dará acuso de recibo dentro de 24 h (días hábiles).		- Citar idealmente a la brevedad a contactos sexuales para estudio de RPR/VDRL, mientras se gestiona atención en policlínico ITS - Junto con derivación a policlínico de ITS, generar IC a Alto Riesgo Obstétrico.

INMUNO-REUMATOLOGÍA INFANTIL

VII. PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN CDT HHHA	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
ALERGIA	Debe ser derivado a Inmunología solo si: 1. Ha presentado compromiso vital (anafilaxia por ej) 2. Pacientes alérgicos	Hemograma, Pbg, IgS GAME, C3 y C4.	Dar las indicaciones generales de manejo de alergia. Hacer tratamiento de dermatitis atópica según

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 60 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	refractarios a tratamiento. 3. Pacientes con sospecha de angioedema hereditario. Flujo de derivación: APS →Pediatría → Inmunoreumatología infantil		protocolos con lubricación, corticoides tópicos y en conjunto con dermatología. En caso de rinitis alérgica tratarla corticoides nasales y antialérgicos. Derivar solo los casos refractarios a tratamiento
INMUNODEFICIENCIA	Inmunodeficiencias primarias(según los criterios Jeffrey Modell), siempre derivar. Flujo de derivación: APS →Pediatría → Inmunoreumatología infantil	Hemograma , PCR, Pbq, orina completa, IgS GAME, C3 y C4.	Ante sospecha de inmunodeficiencia combinada severa avisar inmediatamente.
ENFERMEDADES AUTOINFLAMATORIAS	Cuadro clínico compatible, siempre derivar. Flujo de derivación: APS →Pediatría → Inmunoreumatología infantil	Hemograma , PCR, VHS, Ferritina, Pbq, orina completa, IgS GAME, C3 y C4, Ac Antinuclear.	Manejo sintomático, idealmente sin esteroides.
SOSPECHA CLINICA DE ENFERMEDAD AUTOINMUNE (AIJ, LUPUS ETC)	Cuadro clínico compatible, siempre derivar. Flujo de derivación: APS →Pediatría → Inmunoreumatología infantil	Hemograma, PCR, VHS, Pbq, orina completa, IgS GAME, C3 y C4, Ac Antinuclear y Factor Reumatoideo.	Manejo sintomático, idealmente sin esteroides.
ALERGIA A LA PROTEINA DE LA LECHE	Estos pacientes deben ser derivados a gastroenterología pediátrica, donde existe un policlínico de APLV y si los médicos tratantes consideran necesario, nos los derivan para reevaluación en inmunología. Flujo de derivación: APS →Gastroenterología pediátrica → Inmunoreumatología infantil		

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 61 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN – POLICLÍNICO DE AMPUTADOS

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
LUMBAGO	Derivar en caso de: Presencia de Banderas Rojas (orienta a dolor lumbar de causa específica). **según red de derivación (nodos) Si Lumbago Inespecífico: Derivar en caso de persistencia de dolor severo (EVA >6) pese a manejo conservador >3 meses (Kinesioterapia motora, al menos 10-20 sesiones; manejo nutricional: Control de peso; dosis máxima de medicamentos) *Ver Protocolo de Columna Lumbar. No derivar para realización de estudio imagenológico sin clínica sugerente de <u>Lumbago específico</u>.	-Exámenes de laboratorio: hemograma, VHS, PCR, Fosfatasa Alcalina, Ex. orina + urocultivo. Solicitar en caso de sospecha de patología específica. -Radiografía columna lumbar AP y Lateral: Solicitar en caso de sospecha de patología específica o si en un lumbago inespecífico dolor persiste más de 6 semanas. *Considerar que después de los 40 años los cambios degenerativos son frecuentes	-Tratar todos los casos de dolor lumbar inespecífico, Pesquisar y tratar las banderas amarillas, para prevenir y manejar el dolor lumbar inespecífico crónico. -Estudio inicial y derivación adecuada de los lumbagos de causa específica, detectados a través de las banderas rojas -Derivar a la urgencia solo los casos urgentes -Lograr identificar y manejar los casos con un origen psicosomático, evitando la derivación de estos. *Reposo está contraindicado (sólo en casos de lumbago agudo y sobrecarga laboral, y por no más de 2-3 días) -Calor local, kinesioterapia motora en caso de lumbago crónico (contraindicado en lumbago agudo) -Paracetamol, AINES, AINES locales, relajantes musculares, opioides débiles. Considerar factores de riesgo y

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 62 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

			contraindicaciones, al momento de la prescripción -En toda etapa Educación, actividad física y control de peso.
LUMBOCIÁTICA	<u>Presencia de Banderas Rojas:</u> -Edad: <18 años o >65 años -Traumatismo en los últimos 30 días -Uso de corticoides a permanencia -Persona con osteoporosis difusa o fractura por compresión (hallazgo radiográfico) -Historia de cáncer: pulmón, mama, riñón, próstata -Dolor nocturno intenso que no remite o empeora en posición supina -Síndrome febril persistente o intermitente -Baja de peso -Inmunosupresión -VIH, Uso drogas intravenosas. **según red de derivación (nodos) <u>Derivar a fisiatría casos de persistencia de dolor severo, posterior a evaluación de Neurocirujano</u> (EVA >6) pese a manejo conservador >3 meses (Kinesioterapia motora, al menos 10-20 sesiones; manejo nutricional: Control de peso; dosis máxima de medicamentos) *Ver Protocolo de Lumbociática CIRA 2011	<u>Exámenes de laboratorio:</u> <u>Solicitar en caso de sospecha de causa específica:</u> hemograma, VHS, PCR, Fosfatasas Alcalinas, Ex. orina + urocultivo. <u>Radiografía columna lumbar AP y Lateral:</u> Solicitar en caso de sospecha de patología específica. *Considerar que después de los 40 años los cambios degenerativos son frecuentes y deben asociarse a cuadro clínico	-Reposo laboral es necesario, por 15 días. -Reposo en cama solo en casos de dolor incapacitante. Los pacientes deben recibir la indicación de mantenerse activos y continuar sus actividades diarias regulares. Reposo en cama no mayor a 2 días (EN CASO DE SER NECESARIO) -Tratamiento 1° línea: AINEs + Relajantes musculares por 5-7 días. -Tratamiento 2° línea: Paracetamol + Tramadol hasta próximo control. (En caso de no respuesta, contraindicación o intolerancia al tratamiento de 1° línea) -Derivación urgente en caso de Cauda equina.
SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	Derivación a Fisiatría: post cirugía en caso de persistencia del dolor y/o limitación funcional *Según red de derivación (nodos)		

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 63 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

FIBROMIALGIA	**Según red de derivación (nodos) -Cumpliendo con criterios diagnósticos ACR 2016 (descritos en observaciones) -Paciente fracasa a tratamiento, incluyendo amitriptilina y dosis de tramadol superior a 200 mg/día. (manejo según recomendaciones Orientaciones técnicas MINSAL) - *OTROS CASOS DEBEN SER MANEJADOS EN APS, A NO SER QUE EXISTA SOSPECHA DIAGNÓSTICA DISTINTA DE FIBROMIALGIA.	Paciente debe estar inscrito y bajo control en programa de Salud Mental APS previo a su derivación a HHA. Hemograma, Perfil Bioquímico, FR, Pruebas Tiroideas, Ck total, PCR. Radiografía en caso de sospecha de artropatía degenerativa asociada.	Se sugiere aplicar nuevos criterios diagnósticos de Clasificación Colegio Americano de Reumatología (ACR 2016)*. <u>Anexo N°7</u> Para el diagnóstico se debe cumplir todos los siguientes criterios: 1. Índice de dolor generalizado (IDG) >7; y, puntuación en la escala de gravedad de síntomas (EGS) >5 ó IDG 4-6 y EGS >9. 2. Dolor generalizado: presencia de dolor en al menos 4 de las 5 áreas descritas 3. Historia de síntomas de igual intensidad en los últimos tres meses. 4. El diagnóstico de fibromialgia no debe ser considerado de exclusión: es válido independientemente de otros problemas reumatológicos. La presencia de fibromialgia no excluye otras enfermedades clínicamente importantes. IDD: Dolor musculoesquelético generalizado en al menos 7 de las 19 áreas corporales evaluadas en el Índice de dolor Generalizado. Estos puntos dolorosos deben estar distribuidos en 4 de las 5 áreas corporales (superior derecha, superior izquierda, inferior derecha, inferior izquierda y axial)

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 64 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

FIBROMIALGIA (continuación)			<u>Escala de Severidad de Síntomas (ESS)</u> -Evalúa la presencia e intensidad de los 3 síntomas acompañantes fundamentales. -Graduados según importancia: 0 a 3 -Fatigabilidad -Despertar cansado por sueño de mala calidad - Trastornos cognitivos de la concentración y memoria reciente. - Síntomas asociados como cefaleas, dolor o calambres en la parte inferior del abdomen, síntomas depresivos que puntúan de 0 a 3. La ESS puede ir de 0 a 12 puntos - Antecedentes de Dependencia/abuso a Drogas, Patología psiquiátrica conocida, Usuario de psicotrópicos: Derivar a psicología- Psiquiatría (Programa de Salud Mental) -Paciente que, al examen físico, presente desnutrición (emaciación), poliartritis o pérdida objetiva de fuerza muscular; alteración de exámenes (VHS, PCR): Derivar a Medicina Interna, Reumatología o Neurología según clínica y sospecha diagnóstica.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 65 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

Pie diabético	Derivación a Fisiatría según red de derivación (nodos) -Pie diabético con ulcera plantar para indicación de bota de descarga. -Pie diabético con ulcera cicatrizada para indicación de plantilla y zapato -Pie diabético con riesgo alto y máximo, para indicación de plantilla y zapato	Exámenes: No	Observaciones -Todo paciente diabético debe recibir educación en cuidado de pies, para prevención de lesiones. - Pacientes con riesgo leve debe recibir indicación de zapatilla deportiva de buena calidad, punta ancha y amplia.
Amputados	Derivación a Fisiatría según red de derivación (nodos), de todo paciente con amputación independiente de su origen, priorizar pacientes con amputaciones mayores de EEII o EESS.	No	Previo a derivación iniciar manejo por kinesiólogo y terapeuta ocupacional (según disponibilidad) para manejo preprotésico.
Lesiones Medulares	Derivación a Fisiatría según red de derivación (nodos), de todo paciente con lesión medular para seguimiento.	No	Manejo integral en APS, con apoyo psicológico y de rehabilitación según corresponda.
ACV	Derivación a Fisiatría según red de derivación (nodos) - Con déficit funcional moderado y severo (no postrados) en etapa subaguda - Con dolor central o periférico, intensidad moderada a severa (EVA >6), sin respuesta a manejo en APS (paracetamol y tramadol en dosis creciente) - Con espasticidad moderada a severa (Ashworth >3), que interfiere con actividades en la vida diaria.	No	-Intervención por equipo de rehabilitación para manejo de déficit, dolor y espasticidad. -Manejo del dolor: aumento de dosis gradual hasta Paracetamol 500mg 2 c/8hrs, Tramadol 50mg (200mg al día, distribuida cada 6-8 hrs), Pregabalina o Gabapentina de estar disponible.
TEC	Derivación a Fisiatría según red de derivación (nodos) - Con déficit funcional moderado y severo (no postrados) en etapa subaguda - Con dolor central o periférico, intensidad moderada a severa		-Intervención por equipo de rehabilitación para manejo de déficit, dolor y espasticidad. -Manejo del dolor: aumento de dosis gradual hasta Paracetamol 500mg 2

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 66 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	(EVA >6), sin respuesta a manejo en APS (paracetamol y tramadol en dosis creciente) - Con espasticidad moderada a severa (Ashworth >3), que interfiere con actividades en la vida diaria.		c/8hrs, Tramadol 50mg (200mg al día, distribuida cada 6-8 hrs), Pregabalina o Gabapentina de estar disponible.
--	--	--	--

NEFROLOGÍA ADULTO

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN NEFROLOGIA NODO	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO MEDICINA INTERNA
Enfermedad renal crónica (VFG< 60 mL/min/1,73m2 y/o alteración morfológica ecográfica, o en examen de orina)	1. Pacientes en etapa 3a o 3b sólo si existen asociación a proteinuria (mayor a 1 gr/24 hrs y mayor de 3 grs/24 hrs en diabéticos, en 24 y/o hematuria glomerular (más de 10% glóbulos rojos dismórficos por campo). 2. Pacientes etapa 4 y 5. No derivar pacientes en etapa IV mayores de 85 años. Resto de los pacientes con ERC manejo por medicina interna de su nodo. Red de derivación: APS → Hosp. Digital (Med. Interna) → Nefrología	1. Registro de presión arterial 2. Creatinina plasmática 3. Orina completa 4. RAC y/o Albuminuria de 24 horas 5. Electrolitos plasmáticos 6. Si es diabético hemoglobina glicosilada y resultado de fondos de ojo (si lo tiene) 7. Perfil bioquímico. 8. Etapa V: marcadores virales hepatitis B, C y VIH y Ecografía renal según cartera de prestación del centro 9.- Validez de los exámenes 3 meses	Origen APS deriva a hospital digital policlínico de nefrología. Desde Hospital Digital, según corresponda, se redireccionará a Nefrología o Med. Interna. Link guía clínica IRC GES https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2014/12/Insuficiencia-Renal-cronica-terminal.pdf

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 67 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

Riñones poliquísticos	Derivar si presenta más de 2 quistes en cada riñón) por ecografía en menores de 60 años con historia familiar Red de derivación: APS → Hosp. Digital (Med. Interna) → Nefrología	1. Registro de presión arterial 2. Creatinina plasmática 3. Orina completa 4. Electrolitos plasmáticos 5. Ecografía renal	Origen APS deriva a hospital digital, policlínico de nefrología. Desde Hospital Digital, según corresponda, se redireccionará a Nefrología o Med. Interna.
Monorenos	Derivar SOLO si VGF menor 45 ml y/o proteinuria mayor de 1 grs en 24 horas. Haber sido donante renal. Red de derivación: APS → Hosp. Digital (Med. Interna) → Nefrología	1. Registro de presión arterial 2. Creatinina plasmática 3. Orina completa 4. RAC y/o Albuminuria 5. Electrolitos plasmáticos	Origen APS deriva a hospital digital policlínico de nefrología. Desde Hospital Digital, según corresponda, se redireccionará a Nefrología o Med. Interna.
Hipertensión arterial HTA resistente	HTA de reciente comienzo o empeoramiento en menores de 30 años, o mayores de 60 años Red de derivación: APS → Hosp. Digital (Med. Interna) → Nefrología	1. Registro de presión arterial 2. Creatinina plasmática 3. Orina completa 4. Electrolitos plasmáticos 5. Doppler renal según cartera de prestaciones 6. Función tiroidea	Origen APS deriva a hospital digital policlínico de nefrología. Desde Hospital Digital, según corresponda, se redireccionará a Nefrología o Med. Interna.
- Hematuria macroscópica -Quistes renales complejos. Bosniak 2 o más -Tumores renales -Litiasis renal	DERIVAR A UROLOGÍA		En el caso de litiasis renal, derivar a Nefrología solo si ha tenido más de tres episodios de cólicos renales objetivados

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 68 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

a) Derivar desde NODO por nefrólogo a Nefrología HHA

Biopsia renal	Con indicación de nefrólogo de nodo y estudio completo
Peritoneodiálisis	Con indicación de nefrólogo de nodo.
Estudio Pretrasplante	Con indicación de nefrólogo de nodo.

b) DERIVAR A URGENCIAS INMEDIATA, para hospitalización (con resolutiveidad nefrológica)

Diagnóstico	Observaciones
Criterios de urgencia dialítica	- Ph $\leq$ 7.0 sin respuesta a manejo médico - K⁺ >6.5 mEq/l o con cambios electrocardiográficos sin respuesta a tratamiento médico. - Sobrecarga de volumen refractaria a tratamiento (Edema pulmonar en paciente con oliguria o anuria) - Uremia >200 mg/dl con manifestación clínica: Encefalopatía, pericarditis, convulsiones - Intoxicación grave por sustancia dializable.
Glomerulonefritis rápidamente progresiva	Sospechar en caso de: - Edad entre 20 a 50 años - Insuficiencia renal progresiva a lo largo de semanas o meses; Sd. Nefrítico - Sedimento urinario Nefrítico, hematuria, pueden encontrarse hematíes dismórficos, cilindros hemáticos.

NEFROLOGÍA INFANTIL

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
ITU	1. ITU febril 2. ITU recurrente 3. ITU atípica 4. RVU	- Ecografía renal y vesical con medición de	- Revisar que técnica de toma de muestra del examen de orina sea la correcta

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 69 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	5. Trastornos miccionales que no respondan a uroterapia estándar y/o anomalías de la región dorsolumbar 6. Daño renal confirmado en estudios de imágenes o laboratorio (proteinuria, aumento de creatinina) 7. HTA 8. Retraso de crecimiento 9. Antecedentes familiares de enfermedad nefrourológica y/o ERC. Flujo de derivación: APS → Pediatría → Nefrología infantil	volumen vesical pre y post micción.	- Aporte adecuado de líquidos - Higiene genitoperineal - Evitar irritantes locales - Uroterapia estándar - Tratar constipación - Iniciar uroprofilaxis en: niños < 1 año después de su primera ITU febril, diagnóstico antenatal de malformación de la vía urinaria, RVU, patología obstructiva, ITU recurrente, disfunciones miccionales
PIELECTASIA/ HIDRONEFROSIS	1. Hidronefrosis prenatal con diámetro AP de la pelvis renal > 4 mm antes de las 33 semanas de gestación y > 7 mm después de las 33 semanas de gestación. 2. Hidronefrosis prenatal bilateral, asociada a dilatación del uréter, megavejiga, oligoamnios o monorrenos. Flujo de derivación: APS → Pediatría → Nefrología infantil	- Ecografía renal y vesical con medición de volumen vesical pre y post micción, 7-10 días después de nacer.	- Iniciar uroprofilaxis
PROTEINURIA/ HEMATURIA	1. Proteinuria glomerular primaria (síndrome nefrótico, nefropatía IgA o PSH, síndrome Alport, nefropatía membranosa, GN membrano proliferativa) y secundaria (postinfecciosa, LES, DM) 2. Proteinuria tubular primaria (síndrome Fanconi, enfermedad Dent y Lowe, enfermedades mitocondriales) y secundaria (tóxicos, NTA, nefritis tubulointersticial) 3. Proteinuria ortostática 4. Hematuria glomerular (postinfecciosa, nefropatía IgA o PSH, síndrome Alport,	- Hemograma - Creatinina, BUN, gases, ELP, albúmina, calcio, fósforo, ácido úrico - ASO, C3-C4 - Orina completa - Urocultivo - MAU, proteinuria, creatininuria en muestra aislada de orina - Ecografía renal y vesical con Doppler renal	- Evaluar presencia de edema, palidez, exantema, púrpura, masa abdominal, globo vesical - Peso, diuresis - Toma de PA con técnica correcta: niño sentado, permanecer en reposo al menos 5 minutos, brazo derecho descubierto, pies apoyados en el piso, manguito de PA a la altura del corazón - Descartar causas transitorias como: infecciones, deshidratación, fiebre, ejercicio intenso

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 70 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	nefropatía lúpica, GN membranoproliferativa, SHU) 5. Trauma renal 6. Patología intersticial (PNA, nefritis tubulointersticial, tumor renal, enfermedad poliquística, obstrucción pieloureteral, trombosis vascular) Flujo de derivación: APS → Pediatría → Nefrología infantil		
INCONTINENCIA/ ENURESIS	1. Incontinencia urinaria 2. Enuresis monosintomática 3. Enuresis no monosintomática Flujo de derivación: APS → Pediatría → Nefrología infantil	- Orina completa - Urocultivo - Ecografía renal y vesical con medición de volumen vesical pre y post micción	- Aporte adecuado de líquidos - Uroterapia estándar - Descartar ITU - Tratar constipación - Cartilla miccional
HTA	1. HTA primaria 2. HTA renovascular 3. Malformaciones renales congénitas (displasia renal, riñón poliquístico, hipoplasia renal, riñón único, uropatías obstructivas) 4. Enfermedades del parénquima renal (nefropatía por reflujo, cicatriz renal secundaria a ITU, SHU, glomerulonefritis crónica, nefropatía por PSH, nefropatía lúpica, tumor renal) Flujo de derivación: APS → Pediatría → Nefrología infantil	- Hemograma - Creatinina, BUN, gases, ELP, albúmina, calcio, fósforo, ácido úrico - Orina completa - Urocultivo - MAU, proteinuria, creatininuria en muestra aislada de orina - En pacientes con obesidad, dislipidemia o síndrome metabólico: perfil lipídico, glicemia en ayunas, insulina en ayunas - Ecografía renal y vesical con Doppler	- Toma de PA con técnica correcta: niño sentado, permanecer en reposo al menos 5 minutos, brazo derecho descubierto, pies apoyados en el piso, manguito de PA a la altura del corazón - Alimentación saludable - Comer sin sal - Realizar actividad física - Suspendir medicamentos y/o drogas que aumenten la PA

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 71 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
CONTUSIÓN o FRACTURA DE COLUMNA	- Si radiografía muestra alteración traumática evidente, derivar a URGENCIA CON NEUROCIRUJANO. - Sí radiografía es normal y paciente persiste con dolor más de 30 días, realizar tomografía axial y derivar a policlínico.	Tomografía axial computada según cartera de prestaciones.	—
LUMBOCIÁTICA - HNP	Dolor lumbociático o lumbocruralgico, vale decir, con signos de Lassegue o O'Connell (por ende, se excluye lumbago), de más de 6 semanas.	Derivar con estudio de resonancia magnética. si no es posible, tomografía axial computada como segunda opción según cartera de prestaciones.	En caso que el paciente tenga un déficit radicular motor o síndrome de Cauda equina, derivar al servicio de urgencia con Neurocirujano de turno. En este caso no es necesario el estudio previo con RMN o TAC de columna.
SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	Sin posibilidad de resolución quirúrgica desde Neurocirugía. Derivar a Traumatología de mano.	Derivar con electromiografía concluyente según cartera de prestaciones.	
TEC	Paciente con antecedentes de TEC (manejado inicialmente por urgencia) y que se encuentre	Solicitar TAC cerebro sin contraste con ventana ósea según cartera	

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 72 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	sintomático en forma posterior al alta	de prestaciones	
TUMOR CEREBRAL O DE CALOTA CRANEANA	Con diagnóstico de Proceso expansivo intracerebral o de calota, mediante TAC y RMN cerebro. Si tiene sintomatología de hipertensión endocraneana DERIVAR AL SERVICIO DE URGENCIA. De otra forma derivar al policlínico. *Activar GES según sospecha Dg.	TAC o RMN cerebro indispensable . Realizar según cartera de prestaciones	Guía Clínica AUGÉ Tumores Primarios del Sistema Nervioso Central en >15 https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2014/12/Tumores-Sistema-Nervioso-Central.pdf
RAQUIESTENOSIS CERVICAL, DORSAL O LUMBAR	Sintomatología de claudicación neurogénica, déficit radicular o medular según sea la ubicación de la raquiostenosis. Derivar al policlínico de Neurocirugía	TAC o RMN del segmento de la columna estenótica según cartera de prestaciones	Solicitar priorización si existe signos de compresión medular. En caso que el paciente tenga un déficit radicular motor o síndrome de Cauda equina mantenido, derivar al servicio de urgencia con Neurocirujano de turno. En este caso no es necesario el estudio previo con RMN o TAC de columna.
ANEURISMA CEREBRAL NO ROTO. MALFORMACION ARTERIOVENOSA CEREBRAL NO ROTA.	Derivar al policlínico de Neurocirugía paciente con hallazgo de aneurisma cerebral o antecedente de cirugía de aneurisma.	TAC cerebro con contraste, AngioTAC cerebro o RMN cerebro que demuestre presencia de aneurisma cerebral.	Todos los aneurismas cerebrales y malformaciones arteriovenosas cerebrales son prioridad 1 en atención en el policlínico de Neurocirugía
HIDROCEFALIA ADULTO O INFANTIL	Paciente con diagnóstico de Hidrocefalia con TAC o RMN cerebral. Si la hidrocefalia es aguda, deberá	TAC y/o RMN de cerebro según cartera de prestaciones	Los seguimientos de hidrocefalia operada en otras regiones se pueden derivar siempre y cuando vivan en nuestra región.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 73 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	derivarse de URGENCIA al Neurocirujano de turno		
--	---	--	--

NEUROLOGÍA INFANTIL

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN CDT HHA	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
TEA	- Niños mayores de 1 año - Que cumplan criterios clínicos del Diagnóstico de TEA del DSM-V - Requiere la evaluación previa por Pediatra general o médico de familia (donde se cuente con la especialidad) - Evaluación por Fonoaudióloga (Deseable) - Evaluación por Terapeuta ocupacional. (deseable) - Aplicación de M-CHAT, Q-CHAT, u otra escala de screening.	- Informe Fonoaudiológico - Informe de Terapia Ocupacional - Informe de M-CHAT - ADOS-2 (deseable solo en caso de ser factible)	- Derivación a Sala de Estimulación - Derivación a Jardín o a escuela con PIE. - Derivación a Terapia Fonoaudiológica - Derivación a Terapia Ocupacional - Derivación Psicología
CEFALEA	Derivar cefaleas primarias (migrañas con o sin aura y tipo tensión) después de: - 3 meses de tratamiento preventivo efectivo que continúa con frecuencia e intensidad que afecte la calidad de vida - Sospecha de Cefaleas secundarias no aguda y/o de curso progresiva Cefalea que aumenta su severidad y/o frecuencia en forma progresiva	El diagnóstico de cefalea tensional y migraña es básicamente clínico y no requiere de exámenes de laboratorio. En casos de sospecha de otras etiologías se podrá solicitar: - Screening de infección	Flujograma Cefaleas: Anexo N°9

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 74 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	Cefalea crónica diaria que cambia sus características Cefaleas asociadas a síndromes neurocutáneos Unilateralidad estricta Todo niño con cefalea recurrente menor de 5 años Todo niño con cefalea asociada a macrocefalia Cefalea no aguda con focalidad neurológica Cefalea aguda con signos de alarma, deben evaluarse en S. Urgencia Infantil: (Cefalea de inicio explosivo, cefalea con fiebre y signos meníngeos, cefalea con focalidad neurológica, cefalea con edema de papila, cefalea con diplopia aguda, cefalea con compromiso de conciencia)	(Hemograma, PCR, VHS) - RX de cavidades perinasales y cavum	
EPILEPSIA y CRISIS FEBRILES	- Primera convulsión febril en menor de 18 meses. - Primo convulsión no provocada - Convulsiones febriles o epilépticas con cambio importante en sus características (patrón de crisis) o aumento importante del número de crisis. - Sospecha de enfermedad subyacente: encefalitis, meningitis, lesiones postraumáticas, (maltrato infantil) etc. - Alteración nueva del examen neurológico - Primoconvulsión no provocada que consulta días después de evento, derivar a CDT.	Niveles Plasmáticos de FAE, en sospecha de mala adherencia, si ya están en tratamiento y ante sospecha de intoxicación por fármaco o crisis repetidas.	Guías GES epilepsia no refractaria en menores de 15 años Flujograma de derivación del niño con epilepsia en la Red Asistencial: Anexo N°8

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 75 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	- Crisis en relación a síndrome neurocutaneos. En paciente con Epilepsia en tratamiento: - En caso de cambio en el patrón de crisis - Aumento de la frecuencia habitual de las mismas. - Si es portador de epilepsia no refractaria, sin crisis y sin RAM, control anual por especialidad, según Protocolo GES.		
TDAH	- Todo niño que presente los criterios diagnósticos (DSM-V) y que genere un grado de desadaptación escolar, social y/o familiar clínicamente significativo (y no sólo responder a la percepción de “niño inquieto” por los profesores o los padres) debe ser derivado según el siguiente flujo. - Se adjunta flujograma. - Evaluación por medico de atención primaria, para realizar confirmación de criterios diagnósticos y realizar la derivación con neurología infantil con los siguientes antecedentes:	- Informe escolar académico y conductual. - Notas semestre previo. - Test de Conners (anexo 1) para profesores. - Psicometría WISC-V completa, incluyendo pauta de evaluación (del colegio o APS). - Informes de otros profesionales de la salud, si se encuentra en tratamiento (psicólogos, fono, TO)	Respecto al abordaje en atención primaria, la coordinación en APS puede estar a cargo de médico pediatra, familiar o general, según la disponibilidad en cada centro. Sera función del médico realizar las recetas a partir del segundo mes de instaurado el tratamiento, supervisar respuesta a tratamiento, presencia de efectos adversos y comorbilidades. Se sugiere realizar controles en APS cada 4 meses y en caso de que se

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 76 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

		- Otros (considerados pertinentes por medico APS).	requiera, debe gestionar control anticipado con neurología infantil. Es función de farmacia en cada centro gestionar la disponibilidad de los medicamentos. (Metilfenidato) - Flujograma TDH: Anexo N°9 - Escala de evaluación abreviada de Conners para profesores: Anexo N°10
Retraso del desarrollo psicomotor	- Ante la sospecha de déficit del DSM, ya sea riesgo o retraso en alguna de sus áreas, sumado a antecedentes y/o hallazgos al examen físico que hagan sospechar la presencia de patología, se debe evaluar cada caso y según flujogramas de derivación establecidos por el Ministerio de Salud de Chile, se debe realizar derivación a médico de APS y posterior derivación a especialista. -Regresión del DSM	aplicación de instrumentos durante determinados controles de salud en la APS para la prevención primaria del déficit de DSM en menores de 6 años y de prevención secundaria de RDSM, las que se encuentran a cargo del Programa Chile	

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 77 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

		Crece Contigo y corresponden a: 4 meses: Pauta breve de evaluación del DSM. 8 meses: Escala de evaluación del desarrollo psicomotor (EEDP). 12 meses: Pauta breve evaluación del DSM. 18 meses: Pauta breve evaluación del DSM y EEDP. 3 años: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI).	
--	--	---	--

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 78 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

NEUROCIRUGÍA PEDIÁTRICA

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN CDT HHA	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
SOSPECHA CRANEOSINOSTOSIS	- Deformación craneofacial, incluyendo las posicionales	Exámenes imagenológicos si los tiene	Adjuntar curva crecimiento craneano
DISRAFIA	Disrafia encefálica y espinal - Dg prenatal - Disrafia abierta al nacer - Estigmas de disrafia oculta	Ecografía lumbar en menores de 4 meses. Idealmente RM en eco alterada o disrafia de alto riesgo	Disrafia abierta al nacer debe enviarse a Servicio de Urgencia HHA
TUMORES SNC	- Todos las sospechas o confirmación de tumores SNC encefálicos o columna.	Exámenes de imagen si las tiene, idealmente TAC o RMN	- Si déficit neurológico o síndrome hipertensión intracraneana derivar a Servicio Urgencias HHA
HIDROCEFALIA	- Sospecha o confirmación de hidrocefalia de cualquier causa	Exámenes de imagen si los tiene: TAC o RMN cerebro	Si clínicamente tiene hidrocefalia aguda, derivar a Servicio de Urgencias HHA
MACROCEFALIA Y MICROCEFALIA	- Derivar a Neurología pediátrica	TAC cerebro sin contraste	-

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 79 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

NEUROLOGÍA ADULTO

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR	- ACV no en Agudo y ya confirmados - Los casos en agudo, menos de 14 días deben ser derivados a Urgencia y hospitalizados según GES. - De acuerdo a la guía GES, todo paciente que ha sufrido un ACV isquémico o CIT debe ser controlado por especialista (neurólogo) a los 10 días post al alta (ingresar al momento de diagnóstico a GES lo cual puede realizar medico general de urgencia)	-ECG -Perfil lipídico - Hb Glicosilada - Bioquímico y ELP - Hemograma - TSH - Orina completa y URC - PCR	En caso de no estar en agudo y ser nueva consulta dentro del mes de ocurrido ACV considerar hospitalizar en lugar de origen en caso de: 1. Trastorno deglutorio importante 2. Deficit neurológico severo 3. Síndromes confusionales 4. Complicaciones médicas o neurológicas: Hipertensión y/o Diabetes mal control, infecciones intercurrentes (neumonía, ITU), TVP, progresión deficit, convulsion.
CEFALEA	1.- Derivar cefaleas primarias (migrañas con o sin aura y tipo tensión) después de: ● 3 meses de tratamiento preventivo efectivo que continúa con frecuencia e	-Hemograma con VHS -Perfil bioquímico y ELP -Perfil tiroideo	

	intensidad que afecte la calidad de vida 2. Cefalea de rebote o abuso de fármacos (ergotamina/cafeína). 3. Cefalea aguda con banderas rojas, deben evaluarse en urgencia con neuroimágenes y otros exámenes pertinentes según sospecha diagnóstica		
EPILEPSIA	1. Primoconvulsión debe ser evaluada en urgencia. 2.- Primoconvulsión que consulta 7 días después de evento, con evolución favorable y estable derivar a policlínico de especialidad. 2. En pacientes de riesgo derivar a urgencia: -Usuarios de anticoagulantes -Embarazadas -TEC reciente. 3. En paciente con Epilepsia en tratamiento: -En caso de cambio en el patrón de crisis - Aumento de la frecuencia habitual de las mismas. -Si es portador de epilepsia de varios años de evolución, sin crisis y sin RAM, control anual por especialidad (Excepto embarazadas, quienes	-Hemograma -Perfil Bioquímico -EKG en mayores de 50 años - Niveles Plasmáticos de FAE si ya están en tratamiento y ante sospecha de intoxicación por fármaco o crisis repetidas.	- Primera convulsión debe evaluarse de urgencia -Si se sospecha evento convulsivo, venir con testigo o con relato de quien fue testigo. -Si tiene claro factor de riesgo para tener epilepsia secundaria como: 1. Antecedente de ACV antiguo y crisis focales 2. TEC grave antiguo ya estudiado - Puede iniciar Fármacos antiepilépticos : ácido valproico 20-30 mg/kg/día o Levetiracetam 500 o 1 gramo cada 12 horas según características de paciente y antecedentes, previo exámenes Hemograma, perfil hepático, perfil renal y control de laboratorio a

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 81 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	requerirán control trimestral idealmente) y semestral en APS.		los 15 días de iniciado tratamiento. - Paciente portador de epilepsia estable, control semestral con seguimiento de seguridad por fármacos en APS y anual por especialidad
TEMBLOR NO ESPECIFICADO	1. Temblor asimétrico asociado a: - Rigidez - Bradicinesia - Inestabilidad postural Derivar como sospecha Enf. De Parkinson o Parkinsonismo (GES) 2. Temblor esencial refractario a tratamiento o con RAM o contraindicación a fármacos disponibles para este cuadro en atención primaria.	-TSH - T4 libre - Hemograma - Perfil hepático, función renal, glicemia.	Descartar y en caso estar indicados suspender fármacos conocidos potenciales inductores o exacerbadores de temblor y Parkinsonismo (antipsicóticos, bloqueadores canales de calcio, ISRS según cada caso). Iniciar tratamiento para temblor esencial en APS con laboratorio y EKG previo (propanolol, primidona) y derivar en caso de refractariedad.
VÉRTIGO DE ORIGEN CENTRAL	1. Vértigo (sensación de giro objetivo o subjetivo) recurrente asociado a: -hipoacusia progresiva de más de 6 meses de evolución derivar a otorrinolaringología - Compromiso de 5° o 7° par craneano (sospecha de Tumor de ángulo pc) Derivar a neurocirugía. 2. Vértigo asociado a nistagmus bi o multidireccional: de menos de 2 semanas de evolución	-Si es realmente vértigo recurrente asociado a acúfenos y/o hipoacusia derivar a otorrino.	-Si es mareo u oscilopsia indagar gatillantes (postural, estrés, etc); -Estudiar y corregir factores como hipotensión, bradicardia, anemia, etc.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 82 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	derivar a urgencia por sospecha de ACV como causa más frecuente de vertigo central agudo. De más de 2 semanas derivar a CDT	-El único síndrome vestibular agudo neurológico es el de causa vascular y es mejor tolerado que el vestibular, pero destaca nistagmus bi o multidireccional, signos cerebelosos o de tronco asociados, en cuyo caso debiera ser derivado a urgencia.	
--	---	--	--

NUTRICIÓN INFANTIL

PATOLOGIA	CRITERIOS DE DERIVACION CDT HHA	EXAMENES PREVIOS PARA DERIVACION	OBSERVACIONES /SUGERENCIAS MANEJO APS
MALNUTRICIÓN POR EXCESO	Niños, niñas y adolescentes hasta 15 años de edad que presenten Obesidad asociada con: · Retraso del desarrollo sicomotor o deterioro intelectual · Presión arterial mayor al percentil 90 para la edad, sexo y talla · Dislipidemia persistente con manejo nutricional adecuado de 6 meses.	Derivar siempre con exámenes recientes (idealmente <3m): Glicemia – perfil lipídico – TSH - pruebas hepáticas) y ecografía Abdominal según disponibilidad.	–

	· IMC $\geq +3$ DS +2 o más - FR CV o SD metabólico con intervención en APS · Sospecha de Obesidad secundaria. · Síndrome de Cushing (cara de luna y/o dorso de búfalo, hirsutismo, HTA) · Síndromes genéticos · Apnea del sueño		
MALNUTRICIÓN POR DÉFICIT	Niños, niñas y adolescentes hasta 15 años de edad que presenten malnutrición por déficit asociada a: · Talla menor a - 2 DS · Vomitadores crónicos o sospecha trastorno deglución · Diarrea a repetición o crónica · Anorexia persistente o sospecha de trastorno de ingesta alimentaria · Anomalías específicas del examen físico o sospecha de genopatía · Retraso del desarrollo psicomotor · Distribución anormal de la grasa corporal · Signos carenciales	—	—
TRASTORNOS ALIMENTARIOS	Niños, niñas y adolescentes hasta 18 años de edad que presenten: · Sospecha o diagnóstico de ARFID (TERIA) o		

	anorexia nerviosa o bulimia u otro trastorno conducta alimentaria ·Existencia de conductas compensatorias inapropiadas que se presentan de manera repetida con el fin de no ganar peso como vómitos autoinducidos, abuso de laxantes, diuréticos, enemas, fármacos, ayuno y/o ejercicio excesivo con una duración mayor a tres meses.		
NECESIDAD DE NUTRICIÓN ENTERAL	Niños, niñas y adolescentes hasta 15 años de edad que presenten requerimiento de alimentación por sonda o gastrostomía por más de 3 meses, que presenten estado nutricional de riesgo o condición de salud crónica que pueda ser de riesgo (ej. fibrosis quística, DHC, entre otros)		

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 85 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

OFTALMOLOGÍA INFANTIL

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
Glaucoma congénito	Sospecha clínica por triada: epifora fotofobia blefarospasmo además de examen físico con megalocornea.	Evaluación por médico	contactar via correo electronico a la unidad de oftalmología con la exposición del caso y posterior a la generación de interconsulta → oftacdt@gmail.com
Alteración de rojo pupilar (Sospecha de catarata congénita, retinoblastoma, etc)	sospecha clínica por alteración de rojo pupilar evaluado previo al alta de recién nacido o al mes de vida.	Dos evaluación de rojo pupilar realizadas con 24 horas de diferencia en un ambiente adecuado, baja luminosidad. por médico.	derivación como patología ges, sospecha de cáncer infantil o catarata. catarata congénita plazos del ges no adecuados para tratamiento precoz que aseguren mejor pronóstico visual. contactar con oficina ges para priorización
Nistagmus	Paciente con nistagmus congénito. derivación al servicio de oftalmología. nistagmus adquirido	Examen físico y neurológico idealmente por pediatra.	Realizar una buena historia clínica preguntando por antecedentes de nistagmus congénito familiar, Derivar como patología ges como sospecha de estrabismo.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 86 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	agudo, derivación al servicio de urgencia infantil.		
Retraso de seguimiento y fijación en mayores de 2 meses	El lactante no fija ni sigue estímulos de alto contraste. repetir examen en dos oportunidades.	idealmente evaluación por pediatra previamente	derivar como paciente prioritario al servicio de oftalmología, enviar email a
Ambliopía	baja visión mono o binocular en examen de aps	si tiene una red de derivación uapo u Oftalmología	Derivar a uapo u Oftalmología. Si no hay mejoría en 6 meses de ambliopía derivar a oftalmopediatría (HHHA).
Estrabismo	cumplimientos de criterios de sospecha guía GES de estrabismo.	evaluación de agudeza visual en mayores de 4 años. Motilidad ocular. cover test y rojo pupilar.	Guía clínica estrabismo en < 9 años (2010): http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Estrabismo-menores-9-a%C3%B1os.pdf
Obstrucción de vía lagrimal congénita	Ausencia de respuesta a manejo médico en mayores de 6 meses	Test de desaparición de fluoresceína en fondo de saco lagrimal.	sospecha de obstrucción de vía lagrimal, iniciar manejo médico: enseñar a los padres adecuado aseo párpados. compresiones de saco lagrimal 4 veces al día diez compresiones.
Ptosis congénita	compromiso de eje visual. ambliopía. Anisometropía.	evaluación de agudeza visual en mayores de 4 años.	si hay compromiso de eje visual, derivar como urgencia oftalmológica.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 87 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

		cover test , motilidad ocular.	
--	--	--------------------------------------	--

POLICLINICO DE GÉNERO

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES
TRASTORNO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO/INCONGRUENCIA DE GÉNERO/DISFORIA DE GÉNERO/DISCORDANCIA DE GENERO	06-19 años NNA que consulten por la necesidad de apoyo y consejería en la exploración de temas de identidad de género, o que en el transcurso de la atención de salud se detecte la necesidad NNA que ya han definido y/o asumido su incongruencia de género y que soliciten apoyo en el proceso de transición	No requiere	Derivación desde la red por profesional que haya realizado la atención; matrona, psicólogo, médico. No es requisito evaluación previa por psiquiatra. Considerar indicaciones Ordinario 1206 del 12 de mayo de 2023

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 88 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

OTORRINOLARINGOLOGÍA

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
EPISTAXIS	1. Manejar portación de staphilococo aureus antes de derivar. 2. Optimizar manejo de rinitis alérgica. 3. Descartar patología coagulopatías.	Cultivo nasal.	Epistaxis masivas derivar a urgencia.
HIPERTROFIA ADENO AMIGDALIANA	1. Descartar rinitis alérgica o manejarla óptimamente, además de diagnóstico por examen físico (amígdalas semiobstructivas u obstructivas) y repetición de amigdalitis: 7 por 1 año, 5 por año por 2 años, 3 por año por 3 años.	Radiografía Cavum reciente	—
HIPERTROFIA AMIGDALIANA	Diagnóstico por examen físico: -Amígdalas semiobstructivas u obstructivas. -Repetición de amigdalitis: 7 por 1 año, 5 por año por 2 años, 3 por año por 3 años.	Exámenes de laboratorio generales	No derivar a cirugía infantil
HIPOACUSIA SENSORIAL	Hacer otoscopia previa: -Si hay tapón de cerumen removerlo con lavado de	- Audiometría	

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 89 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	oído según la edad y la posibilidad de realizarlo. -Requiere examen audiológico por lo que deben derivarse todos los pacientes. -Solo recién nacidos debe tamizarse con PEA o EOA	-Impedanciometria o potencial evocado auditivo extendido	
HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	Enviar con audiometría e impedanciometría	Audioimpedanciometria	
RINOSINUSITIS CRÓNICA	<u>Criterios 2 o más:</u> - Obstrucción / congestión nasal - Descarga anterior y posterior - Dolor/presión facial - Hiposmia / anosmia <u>Fracaso tratamiento</u> antibiótico de segunda línea (amoxi + ácido clavulánico o una Quinolona) <u>Presencia de pólipos</u>	2. Endoscopia, TC , RX según disponibilidad.	MANEJO APS SIN POLIPOS: - Lavado con solución salina - Corticoides tópicos (Mometasona 1 rociado en cada fosa nasal noche, controlar al 3 meses? - Uso de antibióticos en eventos agudos.

PSIQUIATRÍA PEDIATRICA Y DE LA ADOLESCENCIA

Para cualquier patología o sospecha de esta dentro de los criterios de derivación es necesario:

- Ingreso a programa de salud mental del paciente en su consultorio correspondiente y sugerir presentación a consultoría del nodo si paciente tiene los criterios de derivación próximamente comentados, si paciente tiene criterios de derivación a urgencias derivar a la urgencia correspondiente a su nodo (idealmente).

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 90 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

Al momento de derivación y presentación a Consultorías se requiere por parte de APS:

-Diagnóstico familiar y de redes por parte de APS (incluido el genograma, si es necesario visitas domiciliarias, presentaciones en los colegios, coordinaciones con otros programas.)

-Si se evalúan situaciones de vulneración de derechos es necesario hacer las **denuncias y derivaciones correspondientes a los sistemas legales** (Por parte de APS o por parte de los policlínicos de especialidad).

- Exámenes básicos: Hemograma, perfil lipídico, perfil hepático, perfil renal, perfil tiroideo, vitamina B12 y vitamina D.

Psicopatología	CRITERIOS DE PRESENTACION A CONSULTORIAS	Exámenes Previos para Derivación	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
Conducta Suicida	<u>Cuando se cumple con criterios de gravedad:</u> -Ausencia de adulto responsable -Grupo familiar caótico y disfuncional -Antecedente de suicidio en la familia -Presencia de patología psiquiátrica -Paciente institucionalizado -Revelación reciente de Abuso Sexual -Antecedente de Intento de suicidio Previo -Método alta letalidad	-hemograma - perfil lipídico -perfil hepático - perfil renal - perfil tiroideo - vitamina B12 y vitamina D según cartera de prestaciones.	*Intento Suicida reciente o alto riesgo suicida debe ser derivado a Urgencia Manejo en: -Pesquisa y diagnóstico -Seguimiento de suicidalidad leve-mod. Leve: Ideación de baja intensidad, frecuencia y duración. Sin planes ni intención. Síntomas leves, autocontrol presente, pocos factores de riesgo y existen factores protectores identificables. Moderada: Frecuencia e intensidad algo mayor pero limitada, algunos planes específicos pero vagos, sin intención, buen autocontrol, factores protectores identificables.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 91 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

TDAH			Manejo de APS: TDAH sin comorbilidad (o que presente trastorno de aprendizaje o DI sin problemas conductuales severos asociados) Pesquisa y diagnóstico, psicoeducación, Entrenamiento parental, intervención en factores psicosociales.
Trastorno de conducta oposicionista desafiante (TOD) y Trastorno explosivo intermitente de conducta disocial.	Derivación a especialidad: - Paciente de difícil manejo con escasa o nula respuesta con intervención psicoterapéutica en APS (al menos seis meses de intervención/8 consultas). - Pacientes con respuesta parcial frente a intervenciones, con tendencia a la cronicidad - Pacientes con duda diagnóstica.	-hemograma - perfil lipídico -perfil hepático - perfil renal - perfil tiroideo	Manejo en APS: Pesquisa y diagnóstico, terapia individual, entrenamiento parental, psicoeducación, intervención en factores psicosociales, apoyo, y rehabilitación escolar.
Trastornos Ansiosos	- Trastorno ansioso que no responde o que responde parcialmente a intervención psicoterapéutica y farmacológica efectiva, durante al menos 6 meses de intervención (8 consultas) - Todo trastorno de pánico, todo	- vitamina B12 y vitamina D según cartera de prestaciones.	Manejo en APS: Pesquisa y diagnóstico, terapia individual (incluyendo psicoterapia y terapia farmacológica), entrenamiento parental, psicoeducación, intervención en factores de riesgo psicosociales.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 92 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	trastorno de estes post traumático, todo trastorno obsesivo compulsivo.		
Trastornos del animo	- Todo trastorno depresivo en menores de 15 años. - En mayores de 15 años: trastorno depresivo severo o refractaria a tratamiento según normas GES MINSAL.		Depresión leve o moderado en mayores de 15 años: Apoyo psicoterapéutico y psicofarmacológico según norma GES Minsal Guía Clínica AUGÉ Depresión en personas de 15 años y más: https://www.minsal.cl/portal/url/item/7222754637c08646e04001011f014e64.pdf
Trastorno afectivo bipolar	Todo trastorno afectivo bipolar debe ser evaluado por especialidad		
Trastorno esquizofreniforme	- Sospecha de primer brote psicótico, siempre que no cumpla criterios de derivación directa a servicio de urgencia (Agitación psicomotora activa, síntomas psicóticos activos de riesgo****).	-hemograma	Se puede contra referir al paciente siempre y cuando tenga 15 años o más, este estudiado, con un tratamiento estable y compensado.
Trastorno del espectro autista	- Trastorno del espectro autista con trastorno conductual que requiere tratamiento farmacológico para compensación.	- perfil lipídico -perfil hepático	Se puede contrarreferir a APS cuando el paciente tiene sus comorbilidades compensadas.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 93 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

Trastorno de conducta alimentaria	- Presentar en consultoría para seguimiento con equipo especializado.	- perfil renal - perfil tiroideo - vitamina B12 y vitamina D según cartera de prestaciones.	Derivar a Urgencia: **Pacientes con Trastorno de la Conducta Alimentaria en alto riesgo médico somático: -Desnutrición: IMC = o < de 14 o baja de peso > a 20% en los últimos 6 meses. -Complicaciones orgánicas severas - graves alteraciones familiares Derivar a APS cualquier TCA que este compensado.
Trastorno del desarrollo de la personalidad	- Presentar en consultoría cuando se asocian otras comorbilidades: Antecedente de intentos de suicidio y/o impulsividad marcada. - Pacientes que presentan poli consumo de sustancias o consumo con patrón abusivo. Comorbilidad psiquiátrica.		Manejo en APS: Pesquisa y diagnóstico, terapia individual, entrenamiento parental, psicoeducación e intervenciones psicosociales.
Trastorno por uso de sustancias	- Derivación a especialidad si cuenta con comorbilidad psiquiátrica importante.		Manejo en APS (siempre que no cumpla con criterios de derivación a urgencias*** descritas más adelante, intoxicación aguda ó Sd. Abstinencia) - Pesquisa y diagnóstico - Psicoeducación - Intervenir en factores psicosociales (familia, colegio) - Derivación según evaluación a programas especializados Guía AUGÉ Consumo perjudicial y

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 94 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

			dependencia de Alcohol y otras drogas en menores de 20 años: https://www.minsal.cl/portal/url/item/7222c0667853b8f8e04001011f016146.pdf Guía Clínica Detección y tratamiento temprano del Consumo problema y dependencia de Alcohol y otras sustancias en APS: http://www.repositoriodigital.minsal.cl/bitstream/handle/2015/589/4139.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Abuso sexual /Maltrato infantil	Manejo según guías minsal, presentación a consultoría por sospecha de psicopatología asociada		- Caso debe ser judicializado - Frente a la necesidad de terapia reparatoria priorizar acceso a red de protección y programas especializados (PRM) antes que derivación a especialidad

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A URGENCIA:

- **Intento suicida reciente**
- ***Alto riesgo suicida actual** / Intento de suicidio inminente:
Paciente con ideación suicida actual persistente, especialmente si hay elementos de impulsividad (autoagresiones o intentos de suicidios previos, consumo excesivo de alcohol y/o drogas, u otras conductas impulsivas interpersonales).
- ****Paciente con Trastorno de la Conducta Alimentaria en alto riesgo médico somático:**
Desnutrición: IMC = 0 < de 14 o baja de peso > a 20% en los últimos 6 meses.
Complicaciones orgánicas severas:
 - Alteraciones hidroelectrolíticas (principalmente K < 2,5).
 - Signos de deshidratación moderada-severa.
 - Hipoglicemia sintomática

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 95 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

- Bradicardia (FC < 50 lat/min).
- T° < 36,1°C
- Hipotensión (PA < 80/50).
- Ruptura esofágica.

Graves alteraciones familiares:

- Violencia familiar.
- Incapacidad de protección parental.
- Psicopatología severa de los padres.

- ***Niño, niña o adolescente con intoxicación por consumo de sustancias o

Síndrome de Privación:

Intoxicación aguda:

Cambios psicológicos o del comportamiento desadaptativos, clínicamente significativos, debidos al efecto de la sustancia sobre el sistema nervioso central (ej: irritabilidad, labilidad emocional, deterioro cognitivo, deterioro de la capacidad de juicio, delirium, convulsiones).

Se presentan durante el consumo de la sustancia o poco tiempo después.

Síndrome de Abstinencia:

Conjunto de síntomas que se presentan cuando hay una abstinencia absoluta o relativa de la sustancia, tras un consumo reiterado, generalmente prolongado o a dosis elevadas.

Tiene un comienzo y evolución limitados y relacionados con el tipo y dosis de sustancia consumida.

Puede presentarse con síntomas físicos (delirium, convulsiones) y/o psicológicos (e.g. ansiedad, depresión, trastornos del sueño, tr. psicótico).

- ******Agitación psicomotora activa:**

Paciente físicamente agresivo o con inminencia de actuar con agresividad física hacia sí mismo o terceros.

Paciente que no responde a la contención verbal ni ambiental por profesionales del consultorio.

- **Paciente con síntomas psicóticos activos que atenten contra su seguridad y/o la de terceros:**

Paciente que atenta contra su seguridad y/o la de terceros.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 96 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

Paciente con autoagresiones, con descuido de su alimentación y/o salud en general.

REUMATOLOGÍA ADULTO

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN CDT HHA	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
Artritis	Derivación a Reumatología sólo por Médico Internista referente por nodo en los casos que se cumplan criterios de derivación a alta complejidad (artropatía inflamatoria refractaria al menos 2 fármacos, con buena adherencia a tratamiento.	Hemograma, VHS, PCR, Perfil hepático, orina completa. Perfil inmunológico según patología sospechada.	
Artritis Juvenil			
Artritis Reumatoide			

TRAUMATOLOGÍA ADULTO

a) HOMBRO

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
Patología del mango rotador	Cualquier rotura en <60 años Falta de respuesta a manejo conservador bien llevado	Rx hombro AP verdadera, outlet y axilar Ecografía de hombro según cartera de prestaciones	Analgesia multimodal; Kinesiterapia motora: postura, control escapular, cadena cinética, fortalecer rotadores. Guía Clínica “Manguito rotador”, SSAS

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 97 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

Tenosinovitis bicipital	Refractario a manejo conservador Sólo pacientes que deseen cirugía	Rx hombro AP verdadera, outlet y axilar Ecografía de hombro según cartera de prestaciones	Analgesia multimodal; Kinesiterapia motora: postura, control escapular, cadena cinética, fortalecer rotadores, elongación bíceps
Tendinitis cálcica	Refractario a manejo conservador	Rx hombro AP verdadera, outlet y axilar Ecografía de hombro según cartera de prestaciones	Analgesia multimodal; optimizar patologías crónicas (especialmente DM2)
Artrosis acromioclavicular	Refractario a manejo conservador Sólo pacientes que deseen cirugía	Rx hombro AP verdadera, outlet y axilar Ecografía de hombro según cartera de prestaciones	
Artropatía mango rotador y artrosis glenohumeral severa	Refractario a manejo conservador Sólo pacientes que deseen una artroplastía	Rx hombro AP verdadera, outlet y axilar TAC de hombro según cartera de prestaciones	Agotar analgesia multimodal para artrosis antes de derivar (Paracetamol, Tramadol, Celecoxib)
Capsulitis adhesiva	Refractario a manejo conservador al menos 6 meses Sólo pacientes que deseen cirugía	Rx hombro AP verdadera y outlet	Educación al paciente en evolución normal de la enfermedad. Buscar dirigidamente diabetes e hipotiroidismo Iniciar cuando tolere (en etapa 3) Kinesiterapia motora: rango articular suave progresivo, postura, control escapular y luego cadena cinética + fortalecer rotadores
Inestabilidad glenohumeral	2 episodios de luxación Persistencia de dolor o aprensión tras kinesiterapia bien llevada	Rx hombro AP verdadera, outlet y axilar TAC de hombro	Kinesiterapia motora: postura, control escapular, cadena cinética, fortalecer rotadores y deltoides

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 98 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

b) RODILLA

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
Inestabilidad ligamentaria de la rodilla	Rotura LCA y LCP y esquinas PL y PM que requieren manejo quirúrgico	Rx rodilla y RM de rodilla lesionada según cartera de prestaciones. No solicitar ecografía	Guía Clínica “Rodilla Traumática” SSAS. Pauta de evaluación y manejo sugerido para el nivel primario.
Gonartrosis moderada a severa	Pacientes que podrían tener indicación quirúrgica	Rx AP, lateral, Rosenberg y Axial patelar de ambas rodillas. Rx panorámica de ambas EELL, no solicitar ecografía	Analgesia multimodal optimizar patologías crónicas (especialmente DM2, sobrepeso)
Meniscopatía de rodilla	Roturas meniscales confirmadas	Rm de rodilla lesionada según cartera de prestaciones, no solicitar ecografía	Guía Clínica “Rodilla Traumática” SSAS. Pauta de evaluación y manejo sugerido para el nivel primario.
Luxación recidivante de la rótula	"2 episodios de luxación Persistencia de dolor o aprensión tras kinesiterapia bien llevada"	Rx AP, lateral y axial patelar en 20 grados. TAC para estudio patelofemoral según cartera de prestaciones, no solicitar ecografía	

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 99 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

c) TUMORES

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
TUMORES MUSCULOESQUELETICOS POTENCIALMENTE BENIGNOS OSEOS Y DE PARTES BLANDAS DE EXTREMIDADES	Paciente con sospecha o diagnóstico de un Tumor musculo esquelético benigno Mediante clínica y exámenes de apoyo	-Radiografía -Ecografía de partes blandas según cartera de prestaciones -Tomografía computada -Resonancia magnética según cartera de prestaciones	Ante Sospecha Clínica Derivar . Su hay posibilidad de estudio de imágenes de apoyo al diagnóstico , hacerlas.
TUMORES MUSCULOESQUELETICOS POTENCIALMENTE MALIGNOS OSEOS Y DE PARTES BLANDAS DE EXTREMIDADES	Énfasis en Osteosarcoma que es GES y debe seguir normativa ministerial en su estudio, etapificación y tratamiento Metástasis ósea, incluido Fractura inminente o patológica Sarcomas de partes blandas de extremidades para Evaluación, Etapificación y tratamiento interdisciplinario	Imágenes de apoyo Diagnostico y Etapificación Radiografías Cintigrafías Tomografías sitio afectado y pulmonar Resonancia magnética según cartera de prestaciones NOTA: Si hay demora en exámenes Derivar sin exámenes	Ante Sospecha Clínica Derivar a brevedad Si hay posibilidad de estudio de imágenes de apoyo al diagnóstico , hacerlas siempre que no retrasen evaluación en HHA

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 100 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

d) CADERA

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
Coxartrosis moderada a severa	Pacientes que podrían tener indicación quirúrgica, que no responden a analgesia multimodal	Rx pelvis AP, centrada en pubis, medio fémur incluido no solicitar ecografía	Analgesia multimodal, optimizar patologías crónicas (especialmente HTA, DM2, sobrepeso)
Coxalgia	Estudio sugerente de patología de resorte quirúrgico (por ejemplo RM que muestre lesión labral)	Rx pelvis con hallazgos sugerentes de patología de resorte quirúrgico	Analgesia multimodal optimizar patologías crónicas (especialmente HTA, DM2, sobrepeso), fisio-kinesiología

e) PIE

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
Fasceitis plantar	Pacientes con fracaso de manejo en APS	Ecografía según cartera de prestaciones, radiografía (para diagnósticos diferenciales)	Énfasis en kinesiología adecuada, optimizar patologías crónicas (especialmente HTA, DM2, sobrepeso)
Hallux valgus	Clínica más imágenes compatibles con diagnóstico de hallux valgus	Rx ambos pies AP-lateral en carga más oblicuo	
Fractura de tobillo	Derivar vía urgencia		Guía clínica "Fractura de tobillo", SSAS.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 101 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

f) MANO

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
SINDROME TUNEL CARPIANO	Pacientes con sospecha clínica (dolor, adormecimiento, falta de fuerzas) <u>con fracaso de manejo en APS</u>	Electromiografía debe ser solicitada por especialista, en casos seleccionados ecografía o radiografía para descartar diagnósticos diferenciales	Énfasis en kinesiología, terapia ocupacional (confección de férula), optimizar patologías crónicas (especialmente HTA, DM2, sobrepeso)
DEDO EN GATILLO	Pacientes con sospecha clínica (bloqueo en flexión) <u>con fracaso de manejo en APS</u>	Ecografía	Énfasis en kinesiología adecuada, optimizar patologías crónicas (especialmente HTA, DM2, sobrepeso)
ENFERMEDAD DE DUPUYTREN	Pacientes con sospecha clínica (fibromatosis palmar)		Optimizar patologías crónicas (especialmente HTA, DM2, sobrepeso)

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA INFANTIL

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
ESCOLIOSIS	Paciente con escoliosis diagnosticada mediante radiografía de Columna total AP y lateral, medida	RX COLUMNA TOTAL AP Y LATERAL ACTUALIZADA, MEDICIÓN DE ÁNGULO DE COBBS	Pueden ser derivados a kinesiólogo para educación postural, fortalecimiento muscular dorsal y abdominal

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 102 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	con ángulo de Cobbs sobre 10*	POR MÉDICO GENERAL, Máximo 6 meses de duración.	
GENUVALGO	GENUVALGO patológico, corresponde a ex físico alterado en decúbito supino, con medición mayor a 6 cm de separación de distancia intermaleolar (tobillos)	Telerradiografía de extremidades inferiores con folio graduado actualizado 6 meses maximo.	En el desarrollo de la marcha es normal genuvaro hasta 2 años, genuvalgo fisiológico entre 3-7 años, recién a los 7 años se adquiere pattern normal del adulto, derivar genuvalgo persistente sobre 7 años, valgo asimétrico de extremidades.
GONALGIA	Gonalgia Aguda, menor a 3 semanas (sospecha de tumor, infección o trauma derivar a urgencia) y el resto a poli con Rx	Rx rodilla ap lateral oblicua y axial	Si es poliartralgia derivar a Reumatología infantil primero.
PIE PLANO CONGÉNITO	Corresponde solo a astrágalo vertical y barras tarsianas	RX PIE AP LATERAL Y OBLICUA BILATERAL ACTUAL, 6 meses de duración	Pie plano hiperlaxo es Benigno solo requiere kinesioterapia y manejo de peso.

UROLOGÍA ADULTO

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE DERIVACIÓN	EXÁMENES PREVIOS PARA DERIVACIÓN	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS MANEJO APS
UROLITIASIS	1. Litiasis renal > 5 mm 2. Litiasis ureteral o vesical, cualquier cálculo asociado a: •Hidronefrosis •Atrofia renal	- Hemograma - Glicemia - Función renal (crea, uremia, BUN) - Pruebas de coagulación Electrocardiograma *Se sugiere	*NO derivar sospecha de cólico renal sin evaluación con imágenes idealmente dado alto porcentaje de eliminación espontánea o ausencia de litiasis en derivación.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 103 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	•Alteración anatómica de vía urinaria.	Ecografía renal y pélvica ó PieloTAC según cartera de prestaciones	
HEMATURIA	1. Hematuria macroscópica ó microscópica (≥ 3 Glóbulos rojos por campo) en 2 ó 3 muestras de orina separadas por al menos 2 semanas de diferencia.	- Examen de orina y urocultivos realizados. - Ex de orina y UC actualizado, no mayor de un mes - Función renal (crea, uremia, BUN) - APE en hombres > 45 años *Según cartera de prestaciones, Ecografía renal y pelviana con antigüedad no superior a 3 meses ó UroTAC (idealmente este último)	Incorporar en la interconsulta antecedentes de complicación. En el caso de hombre mayor de 50 años, descripción del tacto rectal.
UROPATIA OBSTRUCTIVA BAJA (ADENOMA PROSTÁTICO/HIPE RPLASIA PROSTÁTICA/CÁNCER DE PROÓSTATA)	1. Síntomas del tracto urinario inferior moderados/ severos, sin disponibilidad de tratamiento médico 2. Pacientes con indicación quirúrgica 3. Sospecha de cáncer de próstata.	1. APE (>40 años) 2. Función renal 3. OC, urocultivo *Ecografía renal y pélvica según cartera de prestaciones	*NO derivar aumento de volumen prostático asintomático como hallazgo en ecografía. * En el caso de sospecha de cáncer de Próstata, enviar 2 resultados con 6 semanas de diferencia entre ambos exámenes. En los casos en que APE se encuentre entre 4 – 10 ng/ml, incluir fracción libre. - Resumen ejecutivo crecimiento prostático benigno: https://diprece.minsal.cl/le-informamos/auge/acceso-guias-clinicas/guias-clinicas-desarrolladas-utilizando-

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 104 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

			manual-metodologico/estudio-manejo-medico-y-quirurgico-de-pacientes-con-crecimiento-prostatico-benigno-sintomatico/resumen-ejecutivo/ - Guía Clínica GES crecimiento prostático benigno: Microsoft Word - Consolidado final CBP 261211.doc (bibliotecaminsal.cl) - Resumen ejecutivo GES Cáncer de próstata: https://diprece.minsal.cl/garantias-explicitas-en-salud-auge-o-ges/guias-de-practica-clinica/cancer-de-prostata/resumen-ejecutivo/
INCONTINENCIA DE ORINA DE ESFUERZO, VEJIGA NEUROGÉNICA	1. IO moderada/severa refractaria a tratamiento de primera línea 2. No disponibilidad de tratamiento 3. IO recurrente IO asociada a POP o cirugía/radioterapia previa.	-Orina completa, Urocultivo - Glicemia - HbA1C en diabéticos diagnosticados Función renal (crea, uremia, BUN) *Ecografía renal y pelviana según cartera de prestaciones)	—
VARICOCELE, HIDROCELE, QUISTE DE EPIDÍDIMO, ESPERMATOCELE	1. Varicocele G° III 2. Asociado a: • Atrofia testicular • Dolor crónico • Infertilidad	- Hemograma - Glicemia - Función renal (crea, uremia, BUN) - Pruebas de coagulación Electrocardiograma	—

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 105 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

	Adolescentes	*Ecografía testicular sugerido según cartera de prestaciones	
INFECCIÓN URINARIA RECURRENTE	Dos episodios separados de cistitis bacteriana aguda comprobados por cultivo y síntomas asociados dentro de los seis meses o tres episodios dentro de un año. Descartar Diabetes o compensar en caso de existir previo último control de exámenes.	- Examen de orina y urocultivos realizados. - Ex de orina y UC actualizado, no mayor de un mes - Función renal (crea, uremia, BUN) - Glicemia - HbA1 C (en diabéticos diagnosticados) *Se sugiere PieloTAC según cartera de prestaciones	
TUMOR TESTICULAR	- Sospecha clínica: Aumento de volumen testicular firme, no sensible, sin signos inflamatorios, casi siempre unilateral.	- Hemograma - Glicemia - Función renal (crea, uremia, BUN) - Pruebas de coagulación Electrocardiograma - Marcadores tumorales (βHCG, LDH, α fetoproteína) *Se sugiere: Ecografía testicular según cartera de prestaciones	Guía Clínica GES Cáncer de Testículo: https://diprece.minsal.cl/wr/dprss_minsal/wp-content/uploads/2014/12/C%C3%A1ncer-de-Test%C3%ADculo.pdf

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 106 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

VII. CONSIDERARACIONES

Estudios de imagen disponible en APS:

- Radiografía
- Mamografía desde 35 años con factores de riesgo, desde 40 años sin factores de riesgo.
- Ecografía mamaria complementaria a la mamografía desde los 40 años en los casos que sea sugerido por el radiólogo. Menores de 40 años, examen único ante sospecha de patología.
- Ecografía de abdomen, orientado mayormente ante sospecha de coleditiasis, seguimiento de familiares casos con Hidatidosis,

Procedimientos diagnósticos:

- Endoscopia Digestiva Alta, programa de resolutiveidad para estudio de Helicobacter pylori.

VIII. DISTRIBUCIÓN

Estas orientaciones deberán estar disponibles en todos los centros de atención ambulatoria, de todos los niveles, encontrándose disponible en las Subdirecciones Medicas respectivas o Dirección de áreas ambulatorias según corresponda.

IX. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

- Seguimiento de la pertinencia informada a través de RCE por los médicos al momento de realizar las atenciones. Este indicador será medido y comparado a corto y mediano plazo.

X. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Modificada	Descripción de Modificación	Nº documento que deja sin efecto

XI. DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

- No existe conflicto de interés entre los autores y/ o revisores y alguna institución que genere conflictos de interés deben ser declarado

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : mayo de 2024
		Página 107 de 107
		Vigencia: mayo de 2026

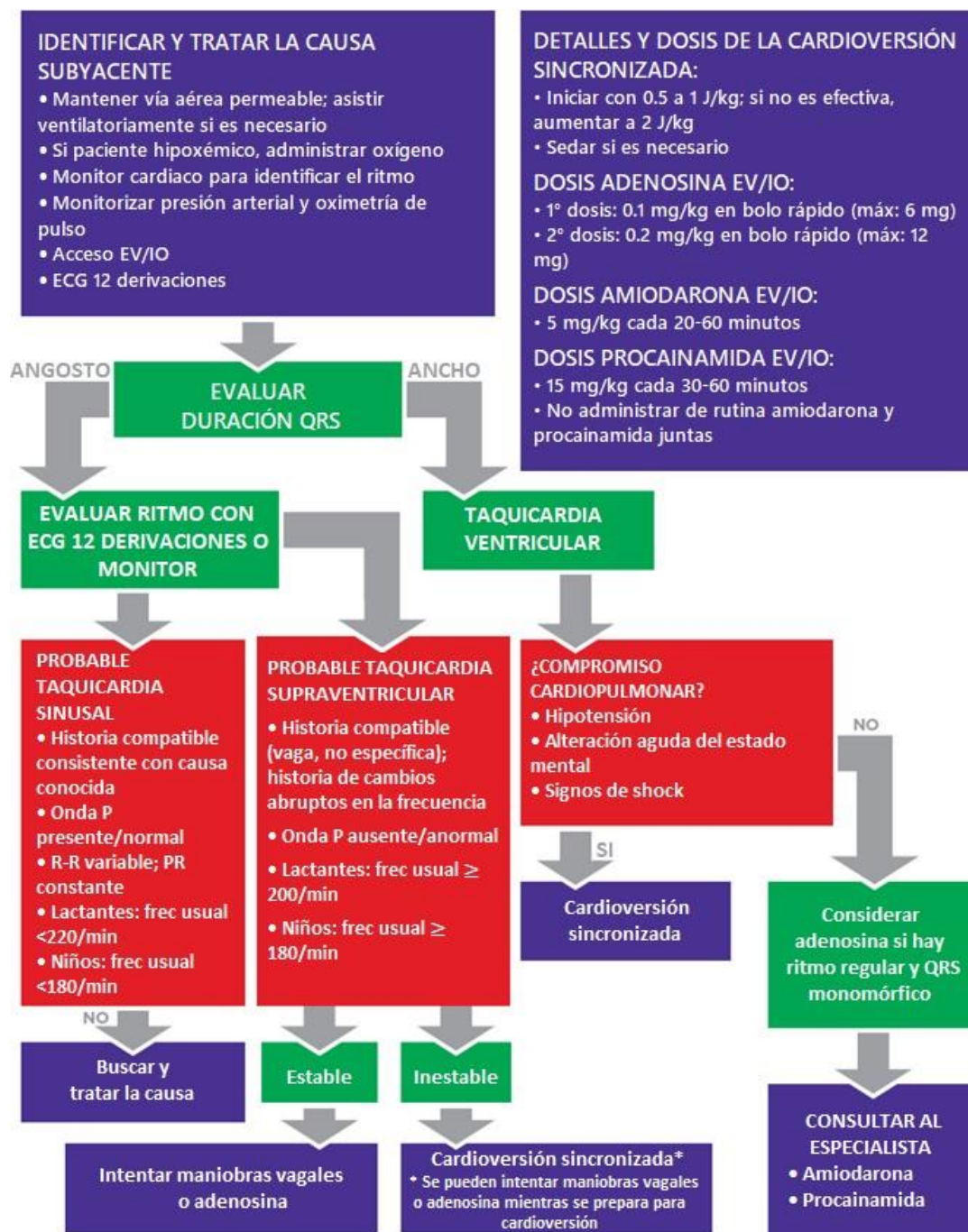
XII. ANEXOS

ANEXO N° 1. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO EN APS DE PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA, QUE NO CUMPLEN CRITERIOS DE DERIVACIÓN A HHA

Diagnóstico	Recomendaciones Manejo APS	Información Adicional
Soplo Funcional o Inocente	-Menores 6 meses: Con alta sospecha de estenosis fisiológica de ramas pulmonares control hasta los 6 meses, si persiste, derivar. -Entre 6 m y 2 años: Citar a control cercano en búsqueda de aparición de otros síntomas. (mayor frecuencia de soplos patológicos). -Mayores de 2 años: Evaluación del soplo en cada control de salud habitual. Educación a padres sobre la normalidad de su condición. Indicar vida normal.	Hasta un 80% de los niños presentan soplo en algún control de salud. Soplo inocente: Sensible a los cambios de posición o la respiración, No holosistólico, No asociado a click o galopes, limitado a una pequeña área y no irradiados, Baja amplitud, No suena áspero, Ocurre sólo en sístole (excepto hum venoso). Ver Anexo 2: Soplo funcional, información para padres y pacientes
Palpitaciones	-Siempre tomar ECG -Evaluar causas extracardíacas (Anemia, hipertiroidismo, hipovolemia, embarazo, fiebre, mala condición física, ansiedad, fármacos, otras). -Evitar estimulantes. -Control con registro de FC en domicilio con síntomas. -Educar a padres sobre naturaleza benigna de los síntomas.	En pediatría la asociación con patología cardíaca es baja y generalmente son secundarias a taquicardia sinusal. Siempre buscar criterios de alarma y tomar ECG. Enseñar a padres a tomar FC para que lo registren. Ver Anexo 3: Registro de FC, arritmias y palpitaciones.
Dolor Precordial	-Descartar causas extracardíacas. -Tomar ECG. -Educar a padres sobre naturaleza benigna de los síntomas. -Control si recurrencia.	La causa cardíaca es infrecuente en niños (1-5%). Anamnesis, examen físico permiten llegar al diagnóstico en la mayoría de los casos.
Síncope Neuromediado (vagal, situacional) u ortostático	Prevenir recurrencias: Aumentar consumo de líquidos, aumentar consumo de sal (si no hay otras contraindicaciones), reconocer pródromos y gatillantes. Evitar lesiones 2°: En período de estudio y tratamiento inicial evitar deportes con riesgo de lesiones graves ante caídas, si pródromos adoptar posición supina. Si recurrencia a pesar de indicaciones generales, evaluar tratamiento farmacológico y derivación. No suspender actividad física	Mayoría (60-70%) son neuromediados y las indicaciones generales son suficientes para evitar recurrencias. Ver Anexo 4: Síncope neuromediado, Información para padres y pacientes.

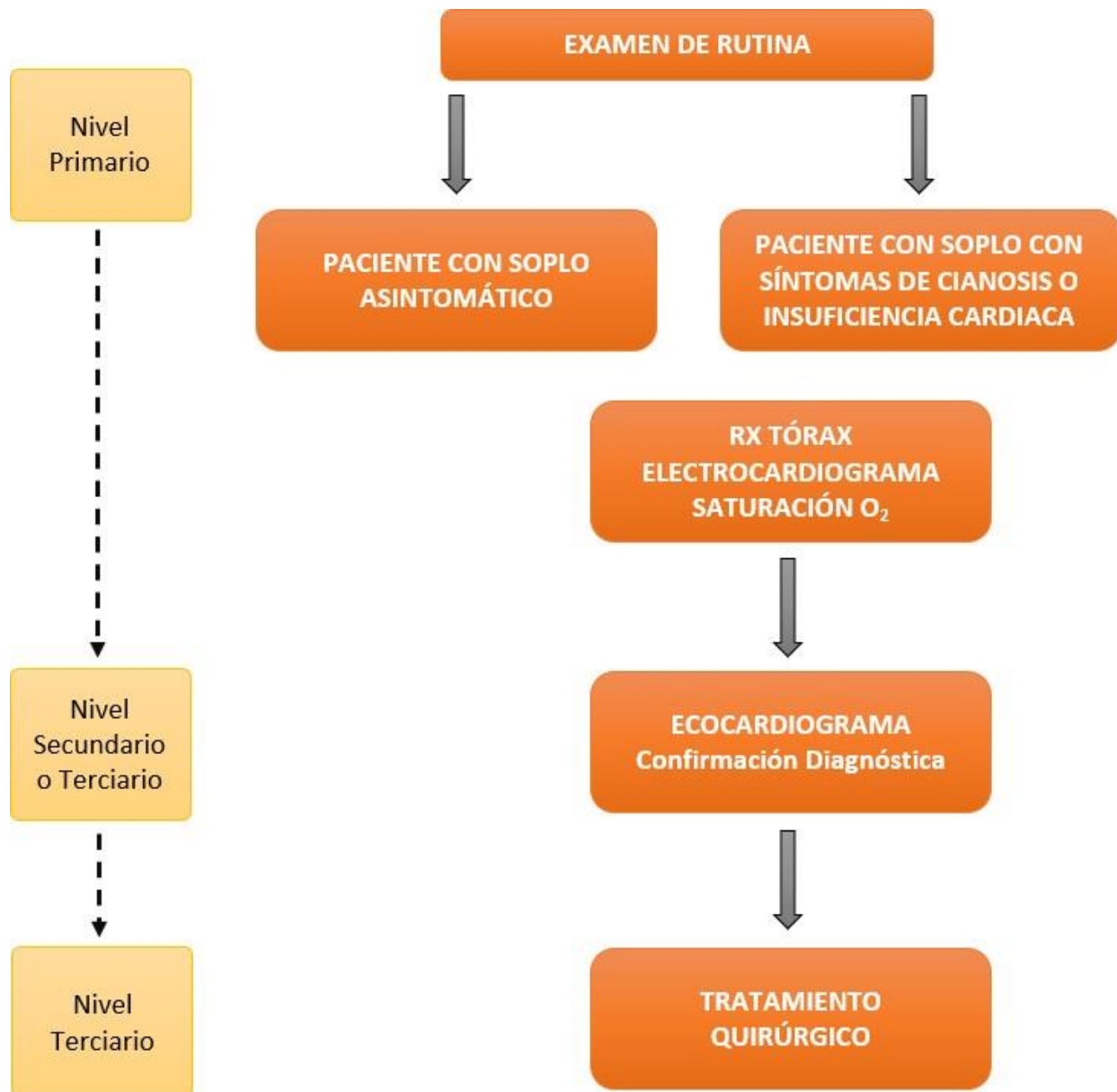
○ **FIGURA 1. ALGORITMO TRATAMIENTO TAQUIARRITMIAS**

(Diske K. Pediatric Advanced Life Support – Provider Handbook. Satori Continuum Publishing 2021)



○ **FIGURA 2 . ALGORITMO SOPLOS EN PEDIATRÍA**

MINISTERIO DE SALUD. Guía Clínica CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS OPERABLES EN MENORES DE 15 AÑOS.
SANTIAGO: MINSAL, 2010)



ANEXO N°2. SOPLO FUNCIONAL O INOCENTE, información para padres y pacientes.

**SOPLO FUNCIONAL O INOCENTE
INFORMACIÓN PARA PADRES Y PACIENTES**

- Se define **SOPLO** al ruido que se produce debido al paso de sangre por los vasos sanguíneos (venas y arterias) o el corazón.
- El tipo más habitual de soplo cardíaco en los niños es el denominado **FUNCIONAL o INOCENTE**. Esto implica que el soplo (ruido) es producido en un corazón normal y completamente sano.
- Puede aparecer y desaparecer a lo largo de la infancia.
- Habitualmente se modifica con los cambios de posición e incluso puede hacerse más intenso en estados febriles, ejercicios, ansiedad, etc.
- Suele desaparecer en la medida que el niño va creciendo y no tiene ningún riesgo para la salud.
- Los niños que tiene soplos funcionales no requieren seguir una dieta especial, restringir sus actividades o recibir algún tratamiento.
- A los niños que son bastante grandes para entender que tiene un soplo de este tipo, se les debe asegurar que no son diferentes a los demás niños y que pueden llevar una vida completamente normal.
- En el transcurso de la vida, como en todas las personas, pueden aparecer otras enfermedades cardíacas que pueden requerir control y que no están relacionadas con el soplo funcional.

**UNIDAD DE CARDIOLOGÍA INFANTIL
HOSPITAL HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA
TEMUCO**



REGISTRO FRECUENCIAS CARDIACAS - ARRITMIAS

Nombre paciente _____ **Edad:** _____

Diagnóstico: _____

[illegible]

ANEXO 4. Síncope Neuromediado. Información para padres y pacientes.

SÍNCOPE NEUROMEDIADO: INFORMACIÓN PARA PADRES Y PACIENTES

Su hijo es portador(a) de un trastorno denominado **síncope** (desmayo) **neuromediado**. Se presenta más frecuentemente en la adolescencia, es de **carácter benigno** y la mayor parte de las veces **desaparece con el tiempo**.

En este trastorno el sistema nervioso está inmaduro y en ciertas ocasiones “se equivoca”, produciendo **disminución en la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca**, lo que lleva al desmayo.

Una de las características de este síncope es que existen síntomas previos que **“avisan”** que se producirá el desmayo y que el paciente debe aprender a reconocer para poder prevenirlo, como palpitaciones, sudoración fría, náuseas, pérdida de visión o visión nublada, zumbido en los oídos y sensación de debilidad muscular.

Los síncope no debidos a una enfermedad, que son la mayoría de los casos, no necesitan ningún tratamiento. La mayoría mejora con el paso del tiempo y en casos muy infrecuentes pueden requerir algún medicamento.

Las recomendaciones a seguir son las siguientes:

1. Evitar situaciones que puedan provocar el síncope: Ayuno, largos periodos de pie, cambios bruscos de posición.
2. Es recomendable que el niño descanse y duerma un número de horas suficiente durante la noche.
3. Aumentar el consumo de agua diaria (al menos 2 litros al día).
- 3.- Consumir un producto con sal al día (maní, ramitas, papitas, etc).
4. Si presenta síntomas de aviso de síncope debe cambiar de posición lo antes posible para evitarlo:
 - a) Acostarse y levantar las piernas.
 - b) Flectar las piernas contra el abdomen y el tórax
contra el abdomen (hacerse ovillo).
5. Según se lo indique su médico deberá mantener control periódico.



ANEXO N° 5. Ficha de ITS y Consentimiento informado para registro de imágenes.

FICHA ITS

FICHA DE ITS

Nombre: _____ RUT: _____

Fecha de nacimiento: ____/____/____ Edad: ____ Nacionalidad: _____

Domicilio _____

Fono: _____

Escolaridad **ULTIMO AÑO APROBADO**

Básica	Completa	Sin Información
Media	Incompleta	
Superior o Técnica	Ninguna	

En caso de ser incompleta favor indique cuantos años cursó: _____

Ocupación actual: _____

ANTECEDENTES

1. Sexo

Hombre	Intersex
Mujer	Otro

2. Genero

Femenino	Transgénero
Masculino	Otro

3. Orientación sexual

Homosexual	Heterosexual
Bisexual	Ignorado

4. Número de parejas en los últimos 12 meses

Ninguna	2 a 4	Más de 10
1	5 a 9	

5. Uso de condón en los últimos 12 meses

Siempre	A veces	Nunca
---------	---------	-------

6. Hábitos **NICOTINA-DROGA-ALCOHOL**

No		
Si		Vía de Uso
Cual		Endovenoso
		Oral
		Respiratoria /inhalatoria

7. Embarazada

Si		Edad gestacional		FUR:	FPP:
No					

Antecedentes Obstétricos

Hijos vivos		Hijos Muertos		Total de Abortos	
				N° de Abortos últimos 12 meses	

Fecha de Ingreso prenatal: ____ / ____ / ____ N° de controles de embarazo: ____

Lugar de control		Publico	
		Privado	
		Otro	

8. Tipo de Consulta

Espontánea		Referida	
------------	--	----------	--

9. Referido por:

Control embarazo		Banco de Sangre	
Paternidad Responsable		Control especialidad	
Regulación de fertilidad		Examen de Salud	¿Cuál?

10. Alergias

Penicilina	
Otro	

11. Antecedente de lesiones genitales y /o dérmicas: ausencia o presencia (descripción, tiempo de inicio, localización)

--

12. Antecedente de contacto con otra persona cursando alguna ITS

--

13. Parejas declaradas últimos 12 meses

Nombre (INICIALES CORRESPONDE)	Y	RUT	SI	Fecha de Tratamiento (si corresponde)

Exámenes Basales (en caso de no tener registro, favor solicitar al menos VIH y RPR o VDRL)

Examen	Fecha	Resultado
VDRL		
RPR		
MHA-TP o FTA Abs		
GRAM		
CULTIVO NEISSERIA		
EXAMEN DIRECTO DE FLUJO		
CULTIVO CORRIENTE		
EXAMEN VIH		

En caso de embarazada:

Evolución serológica

Evolución serológica	Fecha	Edad gestacional	Resultado
1° VDRL			
2° VDRL			
VDRL PARTO			
OTRO VDRL			

**Consentimiento informado para registro por medio auditivo o visual para derivación
policlínico de infecciones de transmisión sexual vía telemática**

Se me ha solicitado en una evaluación médica, el registro por medio auditivo o visual (fotografías, video), de una parte de mi cuerpo, asociado al motivo de consulta, con el fin de solicitar opinión de un especialista a distancia, en el marco de las prestaciones de Unidad Hospital Digital. El médico especialista, emitirá su opinión respecto del diagnóstico de mi enfermedad, pronóstico y tratamiento.

Los registros serán tomados por el médico en el box y adjuntados en la plataforma virtual.

Al participar en esta consulta médica, yo estoy de acuerdo en que: Marcar con **x**

- ☐ Me tomen fotografías de lesiones, o heridas que son motivo de mi consulta.
- ☐ Que se me realice grabación de audio durante la sesión.
- ☐ Me graben en video durante la sesión.

Yo entiendo que:

- a) Los posibles riesgos de este registro incluyen:
 - Que no sean suficientes para el especialista y que requiera ser citado a una nueva atención y/o nuevas fotografías.
- b) Los posibles beneficios de este registro incluyen:
 - o El especialista de Hospital Digital puede evaluar en un periodo breve mis lesiones y/o heridas e indicar el tratamiento que requiero.
- c) Existen alternativas al presente registro de imágenes.
 - o No, ya que la descripción (en texto) de la lesión que no es suficiente para que sea evaluado.
- d) En caso de no aceptar el registro de imágenes puede suceder lo siguiente:
 - o El especialista no podrá realizar evaluación.
- e) En caso de requerir mayor información respecto de este registro, puedo solicitárselo a mi médico tratante.
- f) Yo podré revocar mi consentimiento en cualquier momento sin ser obligado/a dar razones y sin que esto me perjudique en mi calidad de paciente o usuario/a.
- g) Mi consentimiento está dado voluntariamente sin que haya sido forzado u obligado.
- h) El médico se compromete a eliminar las fotografías en un plazo máximo de una semana del dispositivo que fue utilizado, y asegura que las fotos serán usadas exclusivamente para el motivo de esta atención médica. En caso de PhotoDoc.
- i) Este procedimiento está sujeto a confidencialidad, conforme a las disposiciones de la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. El profesional tratante se compromete a proteger mi privacidad y respetar la confidencialidad de mis datos personales.

Nombre paciente	Nombre tutor legal	Nombre Médico responsable
Firma o huella	Firma o huella	Firma
Dirección	Dirección	Correo electrónico
Teléfono contacto	Teléfono contacto	Teléfono de contacto
Fecha		

ANEXO N° 6: Manejo de Nódulo Tiroideo

PAUTAS DE DERIVACIÓN SSAS

MANEJO DE NÓDULO TIROIDEO EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Documento elaborado por Dr. Adelqui Sanhueza Mardones
Médico Endocrinólogo HHAH – CAPLC - UFRO

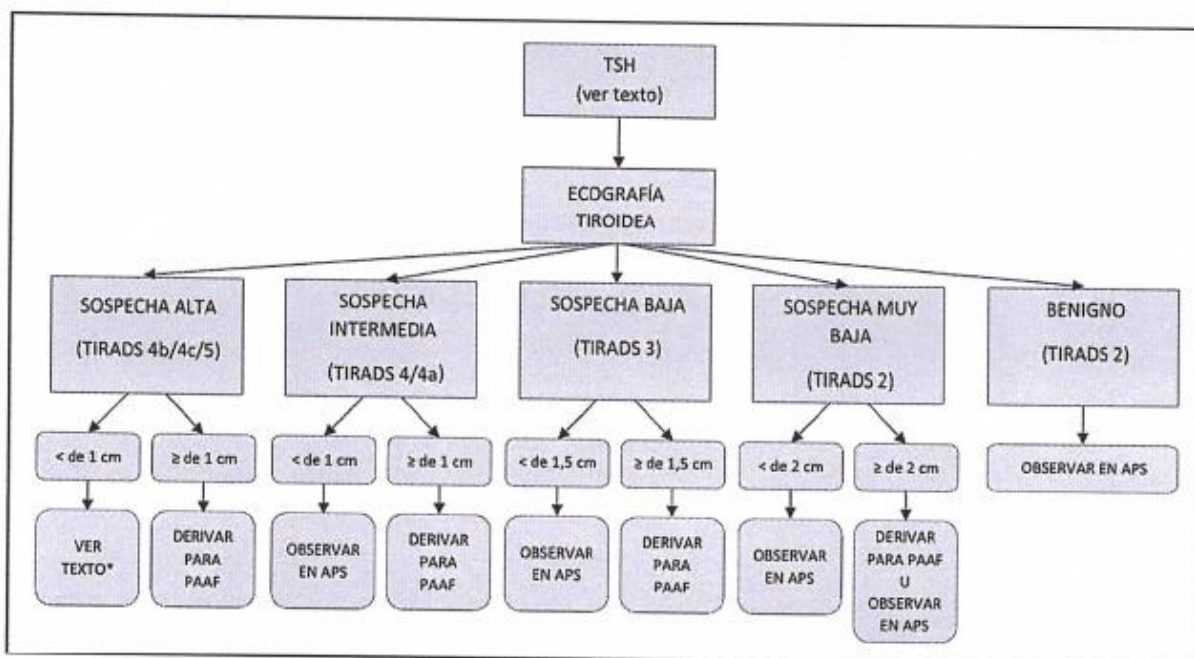
Con la finalidad de optimizar las derivaciones por nódulo tiroideo, se dispone esta pauta de derivación, con criterios a considerar en el manejo de los usuarios con esta patología.

1. Historia de cáncer de cabeza y cuello en la niñez y la irradiación del cuello
 - Irradiación corporal por trasplante de médula ósea
 - Cáncer de tiroides sindrómico (Cowden, poliposis adenomatosa familiar, Gartner, Carney, NEM 2, Werner, DICER – 1)
2. Hallazgos físicos de sospecha de malignidad:
 - Parálisis de cuerdas vocales
 - Ronquera
 - Linfadenopatía cervical
 - Nódulos fijos
 - Crecimiento rápido
3. Ecotomografía tiroidea → a quienes:
 - Bocios
 - Nódulos palpables
 - Nódulos incidentales (por ejemplo: TC cuello)

Aspectos a considerar en el Informe Ecográfico:

Tiroides: Contornos, características del parénquima (ecogenicidad y ecoestructura) y vascularización.

Nódulos: Ubicación, tamaño, contornos, ecoestructura, ecogenicidad y vascularización, presencia de micro y macrocalcificaciones.



Riesgo de malignidad	Características ecográficas	Indicación de PAAF
Alta sospecha o TIRADS 4b/4c/5 (70-90% de riesgo de malignidad)	Nódulo sólido hipoeogénico (o el componente sólido hipoeogénico de un nódulo mixto) con una o más de las siguientes características: • Márgenes irregulares • Microcalcificaciones • Más alto que ancho • Calcificaciones periféricas no continuas con permeación de tejidos blandos entre las calcificaciones • Extensión extratiroidea • Linfonodos sospechosos	Cuando sean $\geq$ de 1 cm Entre 5 y 10 mm, evaluar caso a caso necesidad de PAAF < 5 mm, no puncionar, salvo presencia de adenopatías con aspecto de metástasis o extensión extratiroidea, sospecha de compromiso traqueal o de nervio laríngeo recurrente
Sospecha intermedia o TIRADS 4/4a (10-20% riesgo de malignidad)	Nódulo sólido hipoeogénico con márgenes bien definidos (SIN microcalcificaciones, extensión extratiroidea o más alto que ancho)	Cuando sean $\geq$ de 1 cm
Baja sospecha o TIRADS 3 (5-10% riesgo de malignidad)	Nódulo sólido isoecogénico o hipereogénico o parcialmente quístico con áreas sólidas (SIN microcalcificaciones, margen irregular, más alto que ancho o extensión extratiroidea)	Cuando sean $\geq$ 1,5 cm
Muy baja sospecha o TIRADS 2 (< 3% de riesgo de malignidad)	Espongiformes (aspecto de múltiples microquistes que ocuparon > 50% del volumen nodular) o parcialmente quístico	Cuando sean $\geq$ 2 cm o también sólo se podría observar

Riesgo de malignidad	Características ecográficas	Indicación de PAAF
Benigna o TIRADS 2 (< 1% de riesgo de malignidad)	Nódulo quístico puro (sin componente sólido)	No requiere PAAF
Situación especial	Presencia de:	
	• Adenopatías sospechosas • Extensión extratiroidea • Compromiso Traqueal • Compromiso de Nervio laríngeo recurrente	PAAF siempre, independiente de tamaño
	Antecedentes:	
	• Síndromes familiares • Exposición a rayos antes de los 18 años	Se debe tener en consideración en la toma de decisiones

Consideraciones

*Examen inicial: Siempre se debe medir TSH. Si está elevada debería procederse a un estudio mayor con T4 libre y anticuerpos anti tiroideos.

**Nódulos altamente sospechosos (TIRADS 4b/4c/5) <1cm: Se recomienda observar. Derivar en caso de duda o en caso de situaciones especiales (ver tabla). Controlar con TSH y ecografía a los 6 meses y al año.

*** Nódulos de sospecha muy baja (TIRADS 2): Se recomienda observar. Derivar en caso de situaciones especiales (ver tabla).

**** Nódulos benignos (TIRADS 2) Control con TSH y ecografía tiroidea al año y al tercer año.

Tabla de seguimiento de nódulos cuando cumplen criterios de seguimiento en APS

ACR-TIRADS	6 meses	1 año	2 años	3 años	4 años	5 años
TIRADS 2		X		X		
TIRADS 3		X		X		X
TIRADS 4		X	X	X		X
TIRADS 5 <0,5cm	X (*)	X	X	X	X	X

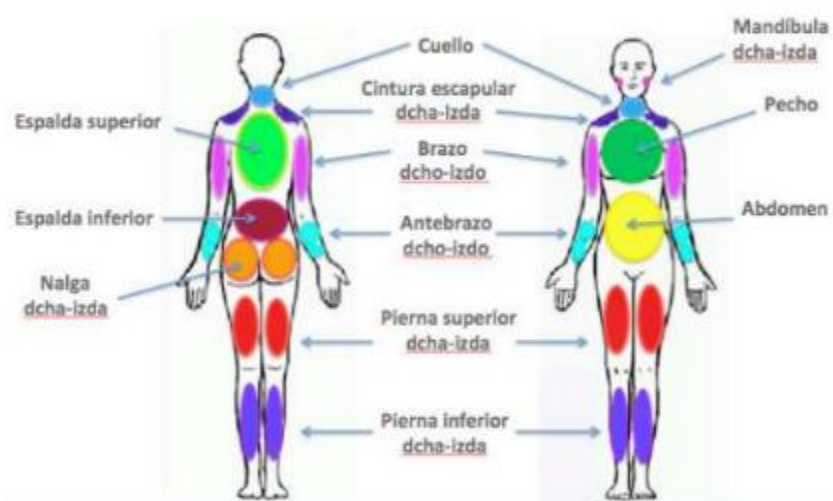
ANEXO N°7: Criterios Diagnósticos de Fibromialgia.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE FIBROMIALGIA (ACR 2010)

1. . IDG/WPI ≥ 7 y SS ≥ 5 ó
IDG/WPI ≥ 16 y SS ≥ 9
2. Síntomas mantenidos con similar
nivel los últimos 3 meses.
3. No haya otra causa que explique el dolor.

Índice de Dolor Generalizado, IDG/Widespread Pain Index , WPI

IDG = 0/19



Señale el número de áreas en las que ha tenido dolor en la última semana.

Compartir resultado		Nalga dcha	Pecho (tórax)
	Brazo superior izdo	Pierna superior izda	Abdomen
	Brazo superior dcho	Pierna superior dcha	Cuello
	Brazo inferior izdo	Pierna inferior izda	Espalda superior
	Brazo inferior dcho	Pierna inferior dcha	Espalda inferior
	Nalga izda	Mandíbula izda	
		Mandíbula dcha	

Índice Severidad de Síntomas /Symptom Severity Score

SSI1= 019

Indique el nivel de severidad de los siguientes síntomas durante la última semana.

0	Ningún problema
1	De leve a moderado, generalmente intermitente
2	De moderado a considerable, frecuente y de intensidad moderada
3	Severo, persistente, generalizado, con interferencia en las actividades diarias

Fatiga	0	1	2	3
Sueño no reparador	0	1	2	3
Trastornos cognitivos	0	1	2	3

Índice Severidad de Síntomas /Symptom Severity Score

SSI2 = 013

Señale cuáles de los siguientes síntomas **padece habitualmente**:

Sin síntomas = 0; Entre 1 y 10 síntomas, puntúa 1; De 11 a 24 síntomas, puntúa 2; 25 o más, puntúa 3

Dolor muscular	Dolor en la parte alta del abdomen	Convulsiones
Picores	Fatiga/cansancio extremo	Ojo seco
Visión borrosa	S. Intestino irritable	Sequedad bucal
Urticaria	Problemas para pensar o de memoria	Pérdida de apetito
Vómitos	Dolor/ calambres en el abdomen	Erupciones, sarpullido
Dolor de cabeza	Respiración entrecortada	Sensibilidad al sol
Dolor torácico	Pitidos al respirar, sibilancias	Trastornos auditivos
Ansiedad	Fenómeno de Raynaud	Entumecimiento, hormigueo
Mareos	Debilidad muscular	Caída de cabello
Insomnio	Zumbidos en los oídos	Micción frecuente
Depresión	Moratonos frecuentes (hematomas)	Micción dolorosa
Estreñimiento	Acidez de estómago	Espasmos vesicales
Diarrea	Aftas orales (úlceras)	Fiebre
Náuseas	Pérdida o cambios en el gusto	

SS1 = _____ SS2 = _____ IDG/WPI = _____ SS = _____

Índice Severidad de Síntomas /Symptom Severity Score
SS-1= 0-9

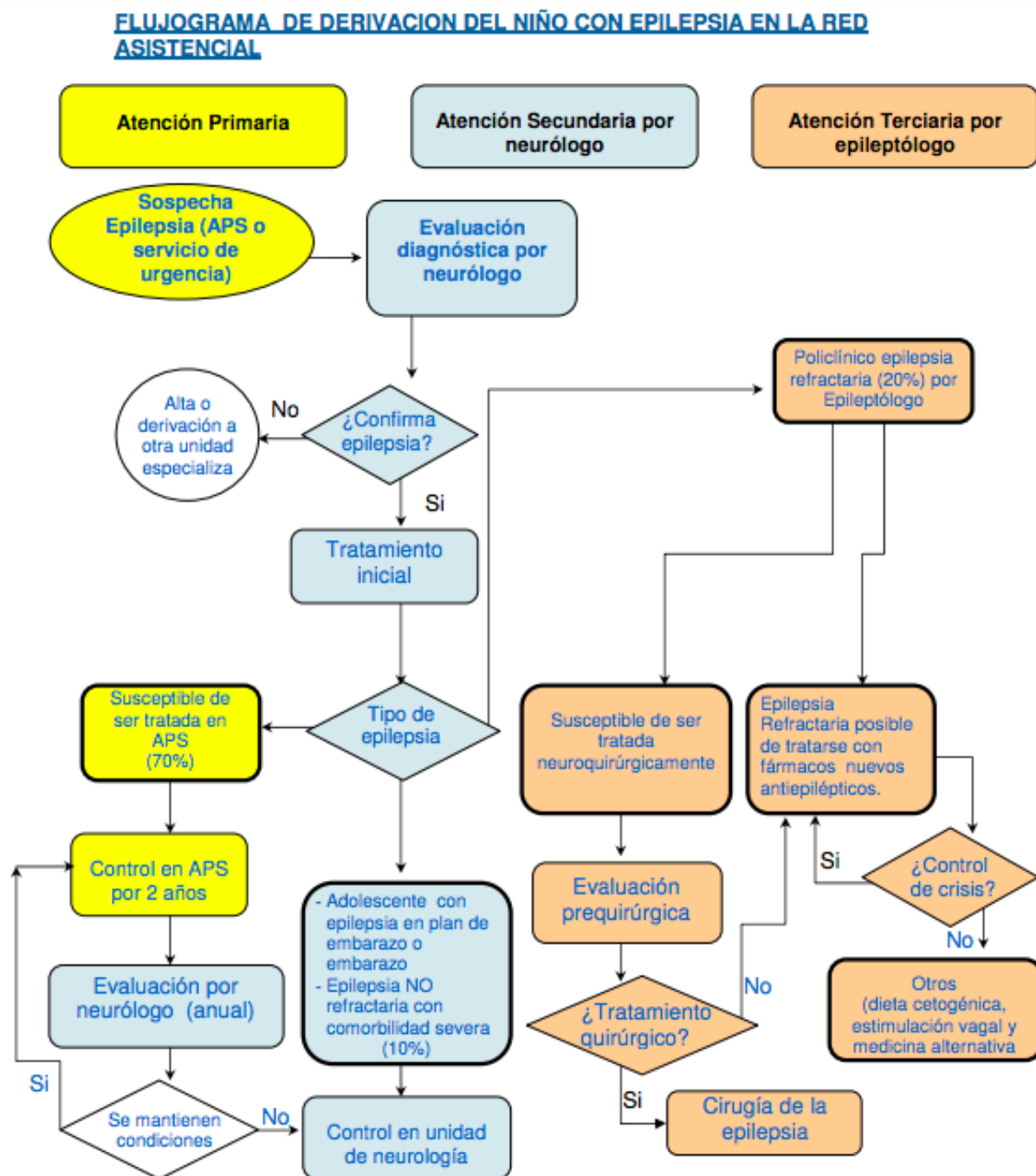
 Indique el nivel de severidad de los siguientes síntomas durante la última semana.

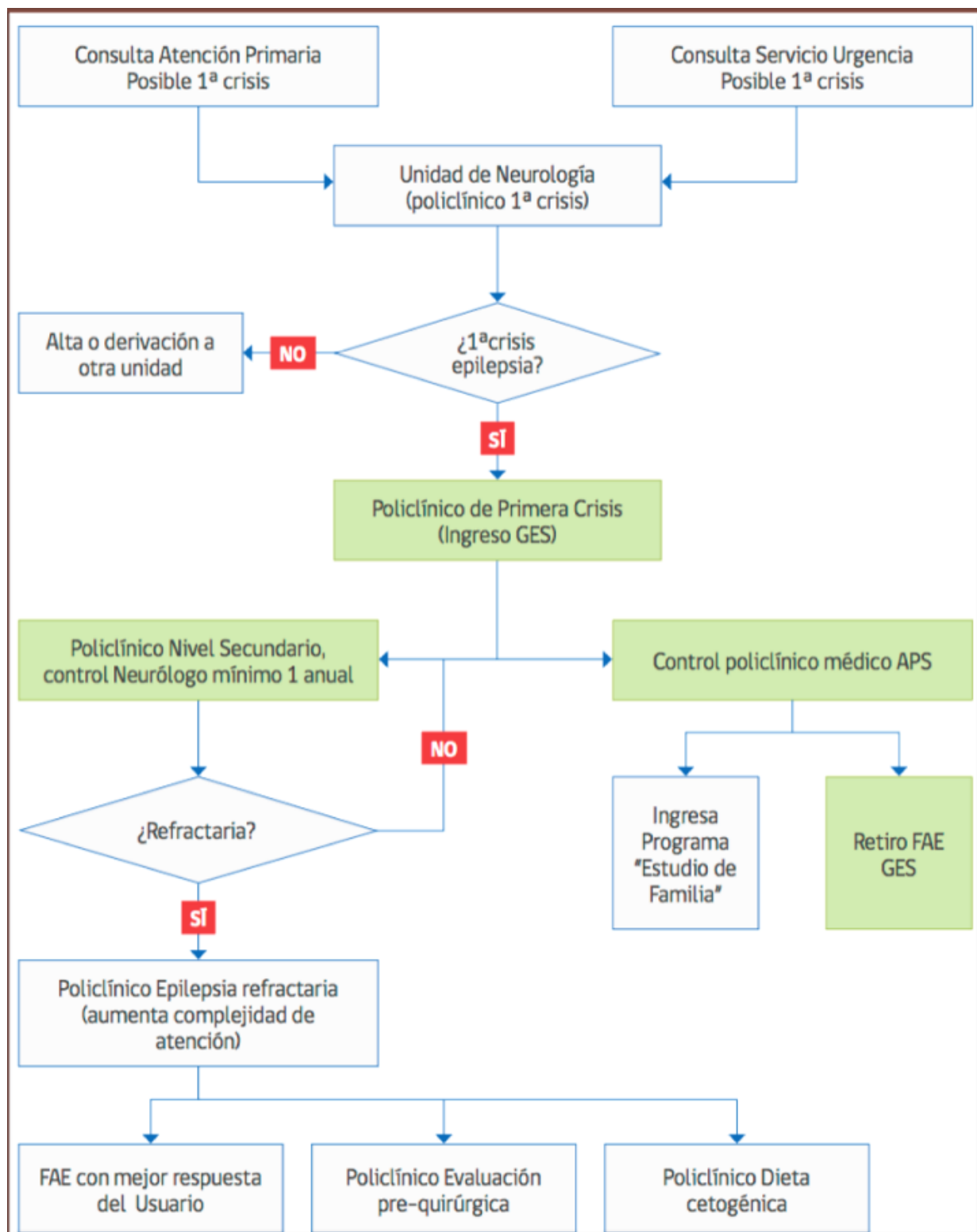
0	Ningún problema
1	De leve a moderado, generalmente intermitente
2	De moderado a considerable, frecuente y de intensidad moderada
3	Severo, persistente, generalizado, con interferencia en las actividades diarias

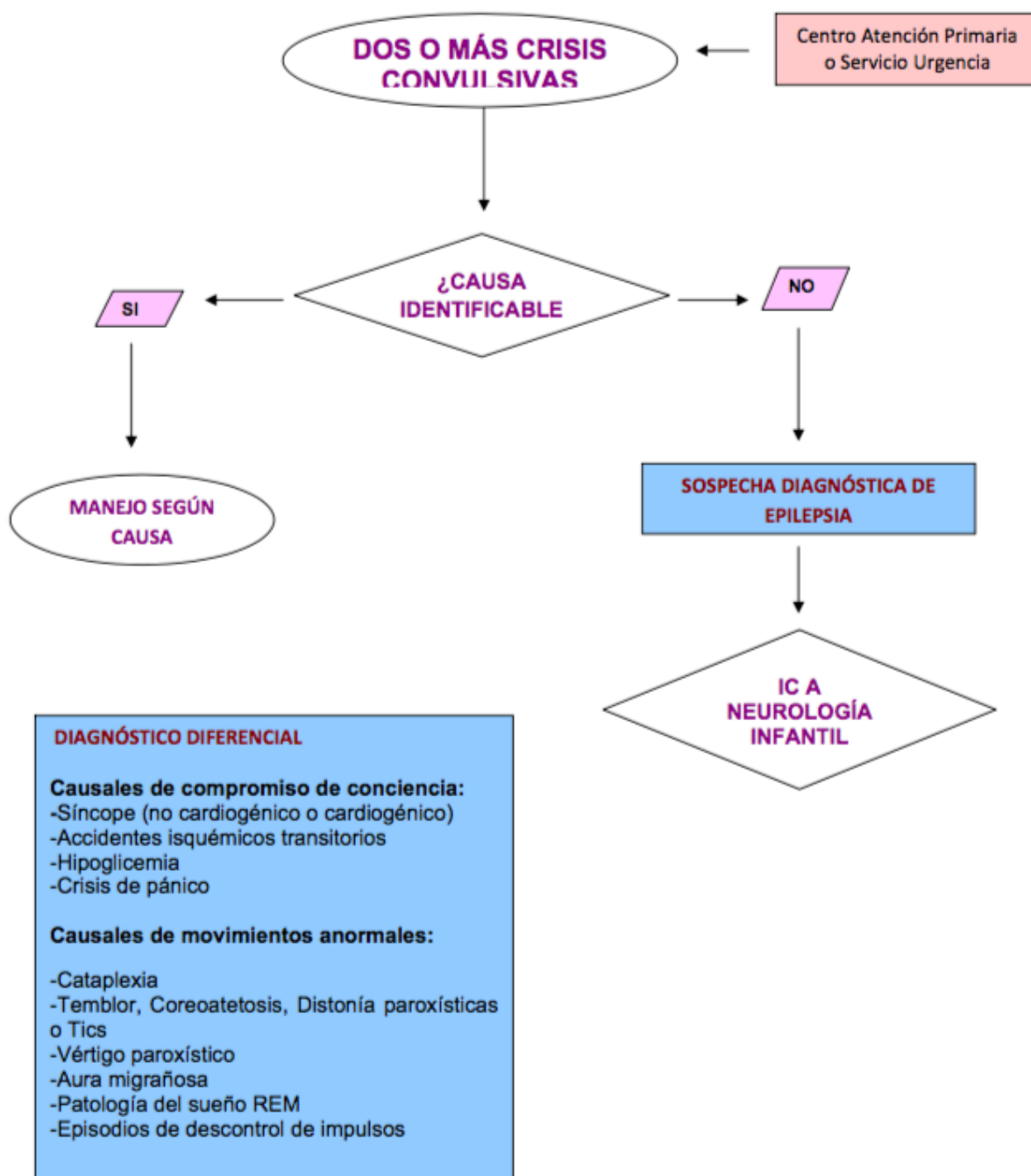
Fatiga	0	1	2	3
Sueño no reparador	0	1	2	3
Trastornos cognitivos	0	1	2	3

Índice Severidad de Síntomas /Symptom Severity Score
SS-2 = 0-3

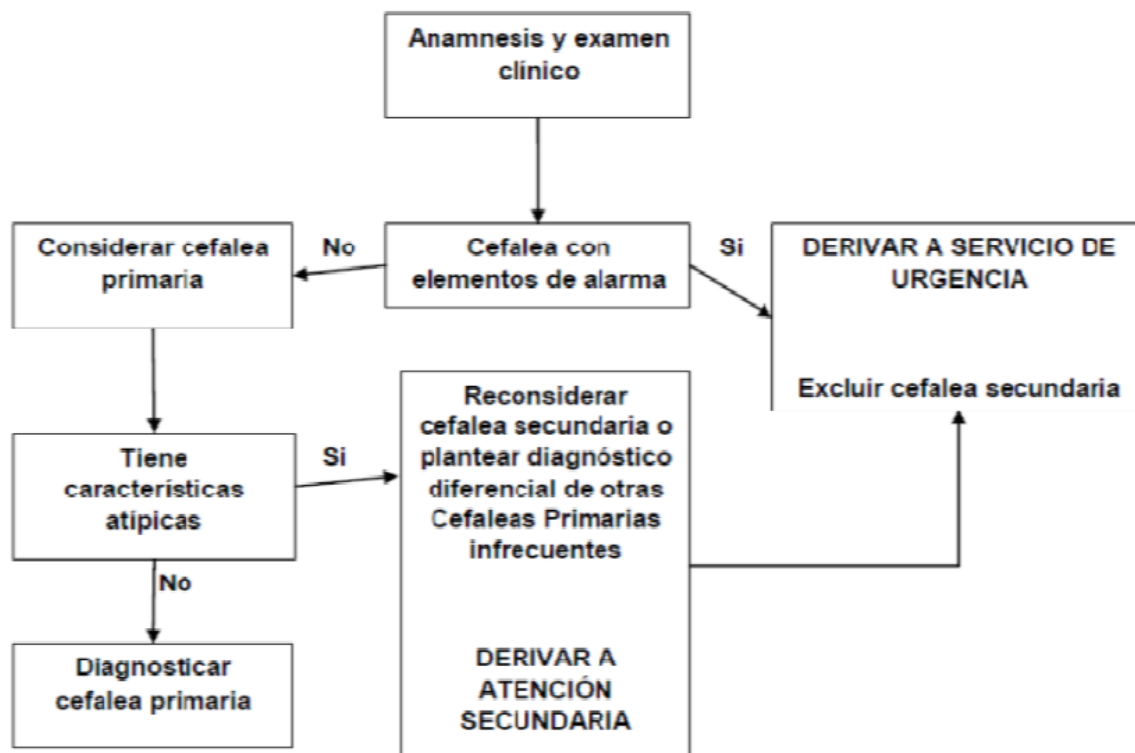
ANEXO N° 8: Flujograma de derivación del niño con epilepsia



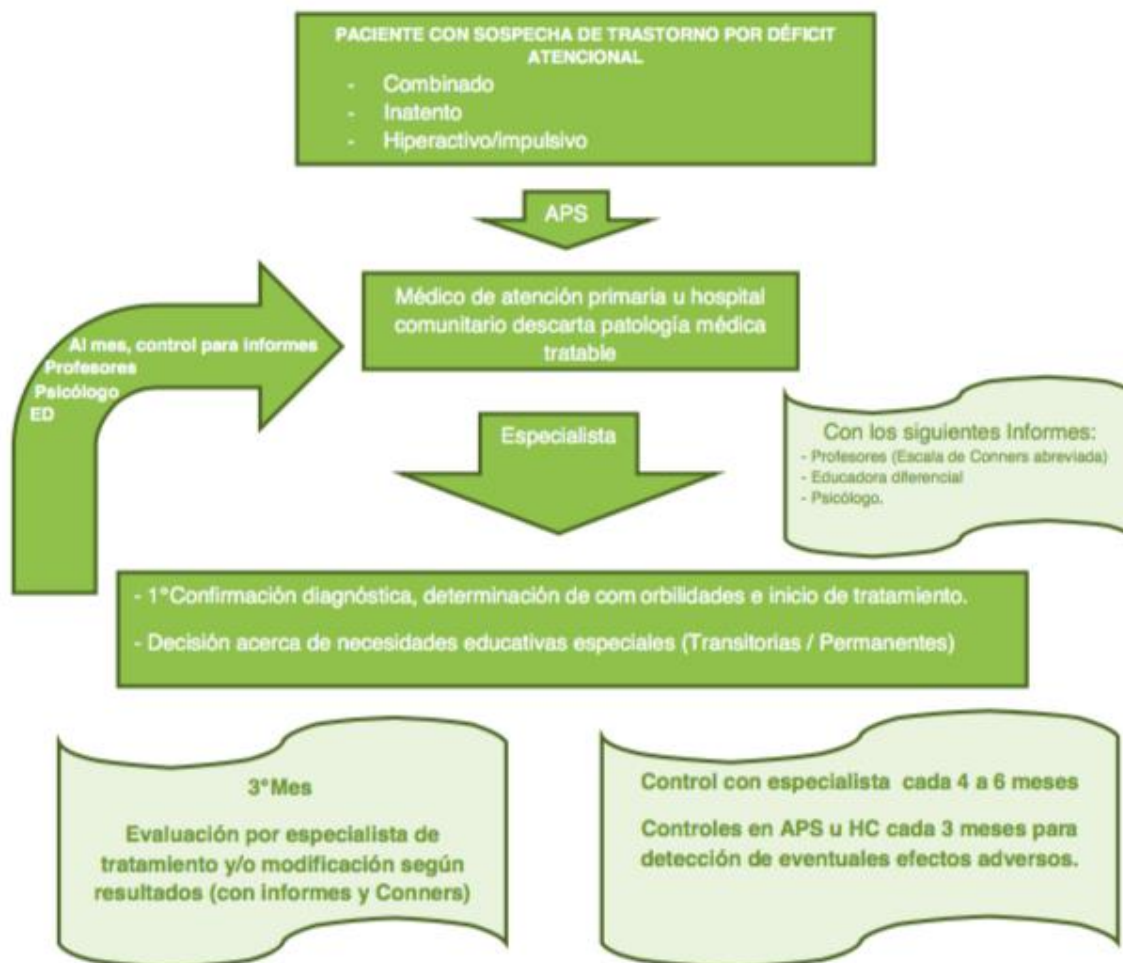




ANEXO N° 9: Flujograma CEFALEAS.

CEFALEA**FLUJOGRAMA**

Flujograma TDAH



ESCALA DE EVALUACIÓN ABREVIADA DE CONNERS PARA PROFESORES

Nombre: _____

Curso: _____

Fecha de evaluación: _____

	NADA	UN POCO	BASTANTE	MUCHO
1) Inquieto, hiperactivo	☐	☐	☐	☐
2) Excitable, impulsivo	☐	☐	☐	☐
3) Perturba a otros niños	☐	☐	☐	☐
4) No termina lo que comienza	☐	☐	☐	☐
5) Constantemente moviéndose en la silla	☐	☐	☐	☐
6) Desatento, fácilmente distráctil.	☐	☐	☐	☐
7) Debe satisfacerse pedidos de inmediato, fácilmente frustrable.	☐	☐	☐	☐
8) Lloro fácil y frecuentemente	☐	☐	☐	☐
9) Cambios de humor rápidos, drásticos	☐	☐	☐	☐
10) Pataleta, conducta explosiva e impredecible	☐	☐	☐	☐

Otras observaciones respecto a su
rendimiento, relación con sus compañeros

Nombre y firma del profesor

Timbre del Colegio

ANEXO N° 10: ESCALAS DE RIESGO TROMBOEMBÓLICO Y DE RIESGO DE SANGRADO

Escala de riesgo tromboembólico CHA2DS2-VASc

C (congestive heart failure)	Historia reciente de insuficiencia cardíaca congestiva	1
H (hypertension)	Historia de hipertensión arterial	1
A (Age)	Edad ≥ 75 años	2
D (Diabetes)	Historia de diabetes mellitus	1
S2 (Stroke)	Historia de ictus/AIT	2
Vascular disease	Enfermedad vascular	1
Age 65-74	Edad 65-74 años	1
Sex female	Sexo femenino	1
Abordaje del riesgo tromboembólico		
CHA2DS2 = 0	No tratar con TACO, uso de aspirina	
CHA2DS2 = 1	TACO o aspirina	
CHA2DS2 ≥ 2	TACO	

Escala de riesgo de sangrado HAS-BLED

H	Hipertensión no controlada, con presión arterial sistólica ≥ 160 mmHg	1
A	Insuficiencia renal (diálisis cr., trasplante renal o creatinina sérica $\geq 2,3$ mg/dl o insuficiencia hepática cirrosis o deterioro hepático BRB > 2 veces el límite superior normal, AST/ALT > 3 veces el límite superior normal)	1 ó 2
S	Historia previa de ictus	1
B	Historia de sangrado, anemia o predisposición al sangrado.	1
L	INR inestable (menos del 60% del tiempo en rango terapéutico)	1
E	Edad ≥ 65 años $\geq$	1
D	Medicamentos que afecten la hemostasia (ej. AAS, Clopidogrel) y/o ingesta ≥ 8 bebidas alcohólicas a la semana	1 ó 2
Puntuación máxima		9
ALTO RIESGO DE SANGRADO CON ≥ 3 PUNTOS		

FORMULARIO DE INGRESO

POLICLÍNICO TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL (TACO)

*Para acceder al Policlínico TACO debe completar la información solicitada.

Nombre del Paciente:		
RUT:	Edad:	Fecha:
Centro desde donde se realiza la derivación:		
Diagnóstico de ingreso al Policlínico TACO (adjuntar epicrisis o derivación médica):		
Puntaje: CHADS2-VASC:		HAS-BLED:

PLAN MÉDICO

1.- Medicamento anticoagulante indicado (por médico):

2.- Dosis administradas (adjuntar si tiene hoja de dosificación o carnet TACO):

3.- Duración de tratamiento:

☐

Permanente

☐

Temporal: Indicar tiempo:

4.- ¿Interconsulta o derivación a especialista para evaluación?. En caso de corresponder, adjuntar documentos de respaldo (Epicrisis, hora, IC ingresada en el sistema).

5. ¿Se inició educación del tratamiento? ☐ SI ☐ NO

6. ¿Se encuentra firmado consentimiento informado y archivado en Ficha Clínica?

☐

SI

☐

NO

NOMBRE Y FRIMA DEL MÉDICO

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR

Arturo Prat N° 969, Temuco - Fono (45) 2556300 www.araucaniasur.cl

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INICIO DE TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE

Sr./Sra. _____ Edad: _____ años. RUT: _____
(Nombre y dos apellidos del paciente)

Sr./Sra. _____ Edad: _____ años. RUT: _____
(Nombre y dos apellidos del representante legal)

En calidad de _____ de _____
(Representante legal o familiar) (Nombre y dos apellidos del paciente)

DECLARO:

Que el /la Doctor/a: _____
Me ha explicado que en mi situación es necesario seguir con un TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTE ORAL.
Conociendo los riesgos y cuidados que este tratamiento implica. CONSIENTO el inicio del TRATAMIENTO.

En el establecimiento de Salud: _____

Firma Paciente y/o Representante Legal: _____

Nombre y Firma del Médico: _____

Día: _____ Mes: _____ del año 20 _____

RECHAZO:

Sr./Sra. _____ Edad: _____ años. RUT: _____
(Nombre y dos apellidos del paciente)

Sr./Sra. _____ Edad: _____ años. RUT: _____
(Nombre y dos apellidos del representante legal)

En calidad de _____ de _____
(Representante legal o familiar) (Nombre y dos apellidos del paciente)

RECHAZO y no acepto el proseguir ante ninguna circunstancia con el TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTE ORAL, asumiendo toda responsabilidad ante cualquier eventualidad de cualquier naturaleza que mi autonomía, soberana e informada decisión pudiera ocasionar.

En el establecimiento de Salud: _____

Firma Paciente y/o Representante Legal: _____

Nombre y Firma del Médico: _____

Día: _____ Mes: _____ del año 20 _____

Anexo N ° 11 Índice de Barthel.

Índice De Barthel

Actividades básicas de la vida diaria

Se puntúa la información obtenida del cuidador principal

Parámetro	Situación del paciente	Puntuación
Comer	- Totalmente independiente	10
	- Necesita ayuda para cortar carne, el pan, etc.	5
	- Dependiente	0
Lavarse	- Independiente: entra y sale solo del baño	5
	- Dependiente	0
Vestirse	- Independiente: capaz de ponerse y de quitarse la ropa, abotonarse, atarse los zapatos	10
	- Necesita ayuda	5
	- Dependiente	0
Arreglarse	- Independiente para lavarse la cara, las manos, peinarse, afeitarse, maquillarse, etc.	5
	- Dependiente	0
Deposiciones (Valórese la semana previa)	- Continencia normal	10
	- Ocasionalmente algún episodio de incontinencia, o necesita ayuda para administrarse supositorios o lavativas	5
	- Incontinencia	0
Micción (Valórese la semana previa)	- Continencia normal, o es capaz de cuidarse de la sonda si tiene una puesta	10
	- Un episodio diario como máximo de incontinencia, o necesita ayuda para cuidar de la sonda	5
	- Incontinencia	0
Usar el retrete	- Independiente para ir al cuarto de aseo, quitarse y ponerse la ropa...	10
	- Necesita ayuda para ir al retrete, pero se limpia solo	5
	- Dependiente	0
Trasladarse	- Independiente para ir del sillón a la cama	15
	- Mínima ayuda física o supervisión para hacerlo	10
	- Necesita gran ayuda, pero es capaz de mantenerse sentado solo	5
Deambular	- Dependiente	0
	- Independiente, camina solo 50 metros	15
	- Necesita ayuda física o supervisión para caminar 50 metros	10
Escalones	- Independiente en silla de ruedas sin ayuda	5
	- Dependiente	0
	- Independiente para bajar y subir escaleras	10
	- Necesita ayuda física o supervisión para hacerlo	5
	- Dependiente	0
Total		

Máxima puntuación: 100 puntos (90 si va en silla de ruedas)	
Resultado	Grado de dependencia
< 20	Total
20-35	Severo
40-55	Moderado
≥ 60	Leve
100	Independiente

Anexo N° 12: Formulario derivación Geriatría, Hospital Digital

Datos del Paciente

Fecha Nacimiento:	Seleccione una fecha	Tipo de Documento:	☐ Rut ☒ Pasaporte/DNI
Numero Documento:	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	Nombre:	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Apellido Paterno:	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	Apellido Materno:	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Sexo:	Elija un elemento.	Teléfono:	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Previsión:	Elija un elemento.	Email:	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Tipo de Consulta:	☒ Nueva ☐ Control		
¿Paciente cuenta con cuidador?	☐ Si ☒ No	Tipo de Cuidado:	Elija un elemento.
¿Paciente vive solo?	☐ Si ☒ No	La persona con quien vive es:	Elija un elemento.
Ingrese los años de estudio del paciente:	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		

¿Tiene alergias a algún medicamento?	☐ Si ☒ No	Tipo de Reacción:	Elija un elemento.
		Detalle Alergia:	

Interconsulta

I. Prioridad de la Interconsulta:	Elija un elemento.
¿Qué tipo de ayuda requiere de parte del equipo de Geriatría?	☐ Polifarmacia. ☐ Multimorbilidad. ☐ Disminución de más de 15 puntos del Barthel en 1 año. ☐ Acompañamiento en GES 85. ☐ Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Realice una descripción del caso:	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Diagnóstico:	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Hipótesis Diagnóstica:	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Exámen Físico

Peso	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	Talla	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
IMC			
Presión Arterial	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	
Ingrese Información Adicional:			

Comorbilidades

Diabetes:		Elija un elemento.	
Hipertensión Arterial:		☐ Si ☒ No	
Dislipidemia:		☒ Si ☐ No	
Cáncer:	☐ Si ☒ No	Localización Cáncer:	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Otras Comorbilidades:	☐ Si ☒ No	Describir otras Comorbilidades:	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Hábitos

Síndrome Geriátrico

Tabaco:	Elija un elemento.	Paquetes de cigarrillos (20 unidades) fumados al día	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Cantidad de años que paciente ha fumado:	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
¿El paciente realiza Actividad Física?	Elija un elemento.
Alcohol:	Elija un elemento.

Nota importante: Todos los campos de este apartado son campos requeridos.

Caídas:	☐ Si ☐ No ☒ No Sabe			
Incontinencia Urinaria:	☒ Si ☐ No ☐ No Sabe	Tipo Incontinencia:	Elija un elemento.	
Alteración Visual:	☒ Si ☐ No ☐ No Sabe			
Alteración Auditiva:	☐ Si ☐ No ☐ No Sabe			
¿Paciente utiliza alguna Órtesis?	☐ Si ☒ No	Escriba que Órtesis usa el Paciente.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	
Demencia:	☐ Si ☐ No ☒ No Sabe	Seleccione tipo de Demencia:	Elija un elemento.	Año diagnóstico: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Depresión:	☐ Si ☐ No ☐ No Sabe	Año diagnóstico:	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	
Deterioro Cognitivo (No Demencia)	☐ Si ☐ No ☐ No Sabe			
Inmovilidad:	☐ Si ☐ No ☐ No Sabe			

¿Presenta Baja de Peso Involuntaria?	☐ Si ☐ No ☐ No Sabe		
Fragilidad (Escala Visual):	Elija un elemento.		

Fármacos

Medicamentos que usa el Paciente:	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		
Adherencia:	☐ Si ☐ No ☒ No Sabe		
¿Recibe ayuda para manejar sus medicamentos? (Confección pastillero, compra medicamentos, etc)	☐ Si ☒ No ☐ No Sabe		

Exámenes

Importante: La plataforma solicitara los exámenes que se listaran a continuación, es de vital importancia adjuntar la mayor cantidad de Exámenes posible.

Recuerde: si posee los exámenes en formato digital el medico puede adjuntarlos en la plataforma.

Recuerde: que en la plataforma el examen **función renal** cuenta con un campo obligatorio y si no lo completa no podrá generar la solicitud de IC.

Hemograma				Perfil Bioquímico	
Hb g/dL	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.			Albúmina mg/dL	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Hcto %	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.			LDH UI/l	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

¿Paciente es Afroamericano? *Campo Requerido		☐ Si ☒ No	
Creatininemia mg/dL		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	
Estandarizada (IDMS)		☐ Si ☒ No	
VfGe mL/min/1.73 m2		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	
Razón Proteinuria/Creatininuria (RPC) mg/gr		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	
Bun mEq/L		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	
Pruebas Hepáticas		Pruebas Tiroideas	
Bilirrubina Total mg/dl	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	TSH uUI/mL	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
SGOT U/L	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	T4 Libre uUI/mL	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
GPT U/L	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	T4 uUI/mL	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
GGT U/L	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		
Fosfatasas Alcalinas U/L	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		
Otros Exámenes			

	Na mEq/L	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	VRDL ó RPR	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	
	Cl mEq/L	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	VIH	☐ Si ☐ No	
	K mEq/L	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	Niveles Vitamina D ng/mL	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	
	Niveles de B12 ng/mL	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	HbA1c %	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	

Importante: Para una mejor valoración la plataforma solicita las escalas más utilizadas en geriatría y que procederemos a listar a continuación.

Recuerde: Si usted no posee alguno de estos test la plataforma los pondrá a su disposición.

Pruebas Funcionales					
	Escala Barthel		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		
	Test Pfeffer		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		
	Escala Lawton y Brody		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		
Pruebas Cognitivas					
			Puntaje		
	Minimental Abreviado		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		

	Minimental Modificado		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.				
	Test AD8		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.				
	Test MIS		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.				
	Test MOCA		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.				
	Test de fluencia verbal semántica		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.				
	Pruebas del Ánimo						
			Puntaje				
	Test Yesavage		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.				
	Test Cornell		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.				
	Evaluación de Deterioro Global						
			Puntaje				
	Escala Reisberg		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.				